
RECOMMANDER
LES BONNES PRATIQUES

RECOMMANDATION

**Coordination entre
protection de
l'enfance et
psychiatrie de
l'enfant et de
l'adolescent**

Validé par le Collège le 30 avril 2025

Les recommandations de bonnes pratiques sont définies comme des propositions développées méthodiquement pour aider les professionnels à mettre en place les soins et accompagnements les plus appropriés en fonction des circonstances.

Cette recommandation de bonne pratique a été élaborée selon une méthode adaptée des méthodes « Recommandations pour la pratique clinique (RPC) » et « Recommandations de bonnes pratiques professionnelles pour le secteur social et médico-social » disponibles sur le site de la HAS.

La méthode utilisée est résumée dans le rapport d'élaboration téléchargeable sur www.has-sante.fr.

Les données de la littérature identifiées dans le cadre de ce travail n'ont pas permis d'établir de grade pour les recommandations (absence d'étude ou insuffisance des niveaux de preuve scientifique des études). En conséquence, toutes les recommandations reposent sur un accord d'experts au sein du groupe de travail, tenant compte de l'avis du groupe de lecture et des parties prenantes sollicitées.

Grade des recommandations

A	Preuve scientifique établie Fondée sur des études de fort niveau de preuve (niveau de preuve 1) : essais comparatifs randomisés de forte puissance et sans biais majeur ou méta-analyse d'essais comparatifs randomisés, analyse de décision basée sur des études bien menées.
B	Présomption scientifique Fondée sur une présomption scientifique fournie par des études de niveau intermédiaire de preuve (niveau de preuve 2), comme des essais comparatifs randomisés de faible puissance, des études comparatives non randomisées bien menées, des études de cohorte.
C	Faible niveau de preuve Fondée sur des études de moindre niveau de preuve, comme des études cas-témoins (niveau de preuve 3), des études rétrospectives, des séries de cas, des études comparatives comportant des biais importants (niveau de preuve 4).
AE	Accord d'experts En l'absence d'études, les recommandations sont fondées sur un accord entre experts du groupe de travail, après consultation du groupe de lecture. L'absence de gradation ne signifie pas que les recommandations ne sont pas pertinentes et utiles. Elle doit, en revanche, inciter à engager des études complémentaires.

Descriptif de la publication

Titre	Coordination entre protection de l'enfance et psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent
Méthode de travail	Adaptée des méthodes « Recommandations pour la pratique clinique (RPC) » et « Recommandations de bonnes pratiques professionnelles pour le secteur social et médico-social »
Objectif(s)	– Repérer le plus tôt possible les besoins de soins en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent chez les enfants protégés – Faciliter l'accès aux soins en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent dès lors qu'un besoin est repéré chez un enfant protégé – Permettre à chaque enfant protégé concerné de bénéficier d'un suivi approprié, aussi longtemps que nécessaire, en veillant à éviter les ruptures
Cibles concernées	Ce travail concerne l'ensemble des bébés, enfants et adolescents accompagnés par l'aide sociale à l'enfance (ASE) ou la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) susceptibles de bénéficier d'une évaluation, éventuellement suivie de soins, par les structures de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Il s'adresse principalement aux professionnels des champs de la protection de l'enfance et de la psychiatrie.
Demandeur	Auto-saisine
Promoteur(s)	Haute Autorité de santé (HAS)
Pilotage du projet	Coordination : Mme Amélie Prigent, cheffe de projet, service des bonnes pratiques (chef de service : Dr Pierre Gabach, puis Dr Morgane Le Bail), direction de l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins (DAQSS), HAS Mme Manon Praca, cheffe de projet, service recommandations (cheffe de service : Mme Manuela Cheviot), direction de la qualité de l'accompagnement social et médico-social (DIQASM), HAS Assistante de projet : Mme Nagette Jousse
Recherche documentaire	De janvier 2010 à mars 2025 (cf. stratégie de recherche documentaire décrite en annexe 2 du rapport d'élaboration) Réalisée par Mme Virginie Henry, avec l'aide de Mme Laurence Frigère (cheffe du service documentation – veille : Mme Frédérique Pagès)
Auteurs	Amélie Prigent, Manon Praca, Matthias Brunn (partie « Freins et leviers à la coordination entre protection de l'enfance et psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent » du rapport d'élaboration) et Nicolas Campelo (partie « Modalités et dispositifs de coordination entre protection de l'enfance et psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent » du rapport d'élaboration)
Conflits d'intérêts	Les membres du groupe de travail ont communiqué leurs déclarations publiques d'intérêts à la HAS. Elles sont consultables sur le site https://dpi.sante.gouv.fr . Elles ont été analysées selon la grille d'analyse du guide des déclarations d'intérêts et de gestion des conflits d'intérêts de la HAS. Pour son analyse, la HAS a également pris en compte la base « Transparence-Santé » qui impose aux industriels du secteur de la santé de rendre publics les conventions, les rémunérations et les avantages les liant aux acteurs du secteur de la santé. Les intérêts déclarés par les membres du groupe de travail et les

	informations figurant dans la base « Transparence-Santé » ont été considérés comme étant compatibles avec la participation des experts au groupe de travail.
Validation	Version du 30 avril 2025
Actualisation	
Autres formats	

Ce document ainsi que sa référence bibliographique sont téléchargeables sur www.has-sante.fr 

Haute Autorité de santé – Service communication information
5, avenue du Stade de France – 93218 SAINT-DENIS LA PLAINE CEDEX. Tél. : +33 (0)1 55 93 70 00
© Haute Autorité de santé – avril 2025 – ISBN : 978-2-11-172733-5

Sommaire

Introduction	7
Repères juridiques	15
Préambule	24
1. Repérage et orientation vers la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent (PE)	29
1.1. Repérage (PE)	29
1.2. Orientation vers les soins en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent (PE)	34
2. Accès aux soins en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent (PE & PSY)	37
2.1. Interlocuteur « protection de l'enfance » identifié au sein de la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent (PSY)	37
2.2. Choix du secteur de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent le plus adapté (PSY)	39
2.3. Autres modalités facilitant l'accès aux soins psychiatriques pour les enfants ayant une mesure de protection de l'enfance (PE & PSY)	40
3. Cohérence et continuité des soins et des accompagnements (PE & PSY)	42
3.1. 1 ^{re} consultation psychiatrique (PE & PSY)	42
3.2. Référents du parcours de l'enfant (PE & PSY)	46
3.3. Association de la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent aux décisions concernant le parcours de l'enfant en protection de l'enfance (PE & PSY)	48
3.4. Transmission d'informations de la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à la protection de l'enfance (PSY)	51
4. Recours aux urgences et hospitalisation à temps plein en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent (PE & PSY)	52
4.1. Recours aux urgences pour des symptômes évocateurs d'un trouble psychique/TND (PE, PSY et autres acteurs)	52
4.2. Hospitalisation à temps plein en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent : continuité dans et avec les lieux d'accueil (PE & PSY)	57
5. Association des enfants protégés et de leurs parents (PE & PSY)	59
6. Coordination avec d'autres acteurs impliqués dans le parcours d'accompagnement et de soins (PE, PSY & autres acteurs)	64
6.1. Coordination avec la médecine générale et la pédiatrie (PE, PSY & autres acteurs)	64
6.2. Coordination avec le champ médico-social pour les enfants ayant (ou ayant besoin d') un accompagnement en lien avec des troubles psychiques/TND (PE & PSY)	67
6.3. Coordination avec la psychiatrie de l'adulte (PE, PSY & autres acteurs)	69
7. Co-construction d'un cadre collaboratif global entre protection de l'enfance et psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et acculturation réciproque (PE & PSY)	70

7.1. Formalisation d'objectifs partagés et de modalités de coordination au niveau de chaque territoire (PE & PSY)	70
7.2. Espaces pluripartenariaux de décision dédiés aux situations individuelles complexes (PE & PSY)	72
7.3. Espaces visant à favoriser l'interconnaissance et l'acculturation réciproque entre professionnels, hors traitement des situations individuelles (PE & PSY)	74
7.4. Formation (PE & PSY)	75
Table des annexes	79
Références bibliographiques	88
Participants	91
Abréviations et acronymes	97

Introduction

La recommandation de bonnes pratiques « Coordination entre protection de l'enfance et psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent » est une auto-saisine de la HAS. Elle fait partie des travaux réalisés dans le cadre de son programme pluriannuel relatif à la santé mentale et à la psychiatrie 2018-2023 (1).

Contexte et enjeux

En France, « la protection de l'enfance vise à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l'enfant, à soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social et à préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation, dans le respect de ses droits¹ ».

Cette politique décentralisée met en œuvre :

- des actions de prévention en faveur de l'enfant et de ses parents ;
- le repérage et le traitement des situations de danger ou de risque de danger pour l'enfant ;
- des mesures administratives (prises par le président du conseil départemental) et judiciaires, civiles ou pénales (prises par le juge des enfants ou en cas d'urgence par le procureur de la République).

Au 31 décembre 2022, le nombre de mineurs pris en charge en protection de l'enfance, toutes prestations et mesures confondues, a été estimé à 310 577 (décisions administratives ou judiciaires ; mesures d'accompagnement en milieu ouvert ou d'accueil) en France métropolitaine et départements et régions d'outre-mer (DROM), hors Mayotte, ce qui représentait un taux de 21,9 ‰ des mineurs. Le nombre de jeunes majeurs concernés était lui estimé à 34 105, ce qui représentait 13,8 ‰ des jeunes âgés de 18 à 21 ans (2). On comptait environ 81 705 jeunes suivis dans un cadre pénal par les services de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) en 2021 (3).

Des conséquences en termes de développement et de santé physique et psychique

Les maltraitances (incluant violences et négligences) ont des effets sur le développement et la santé physique et psychique des enfants qui en sont victimes.

Les enfants ayant une mesure de protection de l'enfance présentent notamment un risque plus important de souffrir de troubles tels que des troubles des conduites, des troubles anxieux et dépressifs, des troubles déficits de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) et des troubles de stress post-traumatique (4-8), la prévalence des troubles mentaux ayant globalement été estimée comme étant près de quatre fois supérieure à celle observée en population générale (9)².

¹ Article L. 112-3 du code de l'action sociale et des familles.

² Tout en considérant ces résultats avec prudence, notamment en raison des disparités d'utilisation des classifications diagnostiques, la prévalence des troubles psychiques dans la population concernée a pu être estimée à 49 % dans le cadre d'une méta-analyse incluant 3 014 enfants protégés. La prévalence entre études variait toutefois entre 37 % et 67 % et une forte hétérogénéité était identifiée.

Point de repère

Au sens de l'article L. 119-1 du code de l'action sociale et des familles, « la maltraitance [...] vise toute personne en situation de vulnérabilité³ lorsqu'un geste, une parole, une action ou un défaut d'action compromet ou porte atteinte à son développement, à ses droits, à ses besoins fondamentaux ou à sa santé et que cette atteinte intervient dans une relation de confiance, de dépendance, de soin ou d'accompagnement. Les situations de maltraitance peuvent être ponctuelles ou durables, intentionnelles ou non. Leur origine peut être individuelle, collective ou institutionnelle. Les violences et les négligences peuvent revêtir des formes multiples et associées au sein de ces situations ».

De potentiels effets iatrogènes de la mesure de protection de l'enfance

Par ailleurs, la mesure de protection de l'enfance, en particulier en cas de placement, est susceptible d'avoir des effets iatrogènes⁴ sur l'enfant et d'engendrer des souffrances psychiques, notamment en lien avec les risques relatifs (11) :

- aux aléas et incertitudes des parcours en protection de l'enfance (périodes de prises de décision, fins de mesure par exemple), potentiellement insécurisants pour l'enfant ;
- à la souffrance liée à la séparation, même avec une figure d'attachement maltraitante.

Peuvent parfois s'ajouter, pour certains enfants, des souffrances psychiques liées à des maltraitances intervenues sur leur lieu d'accueil.

Des difficultés dans l'accès aux soins en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et dans les parcours de soins et de vie

Malgré les besoins de ce public, l'accès aux soins en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent est particulièrement difficile pour les enfants ayant une mesure de protection de l'enfance.

Le bilan de santé et de prévention, créé par la loi de 2016 et devenu obligatoire dès le début de la mesure de protection de l'enfance en 2020, était décrit en 2021 comme n'étant pas encore réalisé dans tous les départements mais progressant dans son déploiement (12). En outre, ce bilan doit intégrer un volet relatif à la santé psychique, mais les départements interrogés par l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS) en 2020 indiquaient que « le volet psychologique [était] le volet le moins mis en œuvre » (13).

La Cour des comptes a par ailleurs indiqué que les psychologues présents dans les structures rempliraient le plus souvent une fonction auprès des équipes éducatives, visant à leur apporter des clés de compréhension sur les situations, et non une fonction thérapeutique auprès des enfants (14).

³ La démarche nationale de consensus pour un vocabulaire partagé de la maltraitance des personnes en situation de vulnérabilité, qui a permis l'élaboration de la définition partagée de la maltraitance intégrée ensuite dans le code de l'action sociale et des familles et citée ici, a également précisé la notion de personne en situation de vulnérabilité : « La vulnérabilité est liée à des facteurs individuels et/ou des facteurs environnementaux. Eu égard à la maltraitance, une personne se sent ou est en situation de vulnérabilité lorsqu'elle se trouve en difficulté voire impossibilité de se défendre ou de faire cesser une maltraitance à son égard ou de faire valoir ses droits du fait de son âge (dans le cas d'un mineur), de son état de santé, d'une situation de handicap, d'un environnement inadapté ou violent, d'une situation de précarité ou d'une relation d'emprise. Des facteurs individuels relatifs au genre, à l'orientation sexuelle, à la race, l'ethnie ou à la nationalité peuvent constituer un risque accru de vulnérabilité. » (10)

⁴ « Sur le modèle de sa signification en médecine, où "iatrogénie se dit d'une pathogénie d'origine médicale ou médicamenteuse", le terme "iatrogène" qualifie les besoins induits par la prise en charge elle-même, ses aléas, ses modalités et conditions de mise en œuvre, voire de sa non-mise en œuvre bien qu'une alerte ait pu être effectuée. Il couvre également les aléas rencontrés par l'enfant, non seulement au cours d'un accueil ou autre prise en charge, mais aussi éventuellement dans son parcours institutionnel incluant les temps de décision le concernant. » (11)

L'accès aux soins en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent a également été décrit comme se faisant trop souvent en situation d'urgence, ce qui peut s'expliquer par :

- des délais d'accès trop importants à des consultations en centres médico-psychologiques (CMP) et en centres médico-psycho-pédagogiques (CMPP) (15, 16) ;
- une absence de clarification ou des désaccords sur le secteur de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent devant prendre en charge l'enfant, pouvant parfois conduire à ce qu'aucun secteur de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent n'assure le suivi d'un enfant :
 - quand les secteurs de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent dont relèvent le lieu d'accueil de l'enfant et le (ou les) domicile(s) des parents diffèrent,
 - ou quand un déménagement d'un (ou des) parent(s) ou un changement de lieu d'accueil de l'enfant implique un changement de secteur de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent ;
- des recours parfois tardifs à la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent par les acteurs de la protection de l'enfance, quand les troubles psychiques/troubles du neurodéveloppement (TND) s'accompagnent de manifestations comportementales bruyantes et nécessitent une intervention urgente⁵ ;
- une réticence, voire une opposition parfois de l'enfant et/ou des parents à recourir aux soins en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, pouvant être liée à des représentations négatives, à de la stigmatisation ou à une incompréhension sur l'objectif poursuivi.

Parallèlement, la continuité des parcours de soins en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent peut être mise à mal par différents facteurs, parmi lesquels les changements fréquents de lieux d'accueil et de vie, qui peuvent également engendrer des difficultés pour les professionnels à reconstituer les parcours de vie des enfants ayant une mesure de protection de l'enfance. Des changements de lieu d'accueil peuvent par ailleurs entraîner des difficultés lorsqu'ils concordent avec une hospitalisation à temps plein en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, certains enfants ne pouvant pas sortir d'hospitalisation faute de nouveau lieu d'accueil.

Au-delà de la continuité des soins en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, la coordination des soins somatiques et psychiques apparaît également insuffisante, avec une nécessité d'améliorer les liens entre protection de l'enfance, psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et médecine générale et pédiatrie notamment.

Une coordination encore insuffisante entre protection de l'enfance et psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent

Dans ce contexte, alors que la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant et de ses vulnérabilités nécessite de penser une approche transversale, à la fois sociale et sanitaire, les services de protection de l'enfance et de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent interviennent encore trop souvent de façon cloisonnée (18-20). Sont notamment évoquées des difficultés liées à :

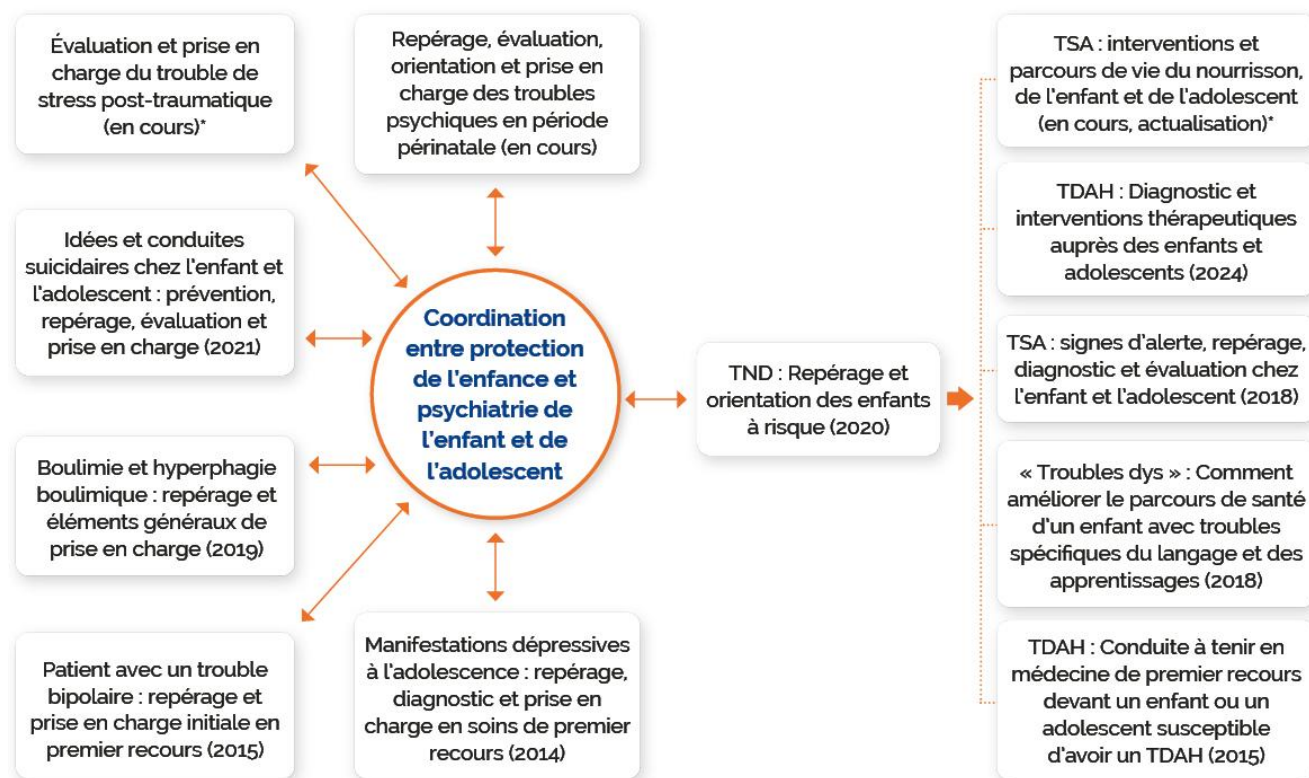
- une insuffisance en termes d'échange et de partage d'informations, dans les deux sens ;
- des différences d'approches dans l'accompagnement et la prise en charge des enfants entre et au sein des deux secteurs ;
- une méconnaissance réciproque des professionnels.

⁵ Une étude française a notamment montré que les adolescents suivis par l'ASE et/ou la PJJ consultaient moins en CMP et davantage en structures d'urgence que les adolescents non suivis par la protection de l'enfance (17).

Demande

Cette recommandation de bonnes pratiques centrée sur les coordinations, sans entrée par types de troubles, est une auto-saisine de la HAS qui se situe en complémentarité d'autres recommandations, notamment cliniques, publiées ou en cours d'élaboration. Le cadrage de certaines recommandations cliniques en cours d'élaboration prévoit qu'elles abordent la question des enfants ayant une mesure de protection de l'enfance*.

Complémentarité avec les recommandations cliniques et parcours de soins du champ de la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent



Complémentarité avec les recommandations du champ de la protection de l'enfance

Ce travail est également complémentaire aux recommandations HAS, publiées ou en cours d'élaboration, concernant le champ de la protection de l'enfance, parmi lesquelles :

- L'évaluation globale de la situation de l'enfant en cours de mesure de protection de l'enfance (en cours) ;
- Améliorer la prise en charge à la sortie des dispositifs de protection de l'enfance – Volet 2 : l'accès à l'autonomie (2024) ;
- Cadre de référence pour l'évaluation globale de la situation des enfants en danger/risque de danger (2021) ;
- L'accompagnement des mineurs non accompagnés (MNA) dits « mineurs isolés étrangers » (2018) ;
- Prendre en compte la santé des mineurs/jeunes majeurs dans le cadre des établissements/services de la protection de l'enfance et/ou mettant en œuvre des mesures éducatives (2015) ;
- L'expression et la participation du mineur, de ses parents et du jeune majeur dans le champ de la protection de l'enfance (2014) ;
- L'exercice de l'autorité parentale dans le cadre du placement (2012).

Objectifs de la recommandation

La recommandation vise à répondre à trois objectifs :

- repérer le plus tôt possible les besoins de soins en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent chez les enfants protégés ;
- faciliter l'accès aux soins en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent dès lors qu'un besoin est repéré chez un enfant protégé ;
- permettre à chaque enfant protégé concerné de bénéficier d'un suivi approprié, aussi longtemps que nécessaire, en veillant à éviter les ruptures.

Acteurs concernés par la recommandation

Les enfants protégés et leur entourage

Les critères d'âge selon lesquels sont définis les publics varient entre les services de protection de l'enfance et les structures de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Ce travail concerne l'ensemble des bébés, enfants et adolescents accompagnés par l'aide sociale à l'enfance (ASE) ou la PJJ susceptibles de nécessiter une démarche d'évaluation, de diagnostic et de soins en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent.

Ainsi, la recommandation concerne :

- tous les enfants accompagnés par l'ASE ou la PJJ (secteur public ou associatif) dans le cadre d'une mesure administrative ou judiciaire (civile ou pénale) de protection de l'enfance (accompagnement en milieu ouvert ou accueil) ;
- les parents ou autres titulaires de l'autorité parentale et les personnes ressources dans l'environnement des enfants (pouvant intégrer des membres de la fratrie) ;
- les associations d'usagers et de familles d'usagers.

Par souci de lisibilité, dans la suite de cette recommandation :

- la terminologie « enfants » désigne l'ensemble des bébés, enfants et adolescents ;
- la terminologie « parents » renvoie aux parents (sous réserve qu'ils soient titulaires de l'autorité parentale) ou aux autres titulaires de l'autorité parentale le cas échéant, qu'ils exercent l'autorité parentale de façon totale ou partielle.

Les professionnels du champ de la protection de l'enfance et du champ sanitaire

Cette recommandation, ciblant la coordination entre protection de l'enfance et psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, s'adresse principalement aux professionnels des champs de la protection de l'enfance et de la psychiatrie, notamment :

- aux professionnels des établissements et services autorisés ASE et/ou PJJ (travailleurs sociaux, acteurs de santé, cadres, etc.), assistants familiaux, professionnels en charge du parcours des enfants, acteurs de santé (médecins [dont médecins référents protection de l'enfance], psychologues, infirmiers) et cadres intervenant au sein des services de l'ASE et de la PJJ, magistrats du siège (juges des enfants, juges aux affaires familiales), magistrats du parquet, avocats d'enfants, administrateurs *ad hoc* ;
- aux professionnels des services de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent des établissements ayant une autorisation d'activité en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent (psychiatres de l'enfant et de l'adolescent, psychologues, cadres de santé, infirmiers, éducateurs,

assistants de service social, psychomotriciens et orthophonistes) et des CMPP⁶, aux directeurs et personnels administratifs des établissements de santé, ainsi qu'aux psychiatres libéraux et aux professionnels de psychiatrie de l'adulte.

Dans la suite de cette recommandation, la terminologie « **structures de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent** » inclut à la fois les établissements ayant une autorisation d'activité en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et leurs services (en ambulatoire [CMP notamment], d'hospitalisation à temps partiel et d'hospitalisation à temps complet [dont l'hospitalisation à temps plein]) et les CMPP.

Le recours à la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent s'inscrivant dans le cadre d'un parcours de soins global pour les enfants ayant une mesure de protection de l'enfance, la recommandation concerne également les acteurs de santé susceptibles d'intervenir en amont, simultanément ou en aval d'un recours à la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, avec lesquels une coordination est aussi indispensable, en particulier : les pédiatres, les médecins généralistes, les médecins et infirmiers de la protection maternelle et infantile (PMI), les psychologues libéraux, les personnels soignants des urgences générales et pédiatriques, les autres personnels exerçant en périnatalité (personnels de maternité, sages-femmes libérales, etc.), les professionnels exerçant au sein des maisons des adolescents (MDA), les professionnels des unités d'accueil pédiatriques enfants en danger (UAPED), les psychomotriciens libéraux, les orthophonistes libéraux et les acteurs de santé de l'Éducation nationale.

Elle intéresse par ailleurs les acteurs chargés d'organiser la coordination aux différents échelons territoriaux, notamment au sein des conseils départementaux, des agences régionales de santé (ARS) (incluant les délégués territoriaux), des directions interrégionales (DIR) et territoriales (DT) de la PJJ ainsi qu'au niveau national.

Délimitation du thème

État des lieux des pratiques de coordination en France et à l'étranger

Dans le cadre de ce travail, préalablement à l'élaboration de la recommandation de bonnes pratiques, un état des lieux des pratiques de coordination entre protection de l'enfance et psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent en France et à l'étranger a été réalisé. Disponible dans le [rapport d'élaboration de ces recommandations](#), il inclut une description des freins et leviers à la coordination et des modalités et dispositifs de coordination ayant été identifiés.

De nombreux dispositifs visant à favoriser la coordination entre protection de l'enfance et psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent ont été identifiés, dans la littérature et par le biais de remontées de terrain⁷ (dispositifs de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent dédiés aux enfants ayant une mesure de protection de l'enfance, équipes mobiles de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, interventions de professionnels de psychiatrie au sein de structures de protection de l'enfance, dispositifs dits mixtes ou partagés, etc.), une hétérogénéité étant observée entre territoires.

Les données actuellement disponibles ne permettent pas de recommander le développement d'un dispositif plutôt qu'un autre sur l'ensemble du territoire.

⁶ Bien qu'ils relèvent du champ médico-social, les CMPP ont été intégrés au champ de la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, dans la mesure où ils proposent des soins souvent proches de ceux proposés au sein des CMP, qui relèvent du champ sanitaire (21).

⁷ Appel à contributions et expériences des membres du groupe de travail ayant élaboré ces recommandations.

Questions abordées dans la recommandation de bonnes pratiques

La recommandation de bonnes pratiques aborde les questions suivantes :

- modalités de repérage et d'orientation vers la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent pour les enfants ayant une mesure de protection de l'enfance ;
- modalités d'accès aux soins psychiatriques pour les enfants ayant une mesure de protection de l'enfance (incluant la question du secteur de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent devant assurer le suivi d'un enfant quand le secteur de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent correspondant à son lieu d'accueil est différent de celui du domicile [voire des domiciles] de ses parents/titulaires de l'autorité parentale) ;
- modalités favorisant la cohérence et la continuité des soins en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et des accompagnements en protection de l'enfance quand une évaluation/un suivi en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent est mis(e) en place ;
- réponses pouvant être apportées en situation d'urgence ;
- modalités favorisant la continuité dans et avec les lieux d'accueil lors d'une hospitalisation à temps plein en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent ;
- modalités d'association des enfants protégés et de leurs parents ;
- modalités de coordination avec la médecine générale, la pédiatrie libérale, la psychiatrie de l'adulte et les acteurs du champ médico-social ;
- modalités de co-construction d'un cadre collaboratif global entre protection de l'enfance et psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent ;
- leviers mobilisables en termes de formation et espaces de rencontre permettant de favoriser une acculturation réciproque entre les deux champs.

Les modalités d'échange et de partage d'informations entre professionnels sont abordées de façon transversale à ces questions, de même que les spécificités attachées à l'accompagnement/la prise en charge des mineurs non accompagnés (MNA) et à celui/celle des enfants en situations considérées comme complexes.

Cette recommandation a été élaborée dans une logique d'amélioration et d'harmonisation des pratiques, tout en veillant à prendre en compte la diversité des contextes locaux.

Champs exclus

Ce travail est centré sur la coordination entre protection de l'enfance et psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Tel que mentionné précédemment, de nombreux autres acteurs interviennent toutefois dans l'accompagnement des enfants protégés (médecins généralistes, pédiatres, acteurs du champ médico-social, de l'Éducation nationale, etc.).

Les articulations avec certains de ces acteurs font l'objet d'un chapitre dédié (« Coordination avec d'autres acteurs impliqués dans le parcours d'accompagnement et de soins ») au sein duquel elles ne sont que partiellement abordées, sous l'angle de la coordination tripartite en lien avec des troubles psychiques/TND, impliquant à la fois la protection de l'enfance et la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent.

Les spécificités de la coordination entre les acteurs du champ médico-social et la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent ainsi que celles de la coordination entre les acteurs du champ médico-social et de la protection de l'enfance pourraient faire l'objet de travaux dédiés permettant de les aborder dans leur globalité.

Par ailleurs, ce travail n'aborde pas :

- les situations d'enfants ne bénéficiant pas d'une mesure de protection (enfants pour lesquels un danger/risque de danger a été repéré mais n'ayant pas encore de mesure de protection) ;
- la question de la continuité de la prise en charge entre services de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et services de psychiatrie de l'adulte, cette question faisant l'objet d'un travail inscrit au programme « santé mentale et psychiatrie » de la HAS ;
- les aspects cliniques de la prise en charge (stratégies thérapeutiques, éléments d'évaluation diagnostique, etc.), dans la mesure où il s'agit d'une recommandation de bonnes pratiques centrée sur la coordination entre les acteurs (incluant les enjeux d'acculturation réciproque), sans entrée par types de troubles.

Les recommandations HAS spécifiques à la prévention, au repérage, à l'évaluation et à la prise en charge de certains troubles, consultables sur le site internet de la HAS ou en cours d'élaboration, sont listées page 10 et en annexe 1.

Repères juridiques

Autorité parentale, intérêt de l'enfant et décisions relatives à sa santé

Cadre général concernant l'autorité parentale et l'intérêt supérieur de l'enfant

Autorité parentale

Article 371-1 du code civil

« L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.

Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques.

Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »

Intérêt de l'enfant

Article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant

« Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. »

Article L. 112-4 du code de l'action sociale et des familles

« L'intérêt de l'enfant, la prise en compte de ses besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs ainsi que le respect de ses droits doivent guider toutes décisions le concernant. »

Actes usuels et non usuels

Selon le cadre juridique relatif à l'autorité parentale, les actes usuels sont ceux qui peuvent être réalisés par un seul parent car le consentement de l'autre est présumé. Les actes non usuels impliquent en revanche « l'accord exprès des deux titulaires de l'autorité parentale ».

La notion d'acte usuel n'est pas définie par la loi, mais des éléments de précision sont apportés par la jurisprudence.

Les tribunaux considèrent l'acte usuel comme celui qui s'inscrit dans la continuité du passé et qui n'engage pas l'avenir de l'enfant, un acte de la vie quotidienne sans gravité⁸.

Quant à l'acte non usuel, autrement qualifié d'acte important, c'est celui qui « rompt avec le passé et engage l'avenir de l'enfant ou qui touche à ses droits fondamentaux⁹ ».

Cadre général concernant les décisions relatives à la santé de l'enfant

Les titulaires de l'autorité parentale ou le tuteur reçoivent les informations sur l'état de santé de l'enfant et sur son suivi : différentes investigations menées, traitements ou actions de prévention proposés (incluant leur utilité, leur niveau d'urgence éventuel, leurs conséquences, les risques fréquents et/ou

⁸ Le 28 octobre 2011, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a défini les actes usuels comme « des actes de la vie quotidienne, sans gravité, qui n'engagent pas l'avenir de l'enfant, qui ne donnent pas lieu à une appréciation de principe essentielle et ne présentent aucun risque grave apparent pour l'enfant, ou encore, même s'ils revêtent un caractère important, des actes s'inscrivant dans une pratique antérieure non contestée [...] ».

⁹ Rapport n° 1925, enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 7 mai 2014, fait sur la proposition de loi n° 1856 du 1^{er} avril 2014 relative à l'autorité parentale et à l'intérêt de l'enfant (22).

graves normalement prévisibles qu'ils comportent), autres solutions possibles, conséquences prévisibles en cas de refus¹⁰.

Un médecin appelé à donner des soins à un mineur doit s'efforcer de prévenir ses parents ou son représentant légal et d'obtenir leur consentement.

Par ailleurs, les mineurs ont le droit de recevoir eux-mêmes les informations sur leur santé, d'une manière adaptée à leur degré de maturité.

S'ils sont aptes à exprimer leur volonté et à participer à la décision, leur consentement doit être systématiquement recherché¹¹.

En cas d'urgence, le médecin doit donner les soins nécessaires¹².

Si les soins et examens envisagés sont usuels, ils peuvent être délivrés avec l'autorisation d'un seul des deux titulaires de l'autorité parentale. Les deux parents sont solidairement engagés.

Les soins non usuels requièrent en revanche l'accord des deux titulaires de l'autorité parentale. L'accord des deux parents doit être exprès ou, en tout cas, clairement établi.

Lorsqu'il est amené à trancher un conflit relatif à l'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales doit en première analyse faire prévaloir l'intérêt supérieur de l'enfant et ce, quel que puisse être celui de l'un ou l'autre des parents¹³.

Le médecin doit être le défenseur de l'enfant lorsqu'il estime que l'intérêt de sa santé est mal compris ou mal préservé par son entourage¹⁴.

Exception au cadre général en matière d'autorité parentale

Par dérogation aux règles générales en matière d'autorité parentale, le médecin peut se dispenser d'obtenir le consentement des titulaires de cette autorité, en cas d'opposition expresse du mineur dans les cas où il souhaite garder le secret sur son état de santé.

Ainsi, l'article L. 1111-5 du code de la santé publique¹⁵ permet au mineur d'exiger du médecin qu'il ne dise rien de son état de santé ou taise un point particulier à ses parents. Le législateur n'a pas fait de distinction concernant l'âge des mineurs. Le praticien devra en conséquence identifier les mineurs ayant suffisamment de maturité et de discernement pour tenir les titulaires de l'autorité parentale dans l'ignorance des soins et traitements prodigués à leurs enfants mineurs. En tout état de cause, le médecin devra s'efforcer de convaincre le mineur de se faire accompagner par ses parents.

Par ailleurs, afin de garder le secret sur son état de santé, l'article L. 1111-13-1 du code de la santé publique prévoit qu'un mineur peut s'opposer à la saisie dans son espace numérique de santé de toute donnée relative à sa prise en charge.

¹⁰ Article L. 1111-2 du code de la santé publique.

¹¹ Articles L. 1111-2 et L. 1111-4 du code de la santé publique.

¹² Article R. 4127-42 du code de la santé publique.

¹³ Cass. 1^{re} civ., 15 mars 2017, n° 16-24.055.

¹⁴ Article R. 4127-43 du code de la santé publique.

¹⁵ « Par dérogation à l'article 371-1 du code civil, le médecin ou la sage-femme peut se dispenser d'obtenir le consentement du ou des titulaires de l'autorité parentale sur les décisions médicales à prendre lorsque l'action de prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement ou l'intervention s'impose pour sauvegarder la santé d'une personne mineure, dans le cas où cette dernière s'oppose expressément à la consultation du ou des titulaires de l'autorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé. Toutefois, le médecin ou la sage-femme doit dans un premier temps s'efforcer d'obtenir le consentement du mineur à cette consultation. Dans le cas où le mineur maintient son opposition, le médecin ou la sage-femme peut mettre en œuvre l'action de prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement ou l'intervention. Dans ce cas, le mineur se fait accompagner d'une personne majeure de son choix.

Lorsqu'une personne mineure, dont les liens de famille sont rompus, bénéficie à titre personnel du remboursement des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité et de la couverture complémentaire mise en place par la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, son seul consentement est requis. »

Cadre relatif aux enfants confiés à l'ASE

Exercice des actes relevant de l'autorité parentale : actes usuels et non usuels et santé de l'enfant confié

L'article 373-4 du code civil prévoit que « lorsque l'enfant a été confié à un tiers, l'autorité parentale continue d'être exercée par les père et mère ; toutefois, la personne à qui l'enfant a été confié accomplit tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation [...] ».

Lorsqu'un enfant pris en charge par le service de l'ASE est confié à une personne physique (assistant familial) ou morale (établissement ou service) :

- le service départemental de l'ASE, puisqu'il assure la prise en charge de l'enfant, et notamment son hébergement, par l'intermédiaire d'une personne physique ou morale, est amené à exercer les actes usuels de l'autorité parentale relatifs à l'éducation et à la surveillance de l'enfant, c'est-à-dire les actes du quotidien de l'enfant qui n'engagent pas son avenir ;
- le service doit ainsi assurer l'éducation et la surveillance de l'enfant tout en veillant à ce que les parents puissent, dans la mesure du possible, être associés à l'ensemble des décisions prises pour lui. Cela signifie que le service départemental de l'ASE :
 - peut effectuer seul les actes usuels, sous réserve d'en informer les parents,
 - ne peut pas effectuer seul les actes non usuels, pour lesquels il doit recueillir l'autorisation du ou des titulaires de l'autorité parentale.

L'article L. 223-1-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que « lorsque l'enfant pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance est confié à une personne physique ou morale, une liste des actes usuels de l'autorité parentale que cette personne ne peut pas accomplir au nom de ce service sans lui en référer préalablement est annexée au projet pour l'enfant. Le projet pour l'enfant définit les conditions dans lesquelles les titulaires de l'autorité parentale sont informés de l'exercice des actes usuels de l'autorité parentale¹⁶ ».

La direction générale de la Cohésion sociale (DGCS) a publié en 2018 un guide qui propose de considérer la mise en place d'un traitement médical comme un acte non usuel pour lequel il est nécessaire de demander l'autorisation des parents, par opposition à la poursuite d'un traitement récurrent, à des soins courants et au suivi médical, qui seraient des actes usuels que l'ASE peut décider seule de réaliser en informant les parents (23).

Possibilité pour la personne/le service à laquelle/auquel l'enfant est confié de demander au juge des enfants l'autorisation de consentir à des soins relevant de l'autorité parentale

Article 375-7 du code civil

« Les père et mère de l'enfant bénéficiant d'une mesure d'assistance éducative continuent à exercer tous les attributs de l'autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure. [...] »

Sans préjudice de l'article 373-4 et des dispositions particulières autorisant un tiers à accomplir un acte non usuel sans l'accord des détenteurs de l'autorité parentale, le juge des enfants peut exceptionnellement, dans tous les cas où l'intérêt de l'enfant le justifie, autoriser la personne, le service ou l'établissement à qui est confié l'enfant à exercer un ou plusieurs actes déterminés relevant de l'autorité parentale en cas de refus abusif ou injustifié ou en cas de négligence des détenteurs de l'autorité parentale ou lorsque ceux-ci sont poursuivis ou condamnés, même non définitivement, pour des crimes ou délits commis sur la personne de l'enfant, à charge pour le demandeur de rapporter la preuve de la nécessité de cette mesure. »

¹⁶ Cf. également article D. 223-17 du code de l'action sociale et des familles.

Droit des personnes accompagnées par un établissement ou service social ou médico-social à participer à la définition et à la mise en œuvre de leur accompagnement

Article L. 311-3 du code de l'action sociale et des familles

« L'exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne accueillie et accompagnée par des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Lui sont assurés :

[...] 3° Une prise en charge et un accompagnement individualisé de qualité favorisant son développement, son autonomie et son insertion, adaptés à son âge et à ses besoins, respectant son consentement éclairé qui doit systématiquement être recherché lorsque la personne est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. À défaut, le consentement de son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, de la personne chargée de cette mesure, qui tient compte de l'avis de la personne protégée, doit être recherché ;

[...] 7° La participation directe de la personne prise en charge à la conception et à la mise en œuvre du projet d'accueil et d'accompagnement qui la concerne. Cette personne bénéficie de l'aide de son représentant légal, s'il s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique à la personne qui n'est pas apte à exprimer sa volonté, de la personne chargée de cette mesure, qui tient compte de son avis. »

Hospitalisation d'un mineur

L'article L. 3211-1 du code de la santé publique prévoit qu'« une personne ne peut sans son consentement ou, le cas échéant, sans l'autorisation de son représentant légal, si elle est mineure, ou celle de la personne chargée de la protection, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, faire l'objet de soins psychiatriques, hormis les cas prévus par les chapitres II à IV du présent titre et ceux prévus à l'article 706-135 du code de procédure pénale ».

En règle générale, un mineur est admis en hospitalisation en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à la demande des titulaires de l'autorité parentale. L'hospitalisation est dans ce cas considérée comme relevant de soins dits libres même si elle n'est pas demandée par l'enfant ou l'adolescent mineur.

Par ailleurs, un mineur peut notamment être admis en hospitalisation en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent selon les deux modalités suivantes :

- admission dans le cadre de mesures d'assistance éducative ordonnées par la justice¹⁷, sur la base de l'article 375-9 du code civil : si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier à un service ou à un établissement sanitaire¹⁸. Lorsque, dans ce cadre, il est décidé de confier le mineur « à un établissement recevant des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux », la décision est ordonnée « après avis médical circonstancié d'un médecin extérieur à l'établissement, pour une durée ne pouvant excéder quinze jours ». « La mesure peut être renouvelée, après avis médical conforme d'un psychiatre de l'établissement d'accueil, pour une durée d'un mois renouvelable¹⁹ » ;
- admission en soins sur décision du représentant de l'État (SDRE), lorsque les troubles mentaux présentés par le mineur « nécessitent des soins et compromettent la sûreté des

¹⁷ Article 375 du code civil.

¹⁸ Article 375-3 du code civil.

¹⁹ Article 375-9 du code civil.

personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public²⁰ ». Cette modalité d'admission s'inscrit dans le cadre des soins sans consentement.

Dans le cadre de SDRE, le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, notamment par la personne faisant l'objet des soins, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate de la mesure²¹. Un enfant ou un adolescent peut par ailleurs contacter lui-même le Défenseur des droits s'il estime que ses droits ne sont pas respectés ou qu'une situation met en cause son intérêt.

En lien avec l'hospitalisation des mineurs, l'article R. 1112-36 du code de la santé publique, non spécifique à l'hospitalisation à temps plein en psychiatrie, prévoit par ailleurs que : « Lorsque le malade relève d'un service départemental de l'aide sociale à l'enfance, le directeur adresse sous pli cacheté dans les quarante-huit heures de l'admission au service médical de l'aide à l'enfance le certificat confidentiel du médecin chef de service indiquant le diagnostic et la durée probable de l'hospitalisation. »

Cadre relatif au « module santé » pour les jeunes ayant une mesure PJJ

Article L. 112-2 du code de la justice pénale des mineurs

« La mesure éducative judiciaire consiste en un accompagnement individualisé du mineur construit à partir d'une évaluation de sa situation personnelle, familiale, sanitaire et sociale. La juridiction peut également prononcer un ou plusieurs modules, interdictions ou obligations suivants :

[...] 3° Un module de santé [...]. »

Article L. 112-11 du code de la justice pénale des mineurs

« Le module de santé peut consister en :

- 1° Une orientation du mineur vers une prise en charge sanitaire adaptée à ses besoins ;
- 2° Un placement dans un établissement de santé, à l'exclusion des services de psychiatrie ;
- 3° Un placement dans un établissement médico-social. »

²⁰ Article L. 3213-1 du code de la santé publique.

²¹ Article L. 3211-12 du code de la santé publique.

Échange et partage d'informations entre professionnels²²

L'échange²³ et le partage²⁴ d'informations entre professionnels des champs sanitaire et social sont abordés à la fois dans le cadre :

- de l'article L. 1110-4 (et R. 1110-1 et suivants) du code de la santé publique ;
- de l'article L. 226-2-2 du code de l'action sociale et des familles.

Le cadre et les conditions dans lesquels l'échange et le partage d'informations sont possibles diffèrent dans les articles des deux codes : finalité, professionnels concernés, périmètre des informations échangées ou partagées et obligations en termes d'information (y compris sur le droit éventuel d'opposition) et de recueil éventuel du consentement des parents (ou autre personne titulaire de l'autorité parentale/représentant légal) et de l'enfant (Tableau 1).

Tableau 1. Cadre et conditions dans lesquels l'échange et le partage d'informations sont possibles dans les articles L. 1110-4 et R. 1110-1 et suivants du code de la santé publique et dans l'article L. 226-2-2 du code de l'action sociale et des familles

	Articles L. 1110-4 et R. 1110-1 et suivants du code de la santé publique	Article L. 226-2-2 du code de l'action sociale et des familles
Finalité de l'échange ou du partage d'informations	Échange d'informations : coordination ou continuité des soins, prévention ou suivi médico-social et social. Partage d'informations : coordination ou continuité des soins ou suivi médico-social et social.	Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de protection de l'enfance définie à l'article L. 112-3 : évaluation d'une situation individuelle, détermination et mise en œuvre des actions de protection et d'aide dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier.
Professionnels concernés et périmètre des	Professionnels participant à la prise en charge d'une même personne listés à l'article R. 1110-2 du code de la santé publique ²⁵	Personnes soumises au secret professionnel qui mettent en œuvre la politique de protection

²² Les dispositions relatives à l'échange et au partage d'informations synthétisées dans cette partie s'appliquent sans préjudice de deux autres dispositifs autorisant ou imposant une transmission d'informations :

- le régime des signalements adressés à l'autorité administrative ou judiciaire en cas de suspicion de maltraitances, de privations ou de sévices contre un mineur (article 226-14 du code pénal et article R. 4127-44 du code de la santé publique) ;
- le dispositif de recueil des informations préoccupantes dans le cadre des cellules départementales de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes (CRIP) prévu par l'article L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles.

²³ L'échange d'informations consiste, pour un professionnel émetteur, à communiquer des informations nécessaires à un ou plusieurs destinataires qui sont identifiés (24).

²⁴ Le partage consiste à mettre à disposition de plusieurs professionnels, sur une base informatisée de dossiers, les informations relatives à une même personne prise en charge qui leur sont nécessaires pour assurer leurs missions (24).

²⁵ Article R. 1110-2 du code de la santé publique : « Les professionnels susceptibles d'échanger ou de partager des informations relatives à la même personne prise en charge appartiennent aux deux catégories suivantes :

1° Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, quel que soit leur mode d'exercice ;

2° Les professionnels relevant des sous-catégories suivantes :

- a) Assistants de service social mentionnés à l'article L. 411-1 du code de l'action sociale et des familles ;
- b) Ostéopathes, chiropracteurs, psychologues et psychothérapeutes non professionnels de santé par ailleurs, aides médico-psychologiques et accompagnants éducatifs et sociaux ;
- c) Assistants maternels et assistants familiaux mentionnés au titre II du livre IV du code de l'action sociale et des familles ;
- d) Educateurs et aides familiaux, personnels pédagogiques occasionnels des accueils collectifs de mineurs, permanents des lieux de vie mentionnés au titre III du livre IV du même code ;
- e) Particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées mentionnés au titre IV du livre IV du même code ;
- f) Mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales mentionnés au titre VII du livre IV du même code ;
- g) Non-professionnels de santé salariés des établissements et services et lieux de vie et d'accueil mentionnés aux articles L. 312-1, L. 321-1 et L. 322-1 du même code, ou y exerçant à titre libéral en vertu d'une convention ;
- h) (Abrogé) ;

informations échangées/partagées	(incluant notamment les professionnels de santé, les psychologues, les assistants de service social, les accompagnants éducatifs et sociaux et les assistants familiaux). Échange ou partage des informations relatives à une même personne prise en charge dans la double limite : 1° Des seules informations strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention, ou au suivi médico-social et social de ladite personne ; 2° Du périmètre de leurs missions.	de l'enfance définie à l'article L. 112-3 ou qui lui apportent leur concours. Partage des informations relatives à une situation individuelle strictement limité à ce qui est nécessaire à l'accomplissement de la mission de protection de l'enfance.
Information et consentement des parents (ou autre personne titulaire de l'autorité parentale/représentant légal) et de l'enfant	Échange d'informations : information préalable de la personne concernée (ou du représentant légal) : – de la nature des informations devant faire l'objet de l'échange ; – soit de l'identité du destinataire et de la catégorie dont il relève, soit de sa qualité au sein d'une structure précisément définie ; – de son droit d'exercer une opposition à l'échange et au partage d'informations la concernant. Partage d'informations (hors équipe de soins²⁶) : recueil du consentement de la personne²⁷ (ou du représentant légal) après information sur : – les catégories d'informations ayant vocation à être partagées ; – les catégories de professionnels fondés à en connaître ; – la nature des supports utilisés pour les partager et les mesures prises pour	Information préalable du père, de la mère, de toute autre personne exerçant l'autorité parentale, du tuteur, de l'enfant en fonction de son âge et de sa maturité, selon des modalités adaptées, sauf si cette information est contraire à l'intérêt de l'enfant.

i) Non-professionnels de santé membres de l'équipe médico-sociale compétente pour l'instruction des demandes d'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée aux articles L. 232-3 et L. 232-6 du même code, ou contribuant à cette instruction en vertu d'une convention.

j) Personnels des dispositifs d'appui à la coordination des parcours de santé complexes mentionnés à l'article L. 6327-1, des dispositifs spécifiques régionaux mentionnés à l'article L. 6327-6 et des dispositifs d'appui mentionnés au II de l'article 23 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé intervenant dans le cadre de leur mission de coordination du parcours de santé de la personne concernée et spécialement habilités par les représentants légaux de ces dispositifs ;

k) Étudiants en troisième cycle mentionnés aux articles R. 6153-1, R. 6153-2 et R. 6153-93 du présent code. »

²⁶ L'article L. 1110-12 du code de la santé publique définit l'équipe de soins notamment comme « un ensemble de professionnels qui participent directement au profit d'un même patient à la réalisation d'un acte diagnostique, thérapeutique, de compensation du handicap, de soulagement de la douleur ou de prévention de perte d'autonomie, ou aux actions nécessaires à la coordination de plusieurs de ces actes, et qui :

1° Soit exercent dans le même établissement de santé, au sein du service de santé des armées, dans le même établissement ou service social ou médico-social mentionné au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans le cadre d'une structure de coopération, d'exercice partagé ou de coordination sanitaire ou médico-sociale figurant sur une liste fixée par décret ;

2° Soit se sont vu reconnaître la qualité de membre de l'équipe de soins par le patient qui s'adresse à eux pour la réalisation des consultations et des actes prescrits par un médecin auquel il a confié sa prise en charge ;

3° Soit exercent dans un ensemble, comprenant au moins un professionnel de santé, présentant une organisation formalisée et des pratiques conformes à un cahier des charges fixé par un arrêté du ministre chargé de la Santé ».

²⁷ L'information préalable de la personne est attestée par la remise à celle-ci, par le professionnel qui a recueilli le consentement, d'un support écrit reprenant cette information (article D. 1110-3-2 du code de la santé publique). Le consentement est valable tant qu'il n'a pas été retiré et est strictement limité à la durée de la prise en charge de la personne, qui peut nécessiter une ou plusieurs interventions successives du professionnel (article D. 1110-3-3 du code de la santé publique).

préserver leur sécurité, notamment les restrictions d'accès.

Partage d'informations au sein d'une même équipe de soins : les informations sont réputées confiées par la personne à l'ensemble de l'équipe, seule une information préalable sur le partage est nécessaire.

Créé par la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance, l'article L. 226-2-2 du code de l'action sociale et des familles pose ainsi un cadre spécifique assoupli permettant un partage d'informations entre professionnels concernant les enfants susceptibles d'être en danger/risque de danger ou bénéficiant d'une mesure de protection de l'enfance dans un cadre administratif ou en assistance éducative dans un cadre judiciaire²⁸, sans possibilité pour les titulaires de l'autorité parentale de s'y opposer.

L'absence de nécessité du consentement des représentants légaux à ce partage d'informations entre professionnels (une information seule étant suffisante) a été confirmée par un arrêt du 8 juin 2021 de la Cour de cassation²⁹.

Au regard des éléments mentionnés ci-avant et sous réserve d'une évolution de la jurisprudence, il est proposé d'appliquer les principes généraux suivants à la présente recommandation, relative à la coordination entre protection de l'enfance et psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent pour les enfants ayant une mesure de protection³⁰.

Dans un cadre administratif et en assistance éducative dans un cadre judiciaire :

- Les échanges et partages d'informations dont il est fait mention dans la recommandation s'inscrivant principalement dans le cadre institutionnel de la protection de l'enfance, ils sont majoritairement considérés comme relevant de l'article L. 226-2-2 du code de l'action sociale et des familles. Ce dernier s'applique en effet lorsque l'échange ou le partage d'informations poursuit les finalités de la protection de l'enfance et a également pour objet direct d'« évaluer une situation individuelle, [de] déterminer ou mettre en œuvre les actions de protection et d'aide ».

Sont par exemple concernés les échanges ou partages d'informations évoqués dans les recommandations R16, R28, R34 et R52, illustrés en annexe 2, qui doivent donc avoir lieu selon les conditions prévues par l'article L. 226-2-2 du code de l'action sociale et des familles (en termes de professionnels concernés, de périmètre des informations échangées/partagées, et d'information des parents et de l'enfant [cf. ci-avant]).

- Lorsque la finalité de l'échange ou du partage d'informations concerne les soins de l'enfant protégé et leur coordination de manière générale, sans lien direct avec la mesure de protection dont il fait l'objet et sans qu'il s'agisse de l'évaluer, de la déterminer ou de la mettre en œuvre, alors les échanges entre les professionnels relèvent de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique et doivent avoir lieu selon les conditions qu'il prévoit.

La recommandation R53, dédiée aux liens entre médecins généralistes/pédiatres/médecins de PMI et professionnels de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, aborde des échanges et partages d'informations susceptibles d'entrer dans ce cas de figure. Certains des échanges et partages d'informations étant recommandés en R53 peuvent toutefois relever

²⁸ Lorsque la PJJ intervient sur le fondement du code de la justice pénale des mineurs (contrôle judiciaire, mesure éducative judiciaire provisoire [MEJP], sursis probatoire, etc.), son action ne s'inscrit pas dans le cadre de la protection de l'enfance au sens de l'article L. 112-3 du code de l'action sociale et des familles.

²⁹ Cass. crim., 8 juin 2021, n° 20-86.000.

³⁰ Un tableau récapitulatif est proposé en annexe 2.

de l'article L. 226-2-2 du code de l'action sociale et des familles s'ils interviennent dans le cadre institutionnel de la protection de l'enfance (par exemple, en lien avec le bilan de santé et de prévention obligatoire à l'entrée en protection de l'enfance).

Une appréciation au cas par cas est ainsi nécessaire pour déterminer le cadre juridique qui s'applique et les conditions de l'échange ou du partage d'informations. Des illustrations sont proposées en annexe 2 pour aider les professionnels dans leur réflexion.

Lorsque la PJJ intervient sur le fondement de la justice pénale des mineurs (contrôle judiciaire, mesure éducative judiciaire provisoire [MEJP], sursis probatoire, etc.) : les échanges et partages d'informations qui impliquent des professionnels de la PJJ (avec les professionnels de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, médecins généralistes, pédiatres, médecins de PMI ou professionnels des équipes des urgences) sont considérés comme relevant du cadre général posé par les articles L. 1110-4 et R. 1110-1 et suivants du code de la santé publique.

Dans tous les cas, le caractère strictement nécessaire des informations échangées ou partagées doit s'apprécier en fonction de la situation de chaque enfant.

Les éléments juridiques relatifs à l'échange et au partage d'informations entre professionnels, abordés dans la présente recommandation portant sur la « coordination entre protection de l'enfance et psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent », ont été travaillés en lien avec la direction des Affaires juridiques (DAJ) des ministères sociaux et les différentes directions concernées au sein du ministère de la Justice (direction des Affaires criminelles et des Grâces [DACG], direction des Affaires civiles et du Sceau [DACS], direction de la Protection judiciaire de la jeunesse [DPJJ]), ainsi qu'en lien avec le Conseil national de l'ordre des médecins (CNOM).

Préambule

Remarques préalables liées au contexte

Un manque de moyens et des disparités territoriales dans les deux champs

L'abord de ce travail sur la coordination entre protection de l'enfance et psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent nécessite de mentionner en préambule le manque de moyens auquel sont souvent confrontés ces deux champs ainsi que les disparités départementales importantes qui sont constatées.

L'offre de soins en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent a été considérée comme ne permettant pas d'apporter une réponse satisfaisante aux besoins des enfants faisant l'objet d'une mesure de protection (25). Des délais d'attente excessifs en ambulatoire (plusieurs mois, voire dépassant une année dans certaines régions) et un manque de places en hospitalisation à temps plein ont notamment été rapportés, cela dans un contexte où le besoin était considéré comme étant en forte progression (14-16, 25). Des disparités territoriales, notamment départementales, ont également été identifiées en termes d'offre de soins (densités de lits d'hospitalisation en psychiatrie infanto-juvénile et de psychiatres de l'enfant et de l'adolescent par exemple) (26).

Parallèlement, la protection de l'enfance est confrontée à une hausse continue du nombre de mesures, particulièrement marquée pour les mesures d'accueil, notamment judiciaires (+ 48 % entre 2007 et 2021³¹) (12) et plus rapide que la hausse du nombre de places³² (27). Dans ce contexte, malgré une grande hétérogénéité selon les territoires et des données incomplètes et à considérer avec précaution³³, les délais de mise en œuvre des mesures judiciaires semblent augmenter (10 jours en moyenne pour les mesures d'accueil ; plus de 4 mois dans un tiers des départements pour les mesures d'action éducative en milieu ouvert (AEMO), dont 8 à 9 % au total sont en attente), accentuant les risques de mise en danger, de dégradation des situations et de ruptures dans les parcours.

Par ailleurs, après une année 2020 globalement atypique du fait du contexte sanitaire et une baisse du nombre de MNA accueillis sur le territoire en 2019-2020, les départements évoquent une reprise brutale de l'augmentation du nombre de mesures, aggravant la saturation des dispositifs (12).

Dans une lettre ouverte « à tous ceux qui œuvrent pour la qualité des soins et des accompagnements », le Collège de la HAS écrivait en mars 2022 : « Du côté des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, les pénuries de personnel s'accroissent. Les acteurs du secteur estiment qu'environ 5 à 10 % des postes d'infirmiers sont vacants dans les établissements de santé [...]. Plus d'un tiers des postes de praticiens hospitaliers ne sont pas pourvus à l'hôpital public [...] ; le secteur de la protection de l'enfance a également du mal à recruter. Dans les établissements, ces pénuries compromettent inévitablement la qualité des soins et des accompagnements. Le lien entre encadrement médical et paramédical et qualité des soins est en effet bien établi, tout comme l'importance d'équipes stables partageant une culture commune de qualité et sécurité des soins. Une enquête régionale révèle que seulement un tiers des soignants considère que les effectifs sont suffisants pour assurer des soins de qualité optimale. Ces pénuries de personnel contribuent également à la dégradation des conditions de travail des professionnels restant en poste, accentuant ainsi la pénibilité des métiers. Enfin,

³¹ De 2007 à 2021, le nombre de mesures d'aide sociale à l'enfance a augmenté de 28 %, l'augmentation étant particulièrement marquée pour les mesures d'accueil (+ 39,3 %), notamment judiciaires (+ 48 %). Si elles ont diminué en proportion, les actions éducatives ont également augmenté en nombre sur la période.

³² Entre 2013 et 2017, l'IGAS estime à 17 % l'augmentation du nombre de placements judiciaires, ce qui correspond à 19 000 enfants accueillis en plus, alors que « seulement » 10 000 places ont été créées sur la même période (en structures, l'offre en famille d'accueil étant stable).

³³ Différences dans les définitions des délais et dans les méthodes de calcul.

dans tous les secteurs, le manque de personnel conduit parfois à fermer lits, places et services, voire à suspendre certaines activités » (28).

Dans ce contexte, le groupe de travail a souhaité souligner la nécessité d'accompagner ces recommandations des moyens humains et financiers suffisants à leur mise en œuvre.

Des données encore insuffisantes en France sur les parcours des enfants protégés et sur l'efficacité des modalités et dispositifs de coordination mis en œuvre

Peu de données à portée générale sont actuellement disponibles en France sur l'accès aux soins en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et plus globalement sur les parcours de soins et d'accompagnement des enfants ayant une mesure de protection de l'enfance³⁴.

La recherche et l'analyse bibliographique conduites dans le cadre de ce travail ont par ailleurs mis en évidence un manque de données sur l'efficacité, et conséquemment sur l'efficience des modalités et dispositifs de coordination entre protection de l'enfance et psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent qui ont été développés, tant en France qu'à l'étranger.

Ainsi, le groupe de travail a souhaité encourager :

- la mise à disposition de données sur les parcours de soins et d'accompagnement des enfants protégés, notamment par la constitution de bases de données permettant un chaînage des données de santé et d'accompagnement pour l'ensemble des enfants ayant une mesure de protection de l'enfance ;
- le développement de travaux de recherche portant sur l'efficacité et l'efficience des modalités et dispositifs de coordination entre protection de l'enfance et psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent.

Des lois considérées comme étant encore imparfaitement mises en œuvre dans le champ de la protection de l'enfance

Les lois de 2007, 2016 et 2022 ayant réformé le champ de la protection de l'enfance sont décrites dans le rapport d'information du Sénat sur l'application des lois relatives à la protection de l'enfance comme « formant un ensemble cohérent et ambitieux, salué par les professionnels » mais étant pourtant « mises en œuvre très imparfaitement » (12).

Les dispositifs suivants sont notamment en lien avec les présentes recommandations.

- Le projet pour l'enfant (PPE)³⁵, prévu par la loi de 2007, était en 2018 mis en œuvre par 82 % des départements ayant répondu à une enquête de la DGCS³⁶ et, parmi les départements le mettant en œuvre, seuls 41 % le faisaient pour tout mineur bénéficiant d'une intervention en protection de l'enfance (hors aides financières) (29). En 2020, la Cour des comptes indiquait au sujet du PPE : « Outre son application inégale sur le territoire et le non-respect des délais pour son élaboration, la méthodologie retenue n'est guère satisfaisante » (14). Plus récemment, dans le rapport du Sénat cité ci-avant, le rapporteur indiquait en 2023 que les départements qu'il avait interrogés n'établissaient pas un PPE pour tous les enfants confiés à l'ASE (12).
- Comme indiqué en introduction, le bilan de santé et de prévention (intégrant un volet relatif à la santé psychique), créé par la loi de 2016 et devenu obligatoire dès le début de la mesure

³⁴ En 2020, la Cour des comptes rappelait « l'insuffisance et la dispersion des données disponibles en matière de protection de l'enfance » et soulignait que la production de données sur les parcours des enfants protégés, prévue par la loi du 5 mars 2007, n'était pas assurée.

³⁵ Pour plus d'informations, consulter l'annexe 5 – Points de repère concernant le projet pour l'enfant (PPE).

³⁶ 68 départements sur 83 répondants.

de protection de l'enfance en 2020, était décrit en 2021 comme n'étant pas encore réalisé dans tous les départements mais progressant dans son déploiement (12). Des données récentes sur la part des enfants ayant une mesure de protection de l'enfance qui ont effectivement bénéficié de ce bilan n'ont toutefois pu être identifiées à date d'élaboration de ces recommandations.

- La loi de 2016 prévoyait également le recrutement d'un médecin référent protection de l'enfance dans chaque département, notamment en charge de favoriser la coordination des services départementaux avec les médecins libéraux, hospitaliers et de santé scolaire du département. En 2023, le rapport du Sénat cité ci-avant faisait le constat de postes n'ayant pas été pourvus dans chaque département, les derniers chiffres cités étant ceux du rapport de la Cour des comptes élaboré en 2020 qui indiquait : « Sur 17 départements contrôlés par les juridictions financières sur ce point, six ont effectivement recruté un médecin sur un poste spécifique et cinq (souvent plus petits) ont confié cette mission au médecin départemental de protection maternelle et infantile (PMI) en sus de son activité » (12, 14).
- La loi de 2007 a instauré la mise en place d'un observatoire départemental de protection de l'enfance (ODPE) dans chaque département, composé notamment de représentants de la pédopsychiatrie³⁷. Dans le cadre d'une enquête réalisée en 2021 auprès de l'ensemble des directions enfance-famille, 37 départements sur les 58 ayant répondu au questionnaire ont mentionné une participation de la pédopsychiatrie au sein de l'ODPE (30).

Au regard de l'importance de ces dispositifs pour favoriser l'accès aux soins, y compris en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, ainsi que leur continuité, il apparaît indispensable que les ODPE mettent à disposition des indicateurs permettant de suivre annuellement la mise en œuvre, pour chaque enfant ayant une mesure de protection de l'enfance :

- du bilan de santé et de prévention ;
- et du PPE.

Ces indicateurs peuvent utilement s'accompagner d'éléments qualitatifs relatifs aux modalités de mise en œuvre de ces dispositifs.

Un suivi annuel au niveau national des créations de postes et des recrutements de médecins référents protection de l'enfance ainsi que des ODPE incluant effectivement des représentants de la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent serait également essentiel.

³⁷ Article D. 226-3-2 du code de l'action sociale et des familles.

Principes clés

La nécessité d'un environnement sécurisant en protection de l'enfance

Au regard des vulnérabilités spécifiques évoquées précédemment, chaque enfant ayant une mesure de protection de l'enfance doit pouvoir, en plus d'une orientation vers le soin quand elle est nécessaire, bénéficier d'un environnement sécurisant permettant de satisfaire ses besoins fondamentaux, sa sécurité notamment, et favorisant son bien-être. Cela suppose en particulier :

- de favoriser autant que possible la continuité du lien entre l'enfant, ses parents³⁸ et les professionnels qui l'accompagnent ;
- d'instaurer et de maintenir des relations de qualité facilitant l'apaisement, la confiance et le dialogue, notamment à travers :
 - l'adoption d'un langage, de postures et de pratiques bienveillants et respectueux (diversités culturelles, identité de genre et orientation sexuelle notamment) ;
 - l'adoption par les professionnels de protection de l'enfance de pratiques d'accompagnement tenant compte des psychotraumatismes³⁹.

Des conditions préalables au bon fonctionnement de la coordination entre protection de l'enfance et psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent

- Une culture et un langage partagés centrés sur les besoins fondamentaux de l'enfant⁴⁰

Au regard des différences de formations et de cultures entre les deux champs, il est important que les professionnels s'accordent sur les besoins fondamentaux de l'enfant en protection de l'enfance en tant que socle commun devant guider toute prise de décision le concernant et qu'ils développent autour de ce socle une culture et un langage partagés.
- Une meilleure interconnaissance

Au-delà du développement d'une culture partagée, il est essentiel que les professionnels améliorent leur connaissance de l'autre champ, de ses missions, de ses objectifs, mais aussi de ses limites d'intervention et des difficultés et contraintes auxquelles il est confronté, cela notamment afin de lever les représentations négatives.
- Une confiance réciproque et une dynamique de co-engagement autour de l'enfant

Dans un contexte de fonctionnement en silos et alors qu'il peut être tentant, en particulier face à des situations complexes, de renvoyer la responsabilité d'une prise en charge/d'un accompagnement vers un autre acteur/champ, il est important que les acteurs de la protection de l'enfance et de la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent interviennent dans une dynamique de confiance réciproque et de co-engagement autour de l'intérêt de l'enfant.

³⁸ En tenant compte des droits de visite et d'hébergement éventuellement fixés et de l'avis de l'enfant, selon son âge et son degré de maturité.

³⁹ « Les pratiques d'accompagnement tenant compte des traumatismes (*trauma-informed practice*) permettent d'améliorer les relations avec les personnes accueillies, de ne pas minimiser ou réactiver un trauma vécu et de faciliter le cas échéant l'adhésion et le maintien dans l'accompagnement. Il ne s'agit pas de pratiques thérapeutiques mais de principes permettant de guider les pratiques, les postures et les organisations des structures travaillant avec des publics susceptibles d'avoir subi des psychotraumatismes » (31).

⁴⁰ Pour plus d'informations, consulter l'annexe 3 – Points de repère concernant les besoins fondamentaux en protection de l'enfance.

Note de lecture

Certaines recommandations s'adressant plus particulièrement à la protection de l'enfance ou à la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, voire à d'autres acteurs également concernés par le document, la cible de chaque chapitre et de chaque recommandation a été précisée de la façon suivante :

- **PE & PSY** : chapitre ou recommandation s'adressant aux champs de la protection de l'enfance et de la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent ;
- **PE** : chapitre ou recommandation s'adressant plus particulièrement à la protection de l'enfance ;
- **PSY** : chapitre ou recommandation s'adressant plus particulièrement à la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent.

Lorsque le chapitre ou la recommandation s'adresse aussi à d'autres acteurs également concernés par le document, cela est précisé selon le même format.

1. Repérage et orientation vers la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent (PE)

1.1. Repérage (PE)

Le repérage des troubles psychiques/TND, s'inscrivant dans le cadre d'une prise en compte globale de la santé physique et psychique, est essentiel dès l'entrée en protection de l'enfance puis tout au long de la mesure.

Plusieurs acteurs y contribuent activement, notamment l'ensemble des professionnels intervenant auprès de l'enfant en protection de l'enfance, les professionnels de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent ainsi que les pédiatres et médecins généralistes (quel que soit leur mode d'exercice).

Le repérage s'inscrit dans un continuum incluant l'évaluation, l'orientation puis la prise en charge des enfants pour lesquels un besoin de soins en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent a été repéré.

Au début de la mise en œuvre de la mesure de protection de l'enfance

Points de repère

Un bilan de santé et de prévention est obligatoirement réalisé dès le début de la mesure de protection de l'enfance et intègre un volet relatif à la santé psychique⁴¹.

Selon les situations et les organisations mises en place par les conseils départementaux, le bilan de santé et de prévention obligatoire peut être réalisé par un médecin généraliste ou un pédiatre (médecin traitant le cas échéant), un médecin de PMI ou par le médecin référent protection de l'enfance.

Sur les territoires concernés, il peut s'inscrire dans le cadre de deux dispositifs visant à structurer le suivi de la santé somatique et psychique des enfants ayant une mesure de protection de l'enfance, en favorisant notamment la réalisation systématique de bilans et examens de santé et, si nécessaire, l'orientation effective des enfants vers les soins adaptés à leurs besoins à l'issue de ces bilans :

- parcours de soins coordonné des enfants et adolescents protégés (« Santé protégée ») (32-34) ;
- protocole de santé standardisé appliqué aux enfants ayant bénéficié avant l'âge de 5 ans d'une mesure de protection de l'enfance (PEGASE) (35, 36).

Ces dispositifs ont été initiés dans le cadre de l'article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2018⁴² et ont été autorisés pour une période transitoire établie pour une durée de 16 mois par arrêtés des 19 et 30 juillet 2024^{43,44}.

Une « consultation complexe à l'entrée du mineur dans le dispositif de protection de l'enfance », à laquelle est associé un tarif supérieur à celui d'une consultation au cabinet sans majoration, est prévue par la convention médicale signée le 4 juin 2024 entre l'Assurance maladie et les médecins libéraux⁴⁵.

R1 PE – Les professionnels responsables de l'accompagnement de l'enfant en protection de l'enfance s'assurent de la réalisation du bilan de santé et de prévention obligatoire dès le début de la mesure de protection de l'enfance dans un délai d'un mois, en lien avec la structure ou les professionnels en charge de la coordination des parcours de soins des enfants protégés le cas échéant⁴⁶.

⁴¹ Article L. 223-1-1 du code de l'action sociale et des familles : « [...] Un bilan de santé et de prévention est obligatoirement réalisé à l'entrée du mineur dans le dispositif de protection de l'enfance. Ce bilan est réalisé, dès le début de la mesure, pour tous les mineurs accompagnés notamment par l'aide sociale à l'enfance ou par la protection judiciaire de la jeunesse. Il permet d'engager un suivi médical régulier et coordonné, lequel formalise une coordination de parcours de soins, notamment pour les enfants en situation de handicap. Il identifie les besoins de prévention et de soins permettant d'améliorer l'état de santé physique et psychique de l'enfant, qui doivent être intégrés au projet pour l'enfant. Il est pris en charge par l'Assurance maladie. [...] »

⁴² « La loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 a introduit, en son article 51, un dispositif permettant d'expérimenter de nouvelles organisations en santé reposant sur des modes de financement inédits. Et ce, dès lors que ces nouvelles organisations contribuent à améliorer le parcours des patients, l'efficacité du système de santé, l'accès aux soins ou encore la pertinence de la prescription des produits de santé. » ([Rapports au Parlement et atlas des expérimentations – Ministère du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles](#) [consulté le 18 mars 2025]).

⁴³ Arrêté du 19 juillet 2024 relatif à l'innovation « parcours de soins coordonné des enfants et adolescents protégés ».

⁴⁴ Arrêté du 30 juillet 2024 relatif à l'innovation « PEGASE, protocole de santé standardisé appliqué aux enfants ayant bénéficié avant l'âge de cinq ans d'une mesure de protection de l'enfance ».

⁴⁵ Cela avait été initié dans la convention médicale signée en 2021, qui prévoyait qu'« afin d'assurer une meilleure prise en charge des enfants admis à l'aide sociale à l'enfance, leur bilan de santé par les généralistes et les pédiatres relèvera[it] désormais d'une consultation complexe ».

⁴⁶ Cette coordination des parcours peut notamment être organisée dans le cadre des dispositifs évoqués dans l'encadré « points de repère » ci-avant.

La structure chargée de la mise en œuvre de la mesure de protection de l'enfance :

- informe les parents de la nécessité de réaliser ce bilan de santé et de prévention ;
- l'organise ou, notamment pour les enfants accompagnés en milieu ouvert, appuie les parents pour son organisation, en favorisant autant que possible leur implication.

La question de l'information et de l'association des parents est spécifiquement abordée dans le cadre du chapitre 5 de cette recommandation.

Points de vigilance concernant les mineurs non accompagnés (MNA)

- Il est important que les professionnels de protection de l'enfance accompagnant des MNA veillent à ce qu'ils bénéficient, dans la continuité de la première identification des besoins en santé réalisée pendant l'accueil provisoire d'urgence⁴⁷, d'un bilan de santé adapté :
 - aux risques de psychotraumatismes spécifiquement liés aux expériences vécues dans le pays d'origine, pendant le parcours migratoire et à l'arrivée en France⁴⁸ ;
 - aux spécificités éventuelles du contexte culturel d'origine des enfants en termes de rapport au soin et aux professionnels de santé.
- Lorsque la langue constitue un frein à la communication, il est important que chaque enfant puisse avoir accès à un interprète professionnel, si possible formé dans le domaine de la santé⁴⁹.

Ces points de vigilance s'appliquent également dans le cadre de l'évaluation et des soins.

R2 PE – En cas de suivi psychiatrique préexistant à la mesure de protection de l'enfance, le bilan de santé et de prévention obligatoire à l'entrée en protection de l'enfance se fait en lien avec le psychiatre de l'enfant et de l'adolescent/l'équipe de soins suivant l'enfant en amont.

R3 PE – Une rencontre est systématiquement programmée avec un psychologue de la protection de l'enfance (psychologue ASE ou psychologue de la structure chargée de la mise en œuvre de la mesure), notamment pour identifier un éventuel besoin de soins en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent :

- elle implique de rechercher l'adhésion de l'enfant, ne peut lui être imposée et tient compte de la temporalité adaptée à sa situation ;
- elle se fait en lien avec le bilan de santé et de prévention (cf. R1) (prise en compte des éléments du bilan de santé et de prévention s'il a eu lieu en amont, transmission d'informations en vue de la réalisation du bilan de santé et de prévention s'il a lieu en aval) et les éventuels soins en cours en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent.

⁴⁷ Prévues par l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles, elles ont fait l'objet d'un guide de bonnes pratiques réalisé par un groupe pluripartenarial piloté par la direction générale de la Santé (DGS) et la DGCS et publié au bulletin officiel Santé protection sociale et solidarité du 30 novembre 2022 (37).

⁴⁸ Une recommandation HAS sur l'évaluation et la prise en charge du trouble de stress post-traumatique est en cours d'élaboration ([note de cadrage](#)).

⁴⁹ Pour plus d'informations, consulter l'annexe 4 – Points de repère concernant l'interprétariat linguistique dans le domaine de la santé.

Par ailleurs, une recommandation dédiée à l'accompagnement des MNA a été publiée par l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ANESM) en 2017 ([recommandation](#)) (38). Elle comporte un sous-chapitre dédié à la santé mentale des MNA qui évoque notamment cette question.

Tout au long de la mesure de protection de l'enfance

Points de repère : consultations et examens médicaux

- Le suivi préventif de tous les enfants comprend notamment 20 examens médicaux obligatoires, dont 13 au cours des trois premières années. « Le calendrier de ces examens est fixé par arrêté du ministre chargé de la Santé. » « Le repérage des troubles psychiques, notamment anxieux et dépressifs » fait partie du contenu de ces examens. « Les examens sont faits soit par le médecin traitant de l'enfant soit par un autre médecin choisi par les parents de l'enfant ou par les personnes titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou les personnes ou services à qui l'enfant a été confié ».⁵⁰
- Pour les enfants ayant une mesure de protection de l'enfance, ces examens médicaux peuvent contribuer à l'élaboration du volet santé physique et psychique du rapport sur la situation de l'enfant (au moins une fois par an ou tous les six mois pour les enfants de moins de trois ans)⁵¹.

R4 **PE** – Les professionnels accompagnant l'enfant en protection de l'enfance informent l'enfant (selon son âge et son degré de maturité) et ses parents de la nécessité de réaliser les 20 examens médicaux obligatoires prévus pour tous les enfants, dans le respect du calendrier prévu par la loi, et appuient leur organisation si nécessaire.

Points de vigilance d'ordre général concernant le suivi par un médecin généraliste, un pédiatre ou un médecin de PMI

Il est important que les professionnels de protection de l'enfance veillent :

- autant que possible, à la continuité de la prise en charge par le médecin généraliste, le pédiatre ou le médecin de PMI ;
- à rassembler les informations médicales relatives à l'enfant en amont d'une première consultation avec un médecin généraliste ou un pédiatre et, en lien avec le médecin généraliste, le pédiatre ou le médecin de PMI, à ce qu'un dossier médical à jour puisse suivre l'enfant tout au long de son parcours en protection de l'enfance et après⁵² ;
- à ce que l'enfant puisse être accompagné par une personne qui connaît son parcours et par qui il se sent soutenu lors d'une consultation médicale.

Ces points de vigilance sont complétés de recommandations dédiées à la coordination tripartite entre protection de l'enfance, psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et médecine générale/pédiatrie, disponibles au chapitre 6.1.

⁵⁰ Articles L. 2132-2 et R. 2132-1 du code de la santé publique ; arrêté du 14 novembre 2024 modifiant l'arrêté du 26 février 2019 relatif au calendrier des examens médicaux obligatoires de l'enfant.

⁵¹ Article L. 223-5 du code de l'action sociale et des familles : « Le service élabore au moins une fois par an, ou tous les six mois pour les enfants âgés de moins de trois ans, un rapport, établi après une évaluation pluridisciplinaire, sur la situation de tout enfant accueilli ou faisant l'objet d'une mesure éducative. Ce rapport porte sur la santé physique et psychique de l'enfant, son développement, sa scolarité, sa vie sociale et ses relations avec sa famille et les tiers intervenant dans sa vie. Il permet de vérifier la bonne mise en œuvre du projet pour l'enfant mentionné à l'article L. 223-1-1 et l'adéquation de ce projet aux besoins de l'enfant ainsi que, le cas échéant, l'accomplissement des objectifs fixés par la décision de justice. Un référentiel approuvé par décret en Conseil d'État fixe le contenu et les modalités d'élaboration du rapport. »

⁵² Mon espace santé, espace numérique personnel et sécurisé proposé par l'Assurance maladie et le ministère de la Santé, peut constituer un levier pour assurer la portabilité des données de santé de l'enfant. Par ailleurs, les dispositifs « Santé protégée » et PEGASE, mentionnés ci-avant, intègrent tous deux un dossier médical informatisé pour chaque enfant concerné.

R5 PE – Dans la continuité de la première rencontre (cf. R3), des rencontres complémentaires peuvent être programmées avec un psychologue de la protection de l'enfance (psychologue ASE ou psychologue de la structure chargée de la mise en œuvre de la mesure), notamment en cas de changement dans le comportement de l'enfant ou dans son environnement, en amont de la sortie du dispositif de protection de l'enfance, à la demande de l'enfant lui-même ou de toute personne se préoccupant de sa santé.

R6 PE – Tous les professionnels accompagnant l'enfant en protection de l'enfance (dont les assistants familiaux) sont attentifs, au quotidien, aux éventuels signes évocateurs d'un trouble psychique/TND exprimés par l'enfant.

Les psychologues exerçant en protection de l'enfance constituent une ressource pour contribuer à la sensibilisation de ces professionnels à la compréhension des symptômes et au repérage d'un besoin de soins en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent.

Il est également possible de s'appuyer sur des outils d'aide au repérage adaptés aux âges des enfants (guides, auto- ou hétéro-questionnaires notamment)⁵³, en veillant à garder à l'esprit que ces outils ne se substituent pas à une démarche clinique.

Points de vigilance

- Une vigilance toute particulière est portée au repérage d'éventuels besoins de soins en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent :
 - chez les bébés, un repérage précoce étant particulièrement important ;
 - chez les enfants ayant des symptômes « non bruyants » ;
 - chez les adolescents et jeunes adultes, et en particulier chez les jeunes femmes, une forte dégradation de leur santé mentale étant observée depuis le début de la pandémie de Covid-19 (41).
- Les professionnels exerçant en protection de l'enfance, fréquemment confrontés à des troubles psychiques/TND chez les enfants qu'ils accompagnent, sont susceptibles d'être concernés par un phénomène d'habituation qui pourrait conduire à une minimisation ou une banalisation des signes évocateurs de troubles psychiques/TND. Il est important d'informer les professionnels concernés de ce risque de biais, d'intégrer cet aspect à leur formation et d'en tenir compte dans les pratiques de travail en équipe, notamment en favorisant les regards croisés.

⁵³ Parmi les outils disponibles figurent par exemple le *Strenghts and difficulties questionnaire* (SDQ), les outils de dépistage identifiés par l'INESSS dans son avis sur le « dépistage des difficultés et retards liés au développement des enfants et des jeunes (0-18 ans) recevant des services en vertu de la loi sur la protection de la jeunesse » (2020) (39), le *Bullying Insomnia Tobacco Stress* (BITS), le guide de repérage « Souffrance psychique et troubles du développement chez l'enfant et l'adolescent », à l'usage des infirmiers et assistants de service social de l'Éducation nationale (40), et les guides de repérage des écarts de développement chez les enfants de 0-6 ans et chez les enfants de 7 à 12 ans élaborés par la délégation interministérielle à la stratégie nationale pour les troubles du neurodéveloppement.

1.2. Orientation vers les soins en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent (PE)

Interlocuteurs « psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent » identifiés au sein de la protection de l'enfance

R7 PE – Pour assurer le lien avec les acteurs impliqués dans les soins en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent présents sur le territoire, des interlocuteurs sont identifiés par la protection de l'enfance à deux échelons :

- au sein du conseil départemental/de la DT PJJ ;
- à l'échelon de chaque établissement/service de la protection de l'enfance.

Échelon	Au sein du conseil départemental et de la DT PJJ	Au sein de chaque établissement/service autorisé ASE et/ou PJJ
Professionnel concerné	Il peut s'agir par exemple d'un professionnel de santé, d'un psychologue, d'un cadre ou d'un autre professionnel assurant une fonction spécifique de coordination avec les partenaires extérieurs. Cette fonction peut également être assurée par : – au sein du conseil départemental : le médecin référent protection de l'enfance, en lien avec les missions énoncées dans le code de l'action sociale et des familles ; – au sein de la DT PJJ : un conseiller technique en promotion de la santé.	
Missions	Les interlocuteurs « psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent » identifiés respectivement au sein du conseil départemental et de la DT PJJ ont notamment pour missions de : – connaître et rencontrer les structures et acteurs impliqués dans les soins en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent présents sur le territoire, en particulier l'interlocuteur « protection de l'enfance » identifié au sein de la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent (cf. R10 ci-après) et, le cas échéant, la structure ou les professionnels en charge de la coordination des parcours de soins des enfants protégés ; – informer les acteurs de la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent sur les acteurs de la protection de l'enfance présents sur le territoire⁵⁴ ; – informer les professionnels de la protection de l'enfance sur les structures et acteurs impliqués dans les soins en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent présents sur le territoire ; – informer les professionnels de la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et les acteurs de la protection de l'enfance sur les réalités et difficultés rencontrées par les deux champs. Par ailleurs, l'interlocuteur « psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent » identifié au sein du conseil départemental a pour mission de centraliser les demandes à destination de la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent concernant les enfants accueillis chez un assistant familial géré par l'ASE.	L'interlocuteur « psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent » identifié au sein de chaque établissement/service autorisé ASE et/ou PJJ a pour mission principale de centraliser les demandes à destination de la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent concernant les enfants accompagnés par sa structure. À ce titre, il est en lien avec l'interlocuteur « protection de l'enfance » identifié au sein de la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent (cf. R10 ci-après), avec l'interlocuteur « psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent » identifié à l'échelon du conseil départemental/de la DT PJJ et, le cas échéant, avec la structure ou les professionnels en charge de la coordination des parcours de soins des enfants protégés.

⁵⁴ Il peut pour cela s'appuyer sur des annuaires déjà élaborés le cas échéant (conseil départemental, DT PJJ, etc.).

Formalisation des missions

Ces missions et la quotité de travail dédiée sont formalisées et :

- intégrées à la fiche de poste de la personne assurant cette fonction ;
- communiquées aux professionnels de protection de l'enfance et aux partenaires de la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent.

Selon les spécificités des territoires et des organisations (nombre et structuration des acteurs en présence dans chaque champ notamment), il est également envisageable que l'ensemble des demandes d'évaluation psychiatrique concernant des enfants ayant une mesure ASE soit centralisé à l'échelon du conseil départemental. Dans ce cas, il est important que l'interlocuteur « psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent » puisse être facilement identifiable et joignable par toutes les structures de protection de l'enfance autorisées.

Point de vigilance

Il est important de veiller à ce que des modalités de relais soient prévues en cas d'absence ou de départ d'un interlocuteur « psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent » identifié au sein de la protection de l'enfance.

Interlocuteurs et référents mentionnés dans les recommandations

Les recommandations identifient des interlocuteurs et référents dans les deux champs, cela à deux niveaux :

- des interlocuteurs « protection de l'enfance » et « psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent », identifiés respectivement au sein de la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et de la protection de l'enfance. Ils constituent une porte d'entrée vers l'autre champ pour tous les enfants concernés et ont une fonction de liaison et d'interconnaissance ;
- des référents du suivi individuel d'un enfant en particulier (au sein de la protection de l'enfance et de la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent respectivement), qui connaissent son parcours et ont une mission de coordination avec les partenaires impliqués dans l'accompagnement et la prise en charge de l'enfant concerné.

	Protection de l'enfance (PE)	Psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent
Liaison/interconnaissance entre les deux champs	Interlocuteur « psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent » (identifié au sein de la PE) (R7)	Interlocuteur « protection de l'enfance » (identifié au sein de la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent) (R10)
Suivi individuel du parcours de l'enfant	Référent éducatif et psychologue éventuellement (R20)	Référent du parcours de soins de l'enfant au sein de l'équipe de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent (R21)

Lorsqu'un besoin de soins en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent est repéré chez un enfant⁵⁵ et qu'une orientation vers la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent apparaît nécessaire

R8 PE – Les professionnels de la protection de l'enfance s'assurent :

- de l'adhésion de l'enfant, selon des modalités adaptées à son âge et à son degré de maturité ;
- du consentement de ses parents, sauf situations d'urgence, dans lesquelles ils seront informés le plus rapidement possible⁵⁶.

Point de vigilance

Le travail sur la prise de conscience des difficultés ou de la souffrance et l'accompagnement vers les soins est basé sur la confiance et se fait dans une temporalité adaptée, avec l'enfant comme avec ses parents.

Si, malgré les échanges, l'enfant s'oppose à une orientation vers la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, les professionnels de la protection de l'enfance :

- s'assurent qu'il comprend les enjeux et les risques potentiels liés à son refus, notamment en lui donnant la possibilité d'exprimer auprès de la personne de son choix (référént éducatif, professionnel de santé, psychologue, etc.) son ressenti, ses questions, ses craintes ;
- s'il maintient son refus, en informent le juge des enfants et/ou le conseil départemental s'ils estiment que la situation de refus de soins met en péril sa santé et/ou son développement.

Si, malgré les échanges, les parents s'opposent à une orientation vers la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, les professionnels de la protection de l'enfance :

- hors situation d'urgence, organisent un temps d'échange avec eux afin de comprendre les raisons de leur refus et de s'assurer qu'ils comprennent les enjeux ;
- leur indiquent, s'ils maintiennent leur refus, qu'ils vont en informer l'autorité judiciaire ou le prescripteur de la mesure s'ils estiment que la situation de refus de soins met en péril la santé de l'enfant et/ou son développement.

R9 PE – L'interlocuteur « psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent » identifié au sein de la protection de l'enfance pour assurer le lien avec la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent (cf. R7) prend contact⁵⁷ avec l'interlocuteur « protection de l'enfance » identifié au sein de la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent pour assurer le lien avec la protection de l'enfance (cf. R10 ci-après) ou avec une ressource pertinente en libéral pour une évaluation spécialisée en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent.

Pour les enfants ayant une mesure d'accompagnement en milieu ouvert, le service chargé de la mise en œuvre de la mesure veille à la réalisation effective des démarches et appuie les parents si nécessaire.

Il est important que la demande d'évaluation spécialisée en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent soit contextualisée.

⁵⁵ Y compris dans le cadre des bilans, examens et consultations de santé (cf. R1 et R4).

⁵⁶ Pour plus d'informations, consulter les repères juridiques.

⁵⁷ En lien, le cas échéant, avec la structure ou les professionnels en charge de la coordination des parcours de soins des enfants protégés.

2. Accès aux soins en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent (PE & PSY)

2.1. Interlocuteur « protection de l'enfance » identifié au sein de la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent (PSY)

R10 **PSY** – Un interlocuteur « protection de l'enfance » est identifié au sein de la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent pour assurer le lien avec la protection de l'enfance dans l'ensemble des situations nécessitant une coordination entre les deux champs (fonction de coordination).

Échelon	Il est identifié à l'échelon de chaque établissement de santé ayant une autorisation d'activité en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Il est attendu de lui qu'il connaisse les autres acteurs du champ psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent (CMPP et ressources libérales pertinentes notamment) ainsi que les communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) présents sur le territoire. Selon les organisations locales, d'autres échelons peuvent être choisis. Il est notamment envisageable de mutualiser la fonction d'interlocuteur privilégié entre plusieurs structures de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, par la désignation d'un interlocuteur « protection de l'enfance » dans le cadre du projet territorial de santé mentale (PTSM) par exemple.
Missions	Facilement identifiable et joignable par les acteurs de la protection de l'enfance, il a notamment pour missions de : – connaître et rencontrer les professionnels de la protection de l'enfance du territoire, en particulier le médecin référent protection de l'enfance ; – informer les acteurs de la protection de l'enfance sur les structures et acteurs impliqués dans les soins en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent présents sur le territoire⁵⁸ et sur les modalités permettant d'y accéder ; – informer les professionnels de la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent sur le fonctionnement de la protection de l'enfance et sur le cadre juridique lié à une mesure de protection de l'enfance ; – informer les professionnels de la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et les acteurs de la protection de l'enfance sur les réalités et difficultés rencontrées par les deux champs ; – orienter les demandes émanant de la protection de l'enfance vers les ressources pertinentes présentes sur le territoire, en prenant en considération les vulnérabilités des enfants concernés ; – s'assurer de l'effectivité de la coordination lorsque les situations le nécessitent.
Formalisation des missions	Ces missions et la quotité de travail dédiée sont formalisées et : – intégrées à la fiche de poste de la personne occupant cette fonction ; – communiquées aux professionnels de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et aux partenaires de la protection de l'enfance.

⁵⁸ Il peut pour cela s'appuyer sur des annuaires déjà élaborés le cas échéant (ARS, conseil départemental, etc.).

L'interlocuteur « protection de l'enfance » identifié au sein de la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent est également en lien, au moins à l'échelon de chaque secteur de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et de chaque CMPP, avec un psychiatre de l'enfant et de l'adolescent (fonction clinique). L'organisation mise en place permet aux professionnels de la protection de l'enfance :

- de joindre rapidement un professionnel de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent par téléphone ;
- d'être orientés vers une évaluation en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et des soins pour l'enfant s'ils sont nécessaires ;
- de bénéficier de conseils et de soutien pour accompagner les enfants en protection de l'enfance, de façon globale, indépendamment des situations individuelles, dans un objectif de prévention primaire et secondaire des troubles psychiques/TND.

Point de vigilance

Il est important de veiller à ce que des modalités de relais soient prévues en cas d'absence ou de départ d'un interlocuteur « protection de l'enfance » identifié au sein de la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent.

Interlocuteurs et référents mentionnés dans les recommandations

	Protection de l'enfance (PE)	Psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent
Liaison/interconnaissance entre les deux champs	Interlocuteur « psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent » (identifié au sein de la PE) (R7)	Interlocuteur « protection de l'enfance » (identifié au sein de la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent) (R10)
Suivi individuel du parcours de l'enfant	Référent éducatif et psychologue éventuellement (R20)	Référent du parcours de soins de l'enfant au sein de l'équipe de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent (R21)

2.2. Choix du secteur de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent le plus adapté (PSY)

Une absence de clarification ou des désaccords sur le secteur de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent devant prendre en charge l'enfant peuvent parfois conduire à ce qu'aucun secteur de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent ne s'occupe d'un enfant ayant une mesure de protection de l'enfance :

- quand les secteurs de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent dont relèvent le lieu d'accueil de l'enfant et le (ou les) domicile(s) des parents diffèrent ;
- ou quand un déménagement d'un (ou des) parent(s) ou un changement de lieu d'accueil de l'enfant implique un changement de secteur de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent.

Le manque de lisibilité sur le fonctionnement des secteurs de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent peut également mener à des difficultés d'orientation des enfants vers les soins pour les acteurs de la protection de l'enfance.

Point de repère : qu'est-ce que la sectorisation en psychiatrie ?

- L'organisation territoriale de la psychiatrie en secteurs géo-démographiques permet de couvrir l'ensemble du territoire national.
- La responsabilité d'un territoire, éventuellement découpé en plusieurs secteurs, est confiée à un établissement autorisé en psychiatrie sectorisée qui est chargé d'assurer accessibilité, proximité et continuité des soins (incluant les soins sans consentement) pour la population de ce/ces secteur(s).
- Trois types de secteurs ont été définis : secteurs de psychiatrie générale, infanto-juvénile (enfants et adolescents), en milieu pénitentiaire.

R11 **PSY** – En cas d'orientation vers la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent de secteur, le choix du secteur de prise en charge se fait au cas par cas, dans l'intérêt de l'enfant, en associant l'enfant (selon son âge et son degré de maturité) et les parents. Compte tenu des enjeux liés à la continuité des soins d'une part et à la proximité des soins d'autre part, les professionnels du soin et de la protection de l'enfance⁵⁹ doivent notamment prendre en considération dans la réflexion :

- l'existence ou non d'un suivi psychiatrique actif/en cours en amont ;
- le lieu de vie principal de l'enfant et son caractère durable (prise en compte de la stabilité du lieu d'accueil notamment⁶⁰) ;
- les localisations des différents lieux fréquentés par l'enfant : lieu de vie, domicile(s) des parents, établissement scolaire/lieu d'exercice professionnel, etc. ;
- la situation et le point de vue de l'enfant (volonté ou non de poursuivre le suivi préexistant le cas échéant, durée de trajet considérée comme acceptable, etc.) ;
- les restrictions judiciaires éventuelles, l'implication et le point de vue des parents ;
- la décision du juge des enfants le cas échéant.

⁵⁹ Référent ASE chargé de faire le « fil rouge » au niveau du conseil départemental et équipes des établissements et services autorisés ASE et/ou PJJ chargés de la mise en œuvre de la mesure le cas échéant, éventuellement en lien avec la structure ou les professionnels en charge de la coordination des parcours de soins des enfants protégés.

⁶⁰ Le lieu de vie ne doit pas être pris en compte de la même façon dans la décision s'il s'agit d'une structure d'accueil d'urgence ou d'un accueil provisoire.

Ainsi, il n'apparaît pas pertinent de définir, au niveau d'un établissement de santé sectorisé/d'un secteur de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, un cadre rigide imposant une règle commune pour l'ensemble des situations (prise en charge systématique des enfants par le secteur correspondant au lieu de vie de l'enfant ou, à l'inverse, par le secteur correspondant au(x) domicile(s) des parents), sans prise en compte du contexte pour chaque enfant⁶¹.

R12 **PE & PSY** – Lorsqu'un changement de lieu de vie susceptible d'impliquer un changement de secteur de prise en charge intervient pour un enfant ayant un suivi psychiatrique actif/en cours :

- les professionnels du soin et de la protection de l'enfance réfléchissent conjointement, dès la décision de changement de lieu de vie, à l'opportunité de changer ou non de secteur de prise en charge, en associant l'enfant (selon son âge et son degré de maturité) et ses parents. Il revient au professionnel en charge de la coordination du parcours de l'enfant en protection de l'enfance d'assurer la concertation ;
- lorsqu'un changement de secteur de prise en charge est décidé, l'équipe de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent qui suivait l'enfant en amont :
 - s'assure de la continuité et de la coordination des soins, en lien avec le professionnel en charge de la coordination du parcours de l'enfant en protection de l'enfance,
 - peut proposer un suivi en distanciel avant la mise en place du nouveau suivi, quand cela est possible et pertinent et pour une durée limitée.

Les principes déclinés dans les recommandations R11 et R12 s'appliquent également aux services de psychiatrie de l'adulte^{62, 63} concernés ainsi qu'aux structures de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent non sectorisés (incluant les CMPP).

2.3. Autres modalités facilitant l'accès aux soins psychiatriques pour les enfants ayant une mesure de protection de l'enfance (PE & PSY)

R13 **PSY** – Lorsqu'un enfant ayant déjà un suivi psychiatrique change de secteur de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à la suite d'un changement de lieu de vie (anticipé autant que possible par les professionnels de la protection de l'enfance), l'équipe de psychiatrie d'accueil lui garantit un accès direct (sans passage par une file d'attente), dans un objectif de continuité des soins.

R14 **PE & PSY** – Pour les premières demandes concernant des enfants ayant une mesure de protection de l'enfance, la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et la protection de l'enfance mettent conjointement en place une organisation permettant d'initier rapidement une évaluation du besoin de soins psychiatriques, prenant en compte les évaluations réalisées par la protection de l'enfance.

La priorisation pour la mise en place des soins se fait ensuite sur la base de critères cliniques, selon les mêmes modalités que pour les enfants n'ayant pas de mesure de protection de l'enfance.

⁶¹ Dans ce cadre, un secteur de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent sur lequel se situe le lieu de vie de l'enfant ou le(s) domicile(s) des parents ne peut refuser de prendre en charge l'enfant en invoquant uniquement la raison de la sectorisation.

⁶² Pour les jeunes adultes accompagnés par la protection de l'enfance et suivis en services de psychiatrie de l'adulte.

⁶³ Le décret n° 2022-1263 du 28 septembre 2022 relatif aux conditions d'implantation de l'activité de psychiatrie prévoit que l'activité de psychiatrie soit exercée selon quatre mentions : « psychiatrie de l'adulte », « psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent », « psychiatrie périnatale » et « soins sans consentement », la mention « psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent » assurant les prises en charge de l'enfant et de l'adolescent de la naissance à l'âge de dix-huit ans.

R15 **PSY** – Dans les cas où une prise en charge est identifiée comme nécessaire après une évaluation psychiatrique mais n'est pas accessible immédiatement, des solutions transitoires sont conjointement envisagées par la structure de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent sollicitée et les professionnels de protection de l'enfance accompagnant l'enfant, en associant l'enfant (selon son âge et son degré de maturité) et ses parents, au minimum pour permettre une vigilance sur sa situation.

Peuvent par exemple être mis en place :

- des contact(s) avec l'enfant, les parents et/ou les professionnels de protection de l'enfance concernés, dans le cadre d'une gestion active de la file d'attente (appels téléphoniques, réunions régulières entre les équipes de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et de protection de l'enfance, etc.) ;
- une veille par un psychologue de la protection de l'enfance⁶⁴, en coordination avec l'équipe de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, pour une durée limitée et selon un rythme conjointement fixés au préalable.

Si c'est adapté à la situation de l'enfant et possible, les professionnels de la structure de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent initialement sollicitée et les professionnels de protection de l'enfance peuvent exceptionnellement envisager conjointement une orientation vers d'autres structures ou professionnels, y compris en libéral, en associant l'enfant (selon son âge et son degré de maturité) et ses parents. Cette démarche se fait en lien avec l'interlocuteur « protection de l'enfance » identifié au sein de la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, qui connaît les différents acteurs du territoire, y compris les CPTS. Le suivi mis en place peut éventuellement se faire en coordination avec la structure de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent initialement sollicitée.

Lorsque des solutions transitoires ou des orientations par défaut vers d'autres structures ou professionnels sont mobilisées, il est important que les structures de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent puissent quantifier les délais d'accès et les besoins non satisfaits et en fassent un retour à l'ARS⁶⁵.

Cette recommandation est formulée dans un contexte où les délais d'attente pour une consultation en structures de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent sont décrits comme pouvant être très longs.

⁶⁴ Psychologue de l'ASE ou psychologue de la structure chargée de la mise en œuvre de la mesure le cas échéant.

⁶⁵ Le [manuel de certification des établissements de santé pour la qualité des soins](#) (version 2025) prévoit dans son critère 2.1-10 « En santé mentale et psychiatrie, l'accès aux soins est organisé et suivi » que « dans les structures ambulatoires de psychiatrie, des dispositions structurées et connues permettent un accès précoce aux soins ». Le critère 3.3-03 « L'établissement est acteur du projet territorial de santé mentale (PTSM) » prévoit également un temps annuel d'évaluation partagé, sur la base du résultat d'indicateurs dont font partie les délais d'entrée dans les soins.

3. Cohérence et continuité des soins et des accompagnements (PE & PSY)

3.1. 1^{re} consultation psychiatrique (PE & PSY)

Point de vigilance

Tel que mentionné dans les repères juridiques, lorsqu'ils concernent un enfant ayant une mesure de protection de l'enfance **dans un cadre administratif ou en assistance éducative dans un cadre judiciaire**, les échanges et partages d'informations dont il est fait mention dans cette recommandation sont majoritairement considérés comme relevant de l'article L. 226-2-2 du code de l'action sociale et des familles. Dans ce chapitre, sont en particulier concernés les échanges ou partages d'informations évoqués dans les recommandations R16 et R28.

Ainsi, sauf si cette information est contraire à l'intérêt de l'enfant :

- les professionnels de protection de l'enfance informent les parents et l'enfant (en fonction de son âge et de son degré de maturité) du fait que des informations strictement nécessaires à l'accompagnement ou à la prise en charge de l'enfant seront échangées ou partagées avec des professionnels de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent ;
- les professionnels de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent informent les parents et l'enfant (en fonction de son âge et de son degré de maturité) du fait que des informations strictement nécessaires à l'accompagnement ou à la prise en charge de l'enfant seront échangées ou partagées avec des professionnels de protection de l'enfance.

Lorsque la PJJ intervient sur le fondement de la justice pénale des mineurs (contrôle judiciaire, MEJP, sursis probatoire, etc.), les échanges et partages d'informations qui impliquent des professionnels de la PJJ (avec les professionnels de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, médecins généralistes, pédiatres, médecins de PMI ou professionnels des équipes des urgences) sont considérés comme relevant du cadre général posé par les articles L. 1110-4 et R. 1110-1 et suivants du code de la santé publique.

Dans ce cas, les professionnels, au-delà d'informer les parents et l'enfant, recueillent le consentement du représentant légal pour un partage d'informations en dehors de l'équipe de soins.

R16 **PE** – En amont de la première consultation psychiatrique (structure de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent ou professionnel en libéral), les professionnels de protection de l'enfance accompagnant l'enfant transmettent les informations strictement nécessaires à sa prise en charge à l'équipe/au professionnel de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent concerné(e).

La liste ci-dessous est présentée à titre indicatif. Le caractère strictement nécessaire ou non des informations doit s'apprécier en fonction de la situation de chaque enfant.

Contexte de la demande d'évaluation ou de soins en psychiatrie

- Éléments motivant la demande, incluant les antécédents connus de troubles psychiques/TND le cas échéant ainsi que les signes éventuellement repérés par d'autres acteurs (Éducation nationale, établissements et services médico-sociaux, PMI, etc.), contexte d'apparition des difficultés identifiées et évolution dans le temps
- Actions déjà mises en place par les professionnels de protection de l'enfance et effets le cas échéant
- Ressources identifiées et mobilisées chez l'enfant et dans son entourage et effets le cas échéant

Informations sur l'histoire et le parcours de l'enfant en protection de l'enfance

- Contexte ayant conduit à la mesure
- Type de mesure mise en place (ASE/PJJ ; accompagnement en milieu ouvert, accueil), cadre juridique (administratif, judiciaire) et objectifs de la mesure
- Mesures de protection antérieures, changements de lieux d'accueil et motifs de ces changements le cas échéant
- Déroulement et effets de la mesure en cours (acceptation de la mesure par l'enfant et ses parents, relations de l'enfant et des parents avec les professionnels de protection de l'enfance, effets sur l'enfant de la séparation avec ses parents, sa famille et son environnement en cas de placement, relations avec les autres enfants accueillis le cas échéant, etc.)

Informations relatives aux parents et à la famille

- Informations relatives à l'exercice de l'autorité parentale
- Droits de visite et d'hébergement éventuellement fixés
- Identité et coordonnées des personnes habilitées à donner le consentement au soin
- Relations de l'enfant avec ses parents, ses frères et sœurs et les autres membres de sa famille depuis la mise en œuvre de la mesure
- Possibilités de mobilisation des parents dans le cadre des soins et de l'accompagnement (en lien avec les objectifs de la mesure et du PPE et en tenant compte des restrictions judiciaires éventuelles)

Informations sur le parcours de santé de l'enfant

- Identité et coordonnées des professionnels impliqués dans le suivi de santé de l'enfant
- Résultats des bilans et examens déjà réalisés le cas échéant (y compris le bilan réalisé par l'UAPED le cas échéant)
- Notification MDPH et accompagnements médico-sociaux en cours le cas échéant

Informations sur la scolarité de l'enfant

- Lieu de scolarisation et classe le cas échéant

Parmi les éléments ressources susceptibles d'être transmis figurent :

- le bilan de santé et de prévention réalisé à l'entrée en protection de l'enfance ;
- le projet pour l'enfant (PPE)⁶⁶ ;
- les éléments utiles issus de l'évaluation globale de la situation de l'enfant, réalisée en amont de la mise en place de la mesure de protection de l'enfance⁶⁷ ou en cours de mesure.

Il est également important que les professionnels de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent puissent avoir accès au carnet de santé de l'enfant qui, selon les situations, peut être en possession des parents, de l'enfant ou de la structure/du professionnel chargé(e) de la mise en œuvre de la mesure d'accueil⁶⁸.

⁶⁶ Pour plus d'informations, consulter l'annexe 5 – Points de repère concernant le projet pour l'enfant (PPE).

⁶⁷ Lorsqu'une évaluation est jugée nécessaire à la suite de la réception d'une information préoccupante concernant la situation d'un ou de plusieurs enfants, celle-ci intègre un volet relatif au développement et à la santé physique et psychique de l'enfant (articles L. 226-3 et D. 226-2-3 du code de l'action sociale et des familles, cadre national de référence HAS pour l'évaluation globale de la situation des enfants en danger ou risque de danger) (42).

⁶⁸ Article L. 2132-1 du code de la santé publique : « Le carnet est établi au nom de l'enfant. Il est remis aux parents ou aux personnes titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou aux personnes ou aux services à qui l'enfant a été confié. Ils doivent être informés

Ces informations viennent compléter les informations transmises au moment de la demande d'évaluation spécialisée (cf. R9). Elles peuvent être transmises par le référent de l'enfant (référent ASE ou référent au sein de la structure chargée de la mise en œuvre de la mesure) et/ou, selon les situations, par le psychologue ASE, le psychologue de la structure chargée de la mise en œuvre de la mesure, l'acteur chargé de la coordination du parcours de soins de l'enfant, l'assistant familial.

Elles s'ajoutent aux informations transmises par les parents le cas échéant.

Points de vigilance

- Pour les enfants accueillis chez un assistant familial, l'implication de ce dernier à cette étape, individuellement ou conjointement avec le référent et/ou le psychologue, permet d'assurer une complémentarité des regards (connaissance du parcours global de l'enfant et de la situation des parents pour le référent et/ou le psychologue et accompagnement au quotidien pour l'assistant familial).
- D'une façon générale, il est important que les professionnels de protection de l'enfance et de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent veillent à éviter que l'enfant ne soit contraint de répéter son histoire à de multiples interlocuteurs, en assurant la transmission des informations pertinentes.

Ces informations sont transmises de façon sécurisée, par tout moyen garantissant la confidentialité, en privilégiant, pour chaque enfant, l'utilisation d'un document unique d'interface entre les deux champs.

La transmission d'informations peut être effectuée par courrier, par messagerie sécurisée, par un partage via l'espace numérique de l'enfant « Mon espace santé » s'il est actif⁶⁹ ou via un autre dossier informatisé partagé ayant été développé le cas échéant. Elle peut également se faire dans le cadre d'une réunion de synthèse.

Pour chaque enfant, les identités des personnes autorisées à accéder aux informations échangées ou partagées sont définies, tracées et actualisées régulièrement.

Il est souhaitable qu'une réflexion soit coordonnée par le médecin référent protection de l'enfance au sein de chaque département afin de formaliser les circuits et les procédures d'échange et de partage d'informations.

R17 **PE & PSY** – Lors de la première consultation psychiatrique, le référent de l'enfant en protection de l'enfance (référent ASE ou référent au sein de la structure chargée de la mise en œuvre de la mesure le cas échéant) s'assure que l'enfant puisse être accompagné par une personne/un professionnel qui connaît son parcours et par lequel il se sent soutenu.

Au cours de la période d'évaluation psychiatrique, l'équipe/le professionnel de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent peut rencontrer, selon les situations (simultanément ou successivement) :

- les parents (en particulier pour les enfants ayant une mesure d'accompagnement en milieu ouvert et en tenant compte des restrictions judiciaires éventuelles) ;
- des professionnels accompagnant l'enfant en protection de l'enfance, qui connaissent son parcours ;
- et/ou d'autres personnes ressources de l'entourage de l'enfant.

que nul ne peut en exiger la communication et que toute personne appelée, de par sa fonction, à prendre connaissance des renseignements qui y sont inscrits est soumise au secret professionnel. »

⁶⁹ Sous réserve de l'opposition éventuelle de la personne mineure, tel que prévu par l'article L. 1111-13-1 du code de la santé publique, mentionné dans les repères juridiques du présent document.

Points de repère

Selon l'article L. 223-1-3 du code de l'action sociale et des familles, « le mineur peut désigner une **personne de confiance** majeure, qui peut être un parent ou toute autre personne de son choix. La désignation de cette personne de confiance est effectuée en concertation avec l'éducateur référent du mineur. [...] Si le mineur le souhaite, la personne de confiance l'accompagne dans ses démarches [...] ».

Par ailleurs, selon l'article L. 221-2-6 du code de l'action sociale et des familles, il est proposé à chaque enfant ayant une mesure de protection de l'enfance, « avec l'accord des parents ou des autres titulaires de l'autorité parentale, si tel est l'intérêt de l'enfant et après évaluation de la situation, de désigner un ou plusieurs **parrains ou marraines**, dans le cadre d'une relation durable coordonnée par une association et construite sous la forme de temps partagés réguliers entre l'enfant et le parrain ou la marraine [...]»⁷⁰.

De la même façon, « il est systématiquement proposé à l'enfant pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance de bénéficier d'un **mentor**. Le mentorat désigne une relation interpersonnelle d'accompagnement et de soutien basée sur l'apprentissage mutuel. Son objectif est de favoriser l'autonomie et le développement de l'enfant accompagné en établissant des objectifs qui évoluent et s'adaptent en fonction de ses besoins spécifiques. Le recours au mentorat doit être proposé à l'entrée au collège ».

R18 **PE & PSY** – Si un besoin de soins en psychiatrie a été identifié à l'issue de la période d'évaluation, le référent de l'enfant en protection de l'enfance organise un échange avec l'équipe/le professionnel de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent concerné(e). Cet échange permet de déterminer notamment les modalités à mettre en place pour soutenir le bon déroulement des soins et pour favoriser le transfert dans le quotidien des éléments travaillés dans le cadre du projet thérapeutique de l'enfant :

- modalités à mettre en place par les différents professionnels de protection de l'enfance, incluant l'assistant familial le cas échéant (organisation des prises de rendez-vous, opportunité et modalités de l'accompagnement de l'enfant aux rendez-vous, présence éventuelle pendant certaines consultations, suivi de l'assiduité, suivi de l'observance des traitements médicamenteux et accompagnement si nécessaire, etc.) ;
- modalités de soutien et de guidance à mettre éventuellement en place par l'équipe/le professionnel de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à destination des professionnels de la protection de l'enfance ;
- modalités d'information et d'association des parents, voire d'autres personnes de l'entourage de l'enfant, aux soins et à l'accompagnement, et modalités de soutien et de guidance à mettre éventuellement en place auprès d'eux par les professionnels des deux champs⁷¹, en lien avec les objectifs définis dans le cadre de la mesure de protection et du PPE.

⁷⁰ La désignation d'un ou de plusieurs parrains ou marraines est proposée à tout mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille.

⁷¹ Pour plus d'informations, consulter le chapitre 5 dédié à l'association des enfants et des parents.

À l'occasion de cet échange, le référent de l'enfant en protection de l'enfance et les professionnels de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent s'accordent par ailleurs sur les modalités d'articulation entre professionnels (incluant l'assistant familial le cas échéant), notamment :

- les modalités concrètes de prise de contact réciproque ;
- les informations strictement nécessaires de part et d'autre au bon déroulement de l'accompagnement et des soins.

R19 PE & PSY – Le caractère strictement nécessaire de toute transmission d'informations à un professionnel de l'autre champ est ensuite évalué tout au long de l'accompagnement et des soins. À titre indicatif, il peut s'agir d'échanger :

- des informations et en particulier des inquiétudes concernant le comportement de l'enfant, sa santé et/ou son environnement (« crises » éventuelles par exemple) ;
- des éléments de compréhension sur ses difficultés et ressources ;
- des propositions d'adaptation de l'accompagnement afin de favoriser son bien-être ;
- des informations sur d'éventuelles absences de l'enfant aux consultations et sur des propositions de solutions pour favoriser la continuité des soins ;
- des informations sur des changements liés au parcours de l'enfant en protection de l'enfance et/ou à la situation de ses parents (droits de visite et d'hébergement, changement de mesure, changement de lieu de vie, sortie du dispositif de protection de l'enfance, etc.).

Ces informations s'ajoutent aux informations échangées avec les parents le cas échéant.

3.2. Référents du parcours de l'enfant (PE & PSY)

En complément des interlocuteurs « psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent » et « protection de l'enfance » identifiés aux recommandations R7 et R10, qui constituent des « portes d'entrée » respectives vers l'autre champ et visent principalement à favoriser l'interconnaissance et à faciliter l'accès aux soins (centralisation des demandes et des réponses), des référents sont identifiés pour chaque enfant en vue d'assurer la coordination de son parcours lorsqu'un suivi psychiatrique est initié.

Interlocuteurs et référents mentionnés dans les recommandations

	Protection de l'enfance (PE)	Psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent
Liaison/interconnaissance entre les deux champs	Interlocuteur « psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent » (identifié au sein de la PE) (R7)	Interlocuteur « protection de l'enfance » (identifié au sein de la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent) (R10)
Suivi individuel du parcours de l'enfant	Référent éducatif et psychologue éventuellement (R20)	Référent du parcours de soins de l'enfant au sein de l'équipe de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent (R21)

R20 **PE** – Référent au sein de la protection de l'enfance assurant le lien avec la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent en cours de suivi

Lorsqu'un suivi psychiatrique est mis en place pour un enfant, son référent éducatif (référent ASE ou référent de la structure chargée de la mise en œuvre de la mesure le cas échéant), qui connaît l'enfant et son parcours, assure le lien avec la structure de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent concernée, éventuellement en binôme avec le psychologue (psychologue ASE ou psychologue de la structure chargée de la mise en œuvre de la mesure le cas échéant).

R21 **PSY** – Référent du parcours de soins de l'enfant au sein de l'équipe de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent

Pour chaque enfant ayant un suivi psychiatrique, l'équipe de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent identifie en son sein un référent chargé de suivre son parcours de soins et d'assurer les liens avec les professionnels de protection de l'enfance qui l'accompagnent.

Cette fonction de référent, dont les missions sont formalisées au niveau de la structure, peut être assurée, selon les situations, par un infirmier, un assistant de service social, un éducateur spécialisé, un médecin ou un psychologue par exemple, en tenant compte autant que possible des souhaits de l'enfant.

Points de vigilance

Il est important de veiller, dans les deux champs, à ce que :

- l'identité et les coordonnées du référent de l'enfant soient transmises aux professionnels de l'autre champ ;
- des modalités de relais soient prévues en cas d'absence ou de départ du référent.

3.3. Association de la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent aux décisions concernant le parcours de l'enfant en protection de l'enfance (PE & PSY)

Pour favoriser la cohérence et la continuité des soins et des accompagnements, il apparaît nécessaire que les professionnels de la protection de l'enfance associent les professionnels de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent aux temps suivants, pour chaque enfant accompagné par les deux champs :

- élaboration et actualisation du projet pour l'enfant (PPE) ;
- élaboration des rapports de situation ;
- changements de lieux d'accueil le cas échéant.

À ces temps peuvent s'ajouter, selon les situations et les besoins identifiés, d'autres temps d'échanges entre les professionnels des deux champs.

Projet pour l'enfant et projet personnalisé d'accompagnement le cas échéant

Points de repère

Le code de l'action sociale et des familles prévoit, depuis 2007, qu'un projet pour l'enfant (PPE) soit établi pour chaque enfant dans un délai de trois mois à compter du début de la prestation ou de la mesure de protection de l'enfance. Le PPE prend en compte les différents domaines de vie de l'enfant, parmi lesquels « le développement, la santé physique et psychique »⁷², qui doit faire l'objet d'un volet dédié. Il intègre, pour chaque domaine, « les éléments synthétiques d'évaluation actualisée, et notamment ceux de l'évaluation médicale et psychologique [...] [et] les observations et propositions des titulaires de l'autorité parentale, de l'enfant et de son environnement ». Il définit ensuite, sur la base de ces éléments, les objectifs poursuivis et un plan d'action, qui décrit les actions à mener auprès de l'enfant, des titulaires de l'autorité parentale et de son environnement et qui précise la durée des actions ainsi que les acteurs les mettant en œuvre⁷³.

Le PPE est remis au mineur et à ses représentants légaux et est communicable à chacune des personnes physiques ou morales qu'il identifie⁷⁴.

Les enfants accompagnés par une structure de protection de l'enfance ont également un projet personnalisé d'accompagnement, dont le volet « développement, santé physique et psychique » est élaboré en cohérence avec le PPE le cas échéant.

R22 **PE** – Lorsque l'enfant bénéficiait d'un suivi psychiatrique en amont de la mesure de protection de l'enfance ou si une évaluation/des soins a/ont été initiée(s) depuis le début de la mesure, le professionnel en charge de la coordination de son parcours en protection de l'enfance invite le référent du suivi psychiatrique (cf. R21)⁷⁵ à participer à l'élaboration du PPE (évaluation de la situation, définition des objectifs à poursuivre et des actions à mener auprès de l'enfant, des parents/titulaires de l'autorité parentale et de son environnement), comme les autres partenaires impliqués dans la vie de l'enfant

⁷² Cf. article D. 223-15 du code de l'action sociale et des familles : « Le projet pour l'enfant prend en compte les domaines de vie suivants :

« 1° Le développement, la santé physique et psychique de l'enfant ;

« 2° Les relations avec la famille et les tiers ;

« 3° La scolarité et la vie sociale de l'enfant. »

Pour plus d'informations, consulter l'annexe 5 – Points de repère concernant le projet pour l'enfant (PPE).

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ Article L. 223-1-1 du code de l'action sociale et des familles.

⁷⁵ Ou un professionnel de l'équipe de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent si un référent n'a pas encore été désigné.

(pour ce qui concerne le volet « développement, santé physique et psychique » : professionnels du champ sanitaire et du médico-social le cas échéant), l'enfant et les parents.

Point de vigilance

Pour les enfants accompagnés par une structure de protection de l'enfance n'ayant pas encore bénéficié d'un PPE, à défaut, les professionnels de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent sont invités par la structure concernée à participer à l'élaboration du projet personnalisé d'accompagnement.

R23 **PSY** – Le référent du suivi psychiatrique de l'enfant (cf. R21)⁷⁶ contribue à l'élaboration du volet « développement, santé physique et psychique » du PPE⁷⁷ :

- de préférence en participant à la (aux) réunion(s) dédiée(s) organisée(s) par le professionnel en charge de la coordination du parcours de l'enfant en protection de l'enfance ;
- ou via un temps d'échange en amont de cette(ces) réunion(s) avec :
 - le professionnel en charge de la coordination du parcours de l'enfant en protection de l'enfance,
 - le référent de l'enfant au sein de la structure chargée de la mise en œuvre de la mesure le cas échéant (si ce n'est pas la même personne).

À défaut, il transmet au professionnel en charge de la coordination du parcours de l'enfant en protection de l'enfance les informations strictement nécessaires à l'élaboration de son PPE, par tout moyen garantissant la confidentialité. Il peut s'agir d'éléments relatifs à la situation de l'enfant, aux axes à travailler dans le cadre du projet thérapeutique et aux modalités de prise en charge susceptibles d'être proposées dans ce cadre.

Point de vigilance

Lors d'une réunion pluripartenariale (protection de l'enfance, psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, autres partenaires éventuels) traitant de la situation individuelle d'un enfant accompagné par la protection de l'enfance, la structure ayant organisé la réunion rappelle que les informations échangées :

- doivent être strictement nécessaires à l'accompagnement ou à la prise en charge de l'enfant concerné ;
- sont soumises au secret pour l'ensemble des participants.

R24 **PE** – Lorsqu'une évaluation ou un suivi psychiatrique est en cours, le PPE finalisé est transmis aux professionnels de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent concernés, comme aux autres partenaires impliqués dans sa mise en œuvre (pour ce qui concerne le volet « développement, santé physique et psychique » : professionnels du champ sanitaire et du médico-social le cas échéant), par tout moyen garantissant la confidentialité.

⁷⁶ Ou un professionnel de l'équipe de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent si un référent n'a pas encore été désigné.

⁷⁷ Et/ou du projet personnalisé d'accompagnement élaboré au sein de la structure chargée de la mise en œuvre de la mesure (cf. encadré « point de vigilance » de la R22).

Rapport de situation et actualisation du PPE

Point de repère

Au cours de la mesure de protection de l'enfance, un rapport de situation est élaboré au moins une fois par an, ou tous les six mois pour les enfants âgés de moins de trois ans. Ce rapport porte notamment sur la santé physique et psychique de l'enfant et son développement, et il est établi après une évaluation pluridisciplinaire de sa situation⁷⁸.

Le rapport de situation sert de base à l'actualisation du PPE⁷⁹.

R25 **PE** – Lorsque l'enfant bénéficie d'un suivi psychiatrique, les professionnels de protection de l'enfance associent, par tout moyen garantissant la confidentialité, les professionnels de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'élaboration du volet « développement, santé physique et psychique » du rapport sur la situation de l'enfant, comme les autres partenaires impliqués dans sa mise en œuvre (professionnels du champ sanitaire et du médico-social le cas échéant), l'enfant et les parents.

L'objectif est notamment de faire le point sur :

- la santé physique et psychique de l'enfant et son développement ;
- la mise en œuvre du projet thérapeutique (dont déroulement des soins, transfert dans le quotidien des éléments travaillés dans le cadre du suivi, éléments de surveillance du traitement médicamenteux le cas échéant, mobilisation des parents) ;
- l'opportunité de poursuivre les soins et/ou d'ajuster les modalités de suivi et d'accompagnement.

R26 **PE** – Les professionnels de protection de l'enfance associent ensuite les professionnels de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'actualisation du PPE, comme l'enfant et les parents. Les recommandations R22, R23 et R24 s'appliquent également dans ce cadre.

Changement de lieu d'accueil de l'enfant

R27 **PE** – Lorsqu'un changement de lieu d'accueil est envisagé pour un enfant ayant un suivi psychiatrique actif/en cours⁸⁰, les professionnels de protection de l'enfance organisent un échange avec le(s) professionnel(s) de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent concerné(s) afin de recueillir leur avis sur les effets éventuels de ce changement et, le cas échéant, d'envisager ensemble des modalités d'accompagnement de l'enfant vers le nouveau projet.

⁷⁸ Article L. 223-5 du code de l'action sociale et des familles.

⁷⁹ Article D. 223-13 du code de l'action sociale et des familles.

⁸⁰ Sont évoqués ici les changements de lieux d'accueil susceptibles d'être anticipés.

3.4. Transmission d'informations de la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à la protection de l'enfance (PSY)

R28 **PSY** – Au minimum une fois par an et à chaque changement significatif de prise en charge, l'équipe de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent transmet les informations strictement nécessaires à la prise en charge et à l'accompagnement de l'enfant :

- au sein des services de l'ASE : au(x) professionnel(s) au(x)quel(s) le suivi de la santé de l'enfant a été confié (psychologue référent de l'enfant, médecin référent protection de l'enfance, ou autre(s) professionnel(s) de santé) ;
- et/ou au sein de la structure autorisée ASE et/ou PJJ chargée de la mise en œuvre de la mesure le cas échéant : au psychologue ou au référent éducatif de l'enfant (ou à un professionnel de santé le cas échéant).

Il peut s'agir d'éléments relatifs au projet thérapeutique et à sa mise en œuvre, en lien avec les axes définis dans le cadre du PPE (dont déroulement des soins, transfert dans le quotidien des éléments travaillés dans le cadre du suivi, éléments de surveillance du traitement médicamenteux le cas échéant, mobilisation des parents).

Ces informations sont transmises de façon sécurisée, par tout moyen garantissant la confidentialité, en privilégiant, pour chaque enfant, l'utilisation d'un document unique d'interface entre les deux champs.

La transmission d'informations peut être effectuée par courrier, par messagerie sécurisée, par un partage via l'espace numérique de l'enfant « Mon espace santé » s'il est actif⁸¹ ou via un autre dossier informatisé partagé ayant été développé le cas échéant. Elle peut également se faire dans le cadre d'une réunion de synthèse.

La coordination des informations pouvant être transmises par l'équipe de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent est assurée par le psychiatre en charge du suivi de l'enfant concerné. Pour chaque enfant, les personnes de la protection de l'enfance autorisées à accéder aux informations transmises par l'équipe de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent sont définies, tracées et actualisées régulièrement.

Les informations transmises peuvent être mobilisées pour l'élaboration du PPE (cf. R22-R23) et du rapport de situation (cf. R25). Leur formalisation dans ces documents fait idéalement l'objet d'une validation par le partenaire concerné.

⁸¹ Sous réserve de l'opposition éventuelle de la personne mineure, tel que prévu par l'article L. 1111-13-1 du code de la santé publique, mentionné dans les repères juridiques du présent document.

4. Recours aux urgences et hospitalisation à temps plein en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent (PE & PSY)

4.1. Recours aux urgences pour des symptômes évocateurs d'un trouble psychique/TND (PE, PSY et autres acteurs)

Cadre général

R29 **PE PSY & autres acteurs** – Un protocole de réponses graduées aux situations de crise est élaboré, à l'échelon du département (ou du PTSM s'il est infra-départemental), entre le conseil départemental, la DT PJJ et l'ARS, en lien avec la gouvernance du PTSM.

Sa co-construction associe :

- pour la protection de l'enfance : les acteurs gérant une ou des structures autorisées au titre de l'ASE et/ou de la PJJ ;
- pour le champ sanitaire : les acteurs de premier recours (pédiatres et médecins généralistes notamment, ainsi que les CPTS présentes sur le territoire), les structures et professionnels de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, les services d'urgences, en particulier pédiatriques, et le SAMU.

Les acteurs de santé de l'Éducation nationale sont également associés.

Ce protocole aborde les questions relatives à :

- la prévention du recours aux urgences ;
- l'amont de l'orientation vers les urgences lorsqu'une crise a lieu (interface téléphonique, possibilité de consultations ambulatoires en CMP par exemple) ;
- la période de prise en charge aux urgences ;
- l'aval de la prise en charge aux urgences.

Il constitue l'un des volets des conventions à formaliser entre acteurs de protection de l'enfance et de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent (cf. R61). Il est réévalué et actualisé régulièrement.

Prévention du recours aux urgences

R30 **PE & PSY** – En prévention du recours aux urgences, les acteurs de la protection de l'enfance peuvent solliciter les acteurs de la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent pour des échanges autour des situations individuelles :

- pour les enfants ayant un suivi psychiatrique ;
- pour les enfants présentant des symptômes évocateurs d'un trouble psychique/TND.

Ces échanges visent notamment à repérer, pour chaque enfant concerné :

- des circonstances contextuelles qui ont tendance à entraîner une crise ;
- des signes avant-coureurs d'une crise ;
- des stratégies d'apaisement.

Si l'enfant le souhaite et selon son âge et son degré de maturité, ces éléments peuvent également être renseignés dans un document co-construit à distance d'une crise par l'enfant et les professionnels (de protection de l'enfance, de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et/ou le médecin généraliste/pédiatre qui le suit par exemple, selon les situations et les préférences de l'enfant), notamment dans un objectif de prévention et d'anticipation des situations de crise.

Ce document :

- résulte d'une décision partagée ;
- peut aussi inclure des éléments relatifs aux personnes que l'enfant souhaite voir contactées en cas de crise, aux souhaits de l'enfant concernant les soins, etc. ;
- est, si l'enfant le souhaite, partagé avec les professionnels impliqués dans son accompagnement et ses soins ainsi qu'avec les personnes identifiées comme étant un soutien⁸².

Il peut être intégré en annexe du volet « développement, santé physique et psychique » du PPE.

Les recommandations R31 à R35 concernent exclusivement les enfants ayant une mesure d'accueil.

Organisation du recours aux urgences par la protection de l'enfance

R31 **PE** – Pour chaque enfant ayant une mesure d'accueil, les professionnels de protection de l'enfance (professionnel en charge de la coordination du parcours de l'enfant en protection de l'enfance ou structure chargée de la mise en œuvre de la mesure le cas échéant) élaborent un document de liaison d'urgence, rempli et mis à jour en dehors de l'urgence et contenant :

- les nom, prénom et date de naissance de l'enfant ;
- les personnes habilitées à donner le consentement aux soins ;
- les noms et coordonnées des personnes à contacter (professionnels de la protection de l'enfance, parents) ;
- le nom et les coordonnées du service de l'ASE et de l'assistant familial/la structure chargé(e) de la mise en œuvre de la mesure ;
- les informations relatives à l'exercice de l'autorité parentale et les droits de visite et d'hébergement éventuellement fixés ;
- le nom et les coordonnées du médecin traitant de l'enfant ou du médecin généraliste/pédiatre/médecin de PMI qui le suit ;
- le nom et les coordonnées du(des) professionnel(s) de protection de l'enfance impliqué(s) dans le suivi de la santé de l'enfant (psychologue référent de l'enfant, médecin référent protection de l'enfance ou autre(s) professionnel(s) de santé) ;
- les noms et coordonnées des autres professionnels de santé suivant l'enfant le cas échéant ;
- les pathologies et traitements en cours, antécédents personnels, allergies ;
- les informations relatives à une éventuelle situation de handicap.

⁸² Cette recommandation s'inscrit dans la continuité de publications précédentes de la HAS qui proposent des plans de prévention partagés (PPP) impliquant la personne dans les décisions qui concernent sa santé, pour augmenter sa participation dans un esprit de co-construction : [Programme de soins psychiatriques sans consentement](#) et [Mieux prévenir et prendre en charge les moments de violence dans l'évolution clinique des patients adultes lors des hospitalisations en services de psychiatrie](#). Ces PPP ont toutefois été élaborés pour des patients adultes et sont adaptés à des situations précises ; ils ne peuvent donc être mobilisés à l'identique concernant des enfants ayant une mesure de protection de l'enfance.

Un outil s'adressant spécifiquement aux adolescents et jeunes adultes « présentant une fragilité psychique ou ayant déjà connu un épisode psychotique » a été développé par Psycom (organisme public d'information sur la santé mentale et de lutte contre la stigmatisation) : mon GPS ado/jeune adulte.

Concernant les éléments relatifs à la santé de l'enfant (pathologies et traitements en cours, antécédents personnels, allergies et informations relatives à une éventuelle situation de handicap notamment), il appartient aux professionnels d'apprécier au cas par cas quelles sont les informations strictement nécessaires en fonction de la situation de chaque enfant.

Si un document de prévention et d'anticipation des situations de crise (cf. R30) a été co-construit avec l'enfant, il peut, avec son accord, être joint au document de liaison d'urgence.

Le document de liaison d'urgence peut être intégré à l'espace numérique de l'enfant « Mon espace santé » s'il est actif⁸³. Lors de l'urgence, il est transmis au médecin prenant en charge l'enfant dans le service des urgences ou consulté via l'espace numérique de l'enfant « Mon espace santé ».

Un exemple de trame de [document de liaison d'urgence](#) fait partie des outils mis à disposition dans le cadre de cette recommandation.

R32 **PE** – Lors d'un recours aux urgences pour un enfant ayant une mesure d'accueil, il est important que l'enfant concerné puisse être accompagné par un professionnel de la protection de l'enfance du départ vers les urgences jusqu'à la sortie des urgences.

Pour les situations où cela ne peut être assuré par un professionnel présent au moment de la crise, le service de l'ASE ou la structure de protection de l'enfance en charge de la mise en œuvre de la mesure s'organise pour qu'un autre professionnel accompagne l'enfant. Ce professionnel qui, idéalement, connaît l'enfant, est informé de la situation ayant conduit à recourir aux urgences et est en possession du document de liaison d'urgence (cf. R31).

Points de vigilance

- Les parents sont informés au plus vite du recours aux urgences⁸⁴.
- Les modalités pertinentes d'association des parents sont évaluées au cas par cas et, idéalement, de façon anticipée, en tenant compte notamment : des restrictions judiciaires éventuelles ; de la situation clinique ; du motif de l'orientation de l'enfant vers les urgences ; des effets anticipés de leur présence sur l'enfant.

Coordination entre professionnels dans le cadre de la prise en charge aux urgences et préparation de la sortie (hors situations d'hospitalisation à temps plein)

L'orientation d'un enfant vers les urgences par les professionnels de protection de l'enfance témoigne d'une situation de grande difficulté pour l'enfant et/ou le lieu dans lequel il réside. Elle constitue un signal d'alarme à prendre en compte.

Dans le contexte d'un recours aux urgences pour un trouble psychique/TND, la proposition de mettre en place une hospitalisation ou des soins ambulatoires relève, après évaluation pluriprofessionnelle, d'un médecin.

Elle est explicitée à l'enfant (selon son âge et son degré de maturité), aux parents et aux professionnels accompagnant l'enfant en protection de l'enfance.

⁸³ Sous réserve de l'opposition éventuelle de la personne mineure, tel que prévu par l'article L. 1111-13-1 du code de la santé publique, mentionné dans les repères juridiques du présent document.

⁸⁴ Pour plus d'informations, consulter les repères juridiques.

R33 **PE PSY & autres acteurs** – Lorsqu’une hospitalisation n’est pas jugée nécessaire, les équipes des urgences, les équipes de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, les équipes de pédiatrie le cas échéant et les professionnels de la protection de l’enfance se mettent en lien pour organiser la suite des soins et de l’accompagnement et pour éviter autant que possible les réitérations de passages aux urgences⁸⁵ :

- dans le cadre de ces échanges, les professionnels de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent ont plus particulièrement la charge d’orienter l’enfant vers des modalités de soins adaptées pour assurer la prise en compte thérapeutique des troubles qui ont conduit les professionnels de protection de l’enfance à faire appel aux urgences ;
- avant la sortie des urgences, l’ensemble des professionnels concernés⁸⁶ s’assurent qu’une consultation psychiatrique en ambulatoire est bien programmée. À défaut, le relais est assuré avec les professionnels de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent qui suivront l’enfant en ambulatoire pour qu’une consultation soit rapidement programmée.

R34 **Équipe des urgences** – Les professionnels de santé des urgences informent l’enfant, les parents, les membres de l’entourage de l’enfant éventuellement présents et les professionnels l’accompagnant en protection de l’enfance sur la conduite à tenir en cas d’aggravation de la crise actuelle ou de nouvelle crise.

Ces éléments ainsi que les informations relatives à la consultation psychiatrique programmée en ambulatoire sont inclus au courrier/courriel de sortie adressé aux professionnels partenaires (professionnel(s) de protection de l’enfance au(x)quel(s) le suivi de la santé de l’enfant a été confié [psychologue référent de l’enfant, médecin référent protection de l’enfance, ou autre(s) professionnel(s) de santé], médecin généraliste, pédiatre ou médecin de PMI et psychiatre de l’enfant s’il est suivi notamment).

Ces informations sont transmises de façon sécurisée, par tout moyen garantissant la confidentialité.

Il peut s’agir d’une transmission par courrier, par messagerie sécurisée ou d’un partage via l’espace numérique de l’enfant « Mon espace santé » s’il est actif⁸⁷ ou d’un autre dossier informatisé partagé ayant été développé le cas échéant.

Il est souhaitable qu’une réflexion soit coordonnée par le médecin référent protection de l’enfance au sein de chaque département afin de formaliser les circuits et les procédures d’échange et de partage d’informations.

Pour chaque enfant, les identités des personnes autorisées à accéder aux informations échangées ou partagées sont définies, tracées et actualisées régulièrement.

⁸⁵ L’organisation des soins et des accompagnements en cas d’hospitalisation à temps plein en psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent est abordée dans le chapitre suivant.

⁸⁶ En lien, le cas échéant, avec la structure ou les professionnels en charge de la coordination des parcours de soins des enfants protégés.

⁸⁷ Sous réserve de l’opposition éventuelle de la personne mineure, tel que prévu par l’article L. 1111-13-1 du code de la santé publique, mentionné dans les repères juridiques du présent document.

Possibilités d'accueil transitoire post-recours aux urgences en protection de l'enfance

R35 **PE** – Il est important que le conseil départemental et les organismes gérant des structures autorisées en protection de l'enfance s'organisent pour disposer en permanence de places permettant d'accueillir de façon transitoire un enfant ayant une mesure d'accueil lorsqu'un retour immédiat sur son lieu de vie habituel après un recours aux urgences n'apparaît pas pertinent (sans pour autant qu'une hospitalisation soit nécessaire).

Dans ces situations, l'organisation pour l'enfant d'un temps en dehors de son lieu de vie habituel peut permettre :

- un apaisement ;
- un échange sur la situation avec lui ;
- une analyse de la situation entre professionnels de protection de l'enfance l'accompagnant habituellement ;
- de poursuivre les échanges avec les autres enfants présents sur le lieu de vie le cas échéant, pour aborder les éventuels effets provoqués chez eux par la crise (sentiment d'insécurité par exemple) et créer les conditions d'un retour le plus serein possible pour l'enfant concerné, en veillant à ne pas le stigmatiser et à éviter tout sentiment d'exclusion.

Ces places d'accueil transitoire, qui ne se substituent pas au lieu de vie habituel de l'enfant, peuvent également être mobilisées par les professionnels de la protection de l'enfance de façon temporaire pour prévenir les crises, les recours aux urgences et les ruptures d'accompagnement en favorisant un apaisement et une prise de distance pour l'enfant concerné, pour les autres enfants accompagnés et pour les professionnels.

4.2. Hospitalisation à temps plein en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent : continuité dans et avec les lieux d'accueil (PE & PSY)

En cas d'hospitalisation à temps plein en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, de même que pour tous les soins, il est essentiel de tout mettre en œuvre pour recueillir l'adhésion aux soins de l'enfant concerné et de ses parents et d'explicitier à l'enfant un éventuel recours à des soins se faisant sans son consentement⁸⁸.

R36 **PSY** – En préadmission ou en début d'hospitalisation en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, une durée d'hospitalisation est estimée par l'équipe de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et une date prévisionnelle de sortie, réévaluable en fonction de l'évolution clinique, est communiquée aux professionnels de protection de l'enfance, à l'enfant (selon son âge et son degré de maturité) et à ses parents.

R37 **PE & PSY** – Pendant une hospitalisation en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, l'assurance d'avoir une place au sein d'un lieu d'accueil et de la conserver, quelle que soit la durée de l'hospitalisation, est essentielle à l'enfant ainsi que pour construire un projet thérapeutique.

Il est souhaitable d'éviter autant que possible qu'un changement de lieu d'accueil concorde avec un temps d'hospitalisation. Si cela ne peut être évité, il est indispensable que le changement de lieu d'accueil soit anticipé dès l'admission en hospitalisation et préparé avec l'enfant.

L'objectif partagé entre les équipes de protection de l'enfance et de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent est alors d'éviter que l'hospitalisation ne doive se prolonger au-delà de la date de sortie programmée, tout en veillant à mettre en place une solution d'accueil aussi stable que possible dans ce contexte.

R38 **PSY** – En amont, tout au long de l'hospitalisation et au moment de la sortie, le référent du parcours de soins de l'enfant au sein de l'équipe de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent (cf. R21) organise des échanges avec les professionnels accompagnant l'enfant en protection de l'enfance. Il associe l'enfant et ses parents, en tenant compte des restrictions judiciaires éventuelles.

R39 **PE & PSY** – Si son état clinique le permet et en tenant compte des restrictions judiciaires éventuelles, l'enfant doit pouvoir, s'il le souhaite, maintenir des liens avec ses proches (téléphone, courriel, visites, etc., selon les possibilités proposées par le service) et bénéficier de sorties temporaires.

Les modalités de maintien des liens et de sorties temporaires sont définies par l'équipe de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent en lien avec les professionnels accompagnant l'enfant en protection de l'enfance, de même que les modalités du suivi scolaire, dans la mesure où les conditions d'hospitalisation le permettent (cf. point de repère ci-après).

Il est également important que les professionnels accompagnant l'enfant en protection de l'enfance le contactent régulièrement pour prendre de ses nouvelles et lui rendent visite, notamment pour les enfants ayant une mesure d'accueil.

⁸⁸ Pour plus d'informations, consulter les repères juridiques.

Point de vigilance

Lorsque l'équipe de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent souhaite organiser une sortie pour un enfant ayant une mesure d'accueil familial gérée par l'ASE, il convient de contacter le service de l'ASE (réfèrent ASE en particulier) en première intention.

Point de repère : droit à un suivi scolaire adapté au sein des établissements de santé

« En France, l'éducation est un droit fondamental et inconditionnel, pour tout enfant⁸⁹ » (43).

« La scolarisation est un élément déterminant dans la socialisation de l'enfant comme pour le développement de sa vie relationnelle. Le suivi scolaire des enfants en âge scolaire adapté au sein des établissements de santé est un droit⁹⁰ dans la mesure où leurs conditions d'hospitalisation le permettent. La scolarisation fait partie intégrante du projet de soins dès lors que l'état somatique, l'état psychique, le niveau de soins et la durée d'hospitalisation le permettent » (44).

R40 **PE** – Dans le cadre d'une mesure d'accueil, les aspects logistiques (gestion du linge, organisation des trajets vers l'établissement scolaire, etc.) sont, pendant l'hospitalisation, organisés par la protection de l'enfance. L'implication des parents est favorisée, en tenant compte des droits de visite et d'hébergement éventuellement fixés et en lien avec les objectifs de la mesure et du PPE⁹¹. L'organisation est définie en préadmission ou en début de séjour, en lien avec l'équipe de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent.

R41 **PE & PSY** – Au moment de la sortie d'hospitalisation :

- l'équipe de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent :
 - programme la poursuite des soins psychiatriques en ambulatoire et/ou à temps partiel et transmet le calendrier des rendez-vous aux professionnels accompagnant l'enfant en protection de l'enfance ainsi qu'aux parents,
 - propose, si nécessaire, un soutien aux professionnels accompagnant l'enfant en protection de l'enfance, de façon à créer les conditions d'un retour sur le lieu de vie qui soit le plus serein possible pour l'enfant concerné, les autres enfants accompagnés le cas échéant et les professionnels. Des modalités de soutien et de guidance peuvent également être mises en place à destination des parents, notamment pour les enfants ayant une mesure d'accompagnement en milieu ouvert ;
- les professionnels accompagnant l'enfant en protection de l'enfance et l'équipe de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent veillent à accompagner l'enfant dans la poursuite ou la reprise de sa scolarité.

Les principes déclinés dans les recommandations R36 à R41 s'appliquent également aux hospitalisations en services de pédiatrie pour des motifs psychiatriques.

⁸⁹ Article 28 de la Convention internationale des droits de l'enfant ; article 24 de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées ; article 13 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; article 26 de la Déclaration universelle des droits de l'homme.

⁹⁰ Article L. 1110-6 du code de la santé publique.

⁹¹ Pour mémoire, la question de l'information et de l'association des parents est spécifiquement abordée dans le cadre du chapitre 5 de la recommandation.

5. Association des enfants protégés et de leurs parents (PE & PSY)

Points de repère

- Comme l'ensemble du PPE, le volet dédié à la santé psychique est établi en concertation avec les titulaires de l'autorité parentale et avec l'enfant lui-même, selon des modalités adaptées à son âge et à sa maturité⁹².
- Les enfants accompagnés par une structure de protection de l'enfance sont également associés à l'élaboration du volet « développement, santé physique et psychique » du projet personnalisé d'accompagnement, de même que les titulaires de l'autorité parentale⁹³.

Pour aller plus loin

Deux recommandations abordent la question de la place de l'enfant et des parents dans le cadre spécifique de l'accompagnement en protection de l'enfance.

- [L'expression et la participation du mineur, de ses parents et du jeune majeur dans le champ de la protection de l'enfance](#) (45) ;
- [L'exercice de l'autorité parentale dans le cadre du placement](#) (45) (recommandation qui comporte une fiche repère concernant la santé de l'enfant).

R42 **PE** – Afin de lutter contre les représentations négatives et la stigmatisation, les professionnels de la protection de l'enfance :

- abordent systématiquement la santé mentale avec l'enfant et ses parents, dès le début de la mesure de protection de l'enfance :
 - en leur rappelant qu'elle fait partie, avec la santé physique et comme la scolarité, la vie sociale ou les relations avec la famille et les tiers, des domaines essentiels de l'accompagnement,
 - en leur indiquant les professionnels qui sont à leur disposition pour échanger en cas de mal-être/de difficultés chez l'enfant :
 - les professionnels de protection de l'enfance, parmi lesquels le psychologue, les professionnels de santé le cas échéant, mais aussi le référent de l'enfant et les autres membres de l'équipe éducative,
 - les acteurs de santé mobilisables en ville et en établissement de santé, leur rôle et la façon dont ils peuvent être sollicités ;
- organisent tout au long de l'accompagnement des temps d'échanges réguliers concernant la santé, y compris mentale, de l'enfant :
 - avec l'enfant lui-même,
 - avec les parents.

⁹² Articles L. 223-1-1 et D. 223-13 du code de l'action sociale et des familles.

⁹³ Article L. 311-3 du code de l'action sociale et des familles.

Points de vigilance

- Il est important que l'ensemble des professionnels de protection de l'enfance s'approprie la question de la santé mentale des enfants accompagnés et puisse l'aborder avec eux. Cette question ne doit pas être la seule responsabilité des psychologues et des professionnels de santé.
- Il est par ailleurs essentiel de veiller à ce que les professionnels (assistants familiaux notamment) ne se sentent pas isolés et puissent être soutenus en cas de difficulté/questionnement face à une situation. Cela peut se faire dans le cadre de réunions d'équipe et/ou par l'identification de professionnels susceptibles d'être contactés en cas de besoin.

Points de repère : supports de sensibilisation concernant la santé mentale

Différents supports de sensibilisation concernant la santé mentale existent, à destination des enfants et/ou des parents.

Les professionnels de protection de l'enfance peuvent s'appuyer sur ces supports dans le cadre d'échanges en groupe ou d'entretiens individuels.

L'opportunité de les utiliser doit être interrogée au cas par cas et, lorsqu'ils sont utilisés, il convient que les professionnels veillent en particulier :

- à avoir recours à des supports adaptés au public qu'ils accompagnent ;
- à ce que leur utilisation ne conduise pas les enfants ou les parents concernés à se sentir stigmatisés.

Exemples d'outils (liste non exhaustive)

[Mpedia](#) (site grand public de l'Association française de pédiatrie ambulatoire) : articles à destination des parents, dont « [Mal-être : reconnaître les signes de dépression à l'adolescence](#) ».

[Psycom](#) (organisme public d'information sur la santé mentale et de lutte contre la stigmatisation) :

- vidéos « [le Cosmos mental](#) » et « [la Boussole de la santé mentale](#) » ;
- kit pédagogique « [le Jardin du Dedans](#) » destiné aux enfants âgés de 8 à 11 ans et composé d'une histoire et de deux livrets pédagogiques pour les adultes souhaitant parler de santé mentale avec les enfants.

[Sparadrap](#) (association pour améliorer le parcours de soin de l'enfant et de l'adolescent) : rubrique parents « [Mon enfant a des soucis](#) », dont « Chez le psy comment ça se passe ? », « Les principales psychothérapies », « Les différents "psys" ».

[Yapaka](#) ([programme de prévention de la maltraitance](#) à l'initiative du ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles de Belgique) :

- campagne « [Une vie de chien](#) » à destination des enfants et comprenant notamment un livre, des vidéos et des affiches ;
- campagne « [L'histoire d'Hubert et de 100drine](#) », à destination des adolescents et composée d'un livre et d'un blog.

R43 PE & PSY – Les professionnels de protection de l'enfance et de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent interrogent dans chaque situation les modalités pertinentes d'information de l'enfant et de recueil de son point de vue, notamment en fonction de son âge, de son degré de maturité, de ses capacités et de ses difficultés, afin d'assurer sa bonne compréhension. Des outils en facile à lire et à comprendre (FALC) peuvent par exemple être mobilisés.

Les professionnels de protection de l'enfance et de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent visent, en particulier pour les adolescents, un niveau d'information et d'association le plus important possible afin de favoriser la confiance et l'adhésion à l'évaluation et/ou aux soins psychiatriques.

Point de vigilance

Il est important, pour préparer la sortie du dispositif de protection de l'enfance, de veiller à renforcer progressivement l'implication des adolescents dans leurs soins (prise de rendez-vous, suivi des thérapies médicamenteuses et non médicamenteuses, etc.).

Il convient notamment d'aborder cette question dans le cadre de l'entretien prévu au plus tard un an avant la majorité et de l'intégrer au projet d'accès à l'autonomie⁹⁴.

R44 PE & PSY – Les professionnels de protection de l'enfance et de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent interrogent dans chaque situation les modalités pertinentes d'information et de mobilisation de chacun des parents, au regard de l'intérêt de l'enfant et en tenant compte notamment :

- du cadre de la mesure : administratif (reposant sur un accord) ou judiciaire (cadre contraint) ;
- du type de mesure : ASE/PJJ ; accompagnement en milieu ouvert, accueil ;
- des motifs de la mesure ;
- des objectifs de la mesure et des objectifs du PPE et du projet personnalisé d'accompagnement le cas échéant ;
- de la situation de chacun des parents au regard de l'autorité parentale (titulaires ou non de l'autorité parentale, plein exercice ou exercice partiel de l'autorité parentale, présents ou non dans la vie de l'enfant) ou des autres titulaires de l'autorité parentale le cas échéant, et des droits de visite et d'hébergement éventuellement fixés ;
- de l'opposition éventuelle de l'enfant lui-même⁹⁵.

Les objectifs de la mesure, du PPE et du projet personnalisé d'accompagnement sont définis et régulièrement actualisés au cours du parcours de l'enfant en protection de l'enfance, sur la base d'évaluations pluridisciplinaires de la situation⁹⁶ et notamment en fonction :

- des ressources et difficultés des parents (dont la capacité à identifier les besoins de santé de l'enfant et à y répondre de façon adaptée), mais aussi de leur volonté de s'impliquer ou non ;

⁹⁴ Article L. 222-5-1 du code de l'action sociale et des familles.

Pour plus d'informations, consulter la recommandation HAS « [Améliorer la prise en charge à la sortie des dispositifs de protection de l'enfance – Volet 2 – L'accompagnement vers l'autonomie](#) » (46).

⁹⁵ Tel que prévu par l'article L. 1111-5 du code de la santé publique, mentionné dans les repères juridiques du présent document.

⁹⁶ Le [cadre national de référence HAS pour l'évaluation globale de la situation des enfants en danger ou risque de danger](#) (42) prévoit notamment une évaluation de la capacité des parents à répondre aux besoins de santé de l'enfant. Sont proposés entre autres, à titre d'exemples, les questionnements suivants :

- Les parents sont-ils en capacité d'écouter l'enfant, d'identifier les symptômes, d'apprécier la gravité ou l'urgence d'une situation ?
- Les parents sont-ils en capacité de répondre aux besoins de l'enfant de façon adaptée :
 - o en prodiguant eux-mêmes des soins (avec un point de vigilance sur l'automédication) ?
 - o en sollicitant de l'aide auprès de professionnels de santé ?

Une recommandation HAS sur [l'évaluation globale de la situation de l'enfant en cours de mesure de protection de l'enfance](#) est en cours d'élaboration.

- des souhaits exprimés par l'enfant⁹⁷, selon son âge et son degré de maturité ;
- des relations parents-enfant et de l'impact que l'implication des parents pourrait avoir sur l'enfant.

En tenant compte des restrictions judiciaires éventuelles, les professionnels de protection de l'enfance et de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent favorisent la mobilisation des parents dans le suivi en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent.

L'objectif est notamment de :

- favoriser l'adhésion aux soins, soutenir leur bon déroulement, dont l'observance des traitements (par exemple via, selon les situations, une participation à la prise des rendez-vous, l'accompagnement de l'enfant à des consultations, des visites à l'enfant en cas d'hospitalisation) ;
- et faciliter le transfert dans le quotidien des éléments travaillés dans le cadre du suivi psychiatrique (y compris pour les enfants ayant une mesure d'accueil, dans le cadre des droits de visite et d'hébergement).

Point de vigilance

Pour les enfants ayant une mesure d'accueil, il est particulièrement important de renforcer l'association des parents lorsqu'un retour au domicile est envisagé, dans un objectif d'autonomisation dans la réponse aux besoins de santé de l'enfant.

R45 **PE & PSY** – Les professionnels de protection de l'enfance et de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent veillent à échanger régulièrement, tout au long du suivi, avec l'enfant et, selon les situations⁹⁸, les parents, sur :

- les difficultés rencontrées (dont les éventuelles situations de crise) ;
- les ressources qu'ils peuvent mobiliser et la façon dont ils peuvent demander de l'aide (auprès des professionnels de protection de l'enfance et/ou de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent ainsi qu'auprès des personnes ressources de l'entourage le cas échéant) ;
- les modalités de soins proposées ;
- les modalités de transfert dans le quotidien des éléments travaillés dans le cadre du suivi psychiatrique ;
- les modalités de coordination entre les différents professionnels qui interviennent autour de l'enfant ;
- les signes d'alerte qu'ils peuvent eux-mêmes repérer.

Les modalités d'échange avec l'enfant et les parents sont pensées conjointement par les professionnels de protection de l'enfance et de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, en lien avec les autres professionnels impliqués dans le suivi de la santé de l'enfant le cas échéant.

R46 **PE** – Pour les enfants ayant une mesure d'accueil, les professionnels de protection de l'enfance et de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent informent au minimum les parents⁹⁹ :

- de la fréquence définie pour les consultations ;
- des éventuelles situations de crise et recours aux urgences, aussi rapidement que possible.

⁹⁷ Pour plus d'informations, consulter les repères juridiques.

⁹⁸ Dont une opposition éventuelle de la personne mineure, tel que prévu par l'article L. 1111-5 du code de la santé publique, mentionné dans les repères juridiques du présent document.

⁹⁹ Sous réserve de l'opposition éventuelle de la personne mineure, tel que prévu par l'article L. 1111-5 du code de la santé publique, mentionné dans les repères juridiques du présent document.

R47 **PE & PSY** – Lorsqu’une réunion pluripartenariale (protection de l’enfance, psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, autres partenaires éventuels) est organisée pour aborder la situation d’un enfant, la structure à l’initiative de la réunion :

- informe l’enfant et les parents¹⁰⁰ :
 - en amont : de la date de la réunion, de son objet et des participants prévus,
 - à l’issue de la réunion : des décisions prises le cas échéant ;
- met en place des modalités adaptées de recueil du point de vue de chacun :
 - au minimum en amont de la réunion,
 - éventuellement, via une participation à la réunion ou à une partie de la réunion.

R48 **PSY** – Les courriers/courriels transmis par les professionnels de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, les médecins généralistes, pédiatres et médecins de PMI dans le cadre des recommandations R28, R52 et R53 sont également adressés aux parents de l’enfant concerné¹⁰¹ et à l’enfant (selon son âge et son degré de maturité).

Point de vigilance

Lorsqu’un tiers digne de confiance a été désigné, il reçoit les mêmes informations que celles qui sont transmises aux parents.

R49 **PE & PSY** – Les professionnels de protection de l’enfance et de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent échangent avec l’enfant pour identifier :

- les éventuelles autres personnes susceptibles de constituer des ressources pour lui au sein de son entourage actuel et passé (membres de la fratrie, famille élargie, amis, parents d’amis, professionnels l’ayant précédemment accompagné, etc.)¹⁰² ;
- la façon dont il souhaiterait voir ces autres personnes ressources associées à son accompagnement et aux soins.

Après évaluation et sous réserve de l’accord du juge des enfants en cas de mesure judiciaire, les personnes ressources identifiées peuvent par exemple :

- être mobilisées pour accompagner l’enfant à des rendez-vous, voire pour y participer, par exemple pour soutenir l’enfant, être informées sur ses soins, apporter leur point de vue sur la situation ;
- être contactées dans certaines circonstances particulières à définir (situation de crise, hospitalisation, etc.).

¹⁰⁰ Sous réserve de l’opposition éventuelle de la personne mineure, tel que prévu par l’article L. 1111-5 du code de la santé publique, mentionné dans les repères juridiques du présent document.

¹⁰¹ Sous réserve de l’opposition éventuelle de la personne mineure, tel que prévu par l’article L. 1111-5 du code de la santé publique, mentionné dans les repères juridiques du présent document.

¹⁰² Pour plus d’informations sur la personne de confiance et les parrain, marraine et mentor susceptibles d’être mobilisés autour de l’enfant, consulter l’encadré « points de repère » de la R17.

6. Coordination avec d'autres acteurs impliqués dans le parcours d'accompagnement et de soins (PE, PSY & autres acteurs)

6.1. Coordination avec la médecine générale et la pédiatrie (PE, PSY & autres acteurs)

Ces recommandations sont complémentaires aux recommandations et points de vigilance du chapitre 1.1.

Pour les enfants protégés souffrant de troubles psychiques/TND, une coordination tripartite entre protection de l'enfance, psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et médecine générale/pédiatrie est d'autant plus importante que les symptômes psychiques et somatiques interagissent fréquemment :

- une détresse psychologique peut en effet s'exprimer par des symptômes somatiques ;
- des maladies somatiques ou leurs traitements peuvent avoir des conséquences psychiatriques ;
- et des troubles psychiatriques peuvent être associés à des complications somatiques (47).

R50 **PE PSY & autres acteurs** – Il est important que, sur un territoire donné, une organisation en réseau permette :

- aux professionnels de protection de l'enfance (par l'intermédiaire du médecin référent protection de l'enfance notamment) de disposer de contacts de médecins généralistes et/ou de pédiatres susceptibles d'assurer le suivi, avec un objectif de stabilité et de continuité, des enfants ayant une mesure de protection de l'enfance (lorsqu'ils ne sont pas déjà suivis par un médecin généraliste ou un pédiatre ou que la poursuite de ce suivi n'est pas jugée souhaitable au regard de l'intérêt de l'enfant) ;
- en lien avec les professionnels de protection de l'enfance :
 - aux professionnels de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent de joindre facilement un médecin généraliste ou un pédiatre lorsqu'ils identifient un besoin de soins somatiques chez un enfant protégé,
 - aux médecins généralistes et pédiatres de joindre facilement un professionnel de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent lorsqu'ils repèrent un besoin d'évaluation psychiatrique chez un enfant protégé.

Les CPTS peuvent contribuer à l'atteinte de ces objectifs par une coordination interprofessionnelle au niveau d'un bassin de population, en lien et en complémentarité avec les dispositifs potentiellement impliqués dans la coordination des parcours de santé des enfants ayant une mesure de protection de l'enfance (dispositifs d'appui à la coordination [DAC] dans le cadre de parcours de santé complexes, plateformes de coordination et d'orientation [PCO] dans les situations qui le nécessitent, etc.).

Points de repère

- « Les examens sont faits soit par le médecin traitant de l'enfant soit par un autre médecin choisi par les parents de l'enfant ou par les personnes titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou les personnes ou services à qui l'enfant a été confié¹⁰³. »
- Le choix du médecin traitant de l'enfant fait partie des actes non usuels. Il se fait en concertation avec les parents au début de la mesure de protection de l'enfance, en prenant en compte l'intérêt de l'enfant¹⁰⁴ et en lui demandant son avis.

R51 **PE** – Lorsqu'un enfant a un suivi psychiatrique, le référent de l'enfant en protection de l'enfance (référent ASE ou référent au sein de la structure chargée de la mise en œuvre de la mesure le cas échéant) transmet :

- les coordonnées actualisées du médecin généraliste, du pédiatre ou du médecin de PMI qui suit l'enfant au référent du parcours de soins de l'enfant au sein de l'équipe de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent (cf. R21) ou au psychiatre ou psychologue qui le prend en charge en libéral ;
- les coordonnées actualisées du référent du parcours de soins de l'enfant au sein de l'équipe de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent (cf. R21), du psychiatre libéral ou du psychologue libéral au médecin généraliste, au pédiatre ou au médecin de PMI qui le suit.

R52 **PE & autres acteurs** – Lors de la première consultation avec un médecin généraliste, pédiatre ou médecin de PMI, les professionnels de protection de l'enfance lui transmettent les informations concernant le parcours de l'enfant en protection de l'enfance qui sont strictement nécessaires à sa prise en charge. Ces informations sont actualisées et complétées au minimum une fois par an et à chaque changement significatif concernant la situation de l'enfant et/ou son accompagnement en protection de l'enfance.

Au moment du bilan de santé et de prévention, au minimum une fois par an et à chaque changement significatif dans l'état de santé ou l'accompagnement de l'enfant, le médecin généraliste, le pédiatre ou le médecin de PMI qui suit l'enfant transmet les informations strictement nécessaires à l'accompagnement/à la prise en charge de l'enfant :

- au sein des services de l'ASE : au(x) professionnel(s) au(x)quel(s) le suivi de la santé de l'enfant a été confié (psychologue référent de l'enfant, médecin référent protection de l'enfance, ou autre(s) professionnel(s) de santé) ;
- et/ou, au sein de la structure autorisée ASE et/ou PJJ chargée de la mise en œuvre de la mesure le cas échéant : au psychologue ou au référent éducatif de l'enfant (ou à un professionnel de santé le cas échéant).

Ces informations permettent de nourrir le volet « développement, santé physique et psychique » du PPE et du rapport de situation.

¹⁰³ Article R. 2132-1 du code de la santé publique.

¹⁰⁴ Guide de la DGCS « L'exercice des actes relevant de l'autorité parentale pour les enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance » (23).

R53 **PSY & autres acteurs** – Au minimum une fois par an et à chaque changement significatif dans la prise en charge ou l'accompagnement de l'enfant :

- le référent du parcours de soins de l'enfant au sein de l'équipe de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent (cf. R21) transmet au médecin généraliste, pédiatre ou médecin de PMI qui suit l'enfant les informations strictement nécessaires à sa prise en charge. Il peut notamment s'agir d'éléments relatifs au projet thérapeutique, aux prescriptions médicamenteuses et aux modalités de surveillance du traitement ;
- le médecin généraliste, le pédiatre ou le médecin de PMI qui suit l'enfant transmet au référent du parcours de soins de l'enfant au sein de l'équipe de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent (cf. R21) les informations strictement nécessaires à la prise en charge de l'enfant.

Ces informations sont transmises de façon sécurisée, par tout moyen garantissant la confidentialité, en privilégiant des documents uniques d'interface entre les deux champs.

La transmission d'informations peut être effectuée par courrier, par messagerie sécurisée, par un partage via l'espace numérique de l'enfant « Mon espace santé » s'il est actif¹⁰⁵ ou via un autre dossier informatisé partagé ayant été développé le cas échéant.

Il est souhaitable qu'une réflexion soit coordonnée par le médecin référent protection de l'enfance au sein de chaque département afin de formaliser et tracer les circuits d'échange et de partage d'informations.

La coordination des informations pouvant être échangées ou partagées est assurée respectivement par le psychiatre en charge du suivi de l'enfant concerné et par le médecin généraliste, pédiatre ou médecin de PMI qui suit l'enfant.

Pour chaque enfant, les identités des personnes autorisées à accéder aux informations échangées ou partagées sont définies, tracées et actualisées régulièrement.

¹⁰⁵ Sous réserve de l'opposition éventuelle de la personne mineure, tel que prévu par l'article L. 1111-13-1 du code de la santé publique, mentionné dans les repères juridiques du présent document.

6.2. Coordination avec le champ médico-social pour les enfants ayant (ou ayant besoin d') un accompagnement en lien avec des troubles psychiques/TND (PE & PSY)

Ces recommandations relatives à la coordination entre protection de l'enfance, psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et médico-social concernent les situations dans lesquelles un enfant ayant une mesure de protection de l'enfance et étant suivi par la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent :

- a un besoin d'accompagnement médico-social en lien avec des troubles psychiques/TND ;
- ou a un accompagnement médico-social en lien avec des troubles psychiques/TND.

R54 **PE** – Pour faciliter l'accès à un accompagnement médico-social pour les enfants ayant un besoin en lien avec des troubles psychiques/TND, les interlocuteurs « psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent » identifiés au sein de la protection de l'enfance¹⁰⁶ (cf. R7) ont également dans leurs missions de faire le lien si nécessaire avec la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) et les structures du champ du handicap.

Ainsi, ils peuvent notamment :

- soutenir les démarches pour les enfants ne bénéficiant pas encore de notification MDPH, par exemple en aidant les professionnels référents de l'enfant en protection de l'enfance et en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent dans le montage du dossier, en lien avec les parents ;
- assurer le lien avec les professionnels référents tout au long du processus de traitement du dossier et les appuyer, après la notification MDPH, dans la recherche d'une structure médico-sociale adaptée ;
- lorsque la notification MDPH ne peut être mise en œuvre ou en cas de rupture dans le parcours, par exemple faute de places, soutenir les professionnels référents dans la mobilisation des ressources présentes sur le territoire afin de mettre en place des solutions alternatives.

Lorsqu'un accompagnement médico-social est mis en place pour un enfant, son référent (référént ASE ou référent de la structure chargée de la mise en œuvre de la mesure le cas échéant) prend le relais de l'interlocuteur « psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent » identifié au sein de la protection de l'enfance et assure le lien avec la structure médico-sociale concernée.

R55 **PE & PSY** – Lorsqu'un besoin d'accompagnement médico-social en lien avec des troubles psychiques/TND est identifié pour un enfant disposant déjà d'une prise en charge psychiatrique, l'interlocuteur « psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent » identifié au sein de la protection de l'enfance mobilise le référent du parcours de soins de l'enfant au sein de l'équipe de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent (cf. R21) pour l'appuyer dans la réalisation des démarches d'orientation vers la MDPH (rédaction du volet médical du dossier en particulier), en lien avec le médecin généraliste, le pédiatre ou le médecin de PMI qui suit l'enfant.

R56 **PE** – Pour les enfants ayant un accompagnement médico-social en lien avec des troubles psychiques/TND, le référent protection de l'enfance (référént ASE ou référent de la structure chargée de la mise en œuvre de la mesure le cas échéant) associe le référent de la structure médico-sociale concernée au processus d'élaboration et d'actualisation du PPE et à l'élaboration du volet « développement, santé physique et psychique » du rapport sur la situation de l'enfant.

¹⁰⁶ Au sein du conseil départemental, de la DT PJJ et à l'échelon de chaque établissement ou service de la protection de l'enfance.

Point de vigilance

Pour les enfants n'ayant pas encore bénéficié d'un PPE, à défaut, le référent de la structure médico-sociale est invité à participer à l'élaboration du projet personnalisé d'accompagnement¹⁰⁷ par la structure chargée de la mise en œuvre de la mesure de protection de l'enfance.

Si nécessaire, des temps de rencontre complémentaires sont programmés entre les acteurs.

Au-delà de ces temps de réunion, le référent protection de l'enfance veille à ce que le référent médico-social soit destinataire des informations nécessaires au bon déroulement de l'accompagnement de l'enfant.

¹⁰⁷ Le projet personnalisé d'accompagnement comporte un volet santé, élaboré en cohérence avec les axes définis dans le cadre du PPE le cas échéant. Pour plus d'informations, consulter l'annexe 5 – Points de repère concernant le projet pour l'enfant (PPE).

6.3. Coordination avec la psychiatrie de l'adulte (PE, PSY & autres acteurs)

Ces recommandations relatives à la coordination entre psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, psychiatrie de l'adulte et protection de l'enfance concernent les situations dans lesquelles le (ou les) parent(s) d'un enfant ayant une mesure de protection de l'enfance souffre(nt) d'un trouble psychique/TND.

La coordination nécessaire entre psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et psychiatrie de l'adulte afin d'assurer une continuité au moment où un adolescent ou un jeune adulte, dans le cadre de son suivi psychiatrique, passe d'un service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent vers un service de psychiatrie de l'adulte fait partie des travaux inscrits au programme « santé mentale et psychiatrie » de la HAS.

R57 **PSY** – Pour faciliter l'accès aux soins de parents [d'enfants protégés] souffrant de troubles psychiques/TND, l'interlocuteur « protection de l'enfance » identifié au sein de la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent pour assurer le lien avec la protection de l'enfance (cf. R10) a également dans ses missions d'orienter les demandes éventuelles vers les services de psychiatrie de l'adulte.

R58 **PE & PSY** – Lorsqu'un parent est déjà suivi par la psychiatrie de l'adulte, le référent de l'enfant en protection de l'enfance (référent ASE ou référent de la structure chargée de la mise en œuvre de la mesure le cas échéant) peut, sous réserve de l'accord du parent concerné et en respectant le cadre juridique lié à l'échange et au partage d'informations entre professionnels, prendre contact avec les professionnels suivant le parent en psychiatrie de l'adulte. Cette démarche peut notamment permettre :

- une réflexion conjointe sur les modalités pratiques des droits de visite et d'hébergement le cas échéant (en particulier en cas d'hospitalisation à temps plein du parent), pour qu'ils se déroulent dans les meilleures conditions possibles au regard de la situation ;
- selon son âge, son degré de maturité et s'il en exprime la demande, d'apporter des éléments de compréhension à l'enfant ou idéalement de créer les conditions pour que le parent puisse expliquer lui-même son trouble psychique/TND à son enfant.

Si l'enfant est suivi par une structure de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, le référent du parcours de soins de l'enfant au sein de l'équipe de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent (cf. R21) est associé à la démarche.

7. Co-construction d'un cadre collaboratif global entre protection de l'enfance et psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et acculturation¹⁰⁸ réciproque (PE & PSY)

7.1. Formalisation d'objectifs partagés et de modalités de coordination au niveau de chaque territoire (PE & PSY)

R59 **PE & PSY** – La question de la coordination entre protection de l'enfance et psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent est abordée dans le cadre des documents de référence dédiés à la définition des politiques publiques aux niveaux régional et départemental :

- dans le champ sanitaire : projet régional de santé (PRS), incluant le schéma régional de santé ;
- dans le champ de la protection de l'enfance : schémas départementaux « protection de l'enfance » ou « enfance famille » des conseils départementaux¹⁰⁹ et projets territoriaux de la PJJ¹¹⁰.

Il est essentiel que le PRS, les schémas départementaux « protection de l'enfance » ou « enfance famille » et les projets territoriaux de la PJJ soient élaborés en cohérence et en associant des représentants des deux champs afin que puissent être définies conjointement les orientations et les actions à mener pour améliorer la coordination entre les acteurs.

R60 **PE & PSY** – L'instance de gouvernance de chaque projet territorial de santé mentale (PTSM) veille à ce que la question de la coordination entre protection de l'enfance et psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent soit intégrée au PTSM et à ce que des représentants de la protection de l'enfance (représentants du conseil départemental¹¹¹ et de la DT PJJ, acteurs gérant une ou des structures autorisées au titre de l'ASE et/ou de la PJJ) soient mobilisés pour :

- établir un diagnostic partagé des problématiques rencontrées, des ressources disponibles (acteurs de l'accompagnement/du soin, dispositifs de coordination existant entre protection de l'enfance et psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent le cas échéant) et des besoins sur le territoire ;
- identifier conjointement des actions permettant de répondre aux besoins identifiés, voire élaborer conjointement des projets co-portés et les soumettre aux potentiels financeurs s'ils nécessitent des moyens dédiés.

¹⁰⁸ L'acculturation est entendue ici comme le « processus par lequel une personne ou un groupe assimile une culture étrangère à la sienne » (Le Robert).

¹⁰⁹ Articles L. 312-4 et L. 312-5 du code de l'action sociale et des familles, relatifs aux schémas d'organisation sociale et médico-sociale.

Selon les conseils départementaux, la dénomination de ces schémas peut varier (« schéma de prévention et de protection de l'enfance », « schéma de l'enfance et de la famille », etc.), notamment en lien avec leur périmètre, certains conseils départementaux ayant fait le choix de rassembler les schémas relatifs à la protection de l'enfance, à la PMI et/ou aux services aux familles.

¹¹⁰ Article R. 241-7 du code de la justice pénale des mineurs.

¹¹¹ Dont représentant de l'ODPE.

Point de repère : projet territorial de santé mentale (PTSM)^{112, 113, 114}

L'article 69 de la loi de modernisation de notre système de santé prévoit que des PTSM soient élaborés et mis en œuvre dans un objectif d'« amélioration continue de l'accès des personnes concernées à des parcours de santé et de vie de qualité, sécurisés et sans rupture ».

Le PTSM :

- « favorise la prise en charge sanitaire et l'accompagnement social ou médico-social de la personne dans son milieu de vie ordinaire, en particulier par le développement de modalités d'organisation ambulatoires dans les champs sanitaire, social et médico-social ;
- permet la structuration et la coordination de l'offre de prise en charge sanitaire et d'accompagnement social et médico-social ;
- détermine le cadre de la coordination de second niveau et la déclinaison dans l'organisation des parcours de proximité, qui s'appuient notamment sur la mission de psychiatrie de secteur. »

Le PTSM est défini sur la base d'un diagnostic territorial partagé en santé mentale, établi par les acteurs de santé du territoire en vue d'identifier « les insuffisances dans l'offre de prévention et de services sanitaires, sociaux et médico-sociaux et dans l'accessibilité, la coordination et la continuité de ces services, et de préconiser des actions pour y remédier ».

Le PTSM est « élaboré et mis en œuvre à l'initiative des professionnels et établissements travaillant dans le champ de la santé mentale à un niveau territorial suffisant pour permettre l'association de l'ensemble des acteurs » intervenant dans les domaines de prévention, de diagnostic, de soins, de réadaptation et de réinsertion sociale (établissements de santé autorisés en psychiatrie, médecins libéraux, psychologues et ensemble des acteurs de la prévention, du logement, de l'hébergement et de l'insertion notamment).

« Le projet territorial de santé mentale a une durée de 5 ans à compter de la date à laquelle il est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé. »

Des indicateurs d'évaluation y sont inscrits et visent prioritairement à mesurer l'amélioration du parcours des personnes au sein de chaque territoire. Par ailleurs, l'Agence nationale de la performance sanitaire et médico-sociale (ANAP) a débuté en avril 2024 l'évaluation des PTSM arrivés à échéance, cette évaluation portant sur la gouvernance et les actions déployées, pour mesurer leurs effets au sein de chaque territoire.

R61 **PE & PSY** – Des conventions sont signées sur chaque territoire entre protection de l'enfance et psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Elles intègrent notamment :

- les objectifs opérationnels de la coordination entre protection de l'enfance et psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, en cohérence avec les orientations et les actions identifiées dans le cadre des documents de référence précédemment cités ;
- les rôles et engagements de chacun et les modalités de coordination, en reprenant les éléments clés de ces recommandations (identification des interlocuteurs « psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent » et « protection de l'enfance », respectivement au sein de la protection de l'enfance et de la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent (cf. R7 et R10), informations à transmettre telles que définies notamment en R16 et R28, protocole de réponses graduées aux situations de crise comme défini en R29, définition de temps de rencontres, etc.).

¹¹² Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé.

¹¹³ Décret n° 2017-1200 du 27 juillet 2017 relatif au projet territorial de santé mentale.

¹¹⁴ Instruction n° DGOS/R4/DGCS/3B/DGS/P4/2018/137 du 5 juin 2018 relative aux projets territoriaux de santé mentale.

Selon les spécificités des territoires et des organisations (nombre et structuration des acteurs en présence dans chaque champ notamment), ces conventions sont signées :

- entre le conseil départemental et les structures de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent concernées, en lien avec l'ARS ;
- entre la DT PJJ et les structures de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent concernées, en lien avec l'ARS ;
- et éventuellement entre les acteurs gérant une ou des structures autorisées au titre de l'ASE et/ou de la PJJ et les structures de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent concernées.

Ces conventions :

- sont (ré)évaluées (suivi de l'atteinte des objectifs fixés et de l'efficacité des modalités de coordination mises en œuvre, acceptabilité par les professionnels, les enfants concernés et leurs familles, etc.) et adaptées régulièrement, en tenant compte du point de vue des professionnels concernés ;
- tiennent compte des rôles des autres partenaires intervenant dans les soins et l'accompagnement des enfants protégés.

R62 **PE** – Le conseil départemental et la DT PJJ font connaître auprès des acteurs de la protection de l'enfance (professionnels du conseil départemental, de la PJJ, des établissements et services autorisés ASE et/ou PJJ, assistants familiaux, etc.) les structures de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent identifiées sur leur territoire (notamment par l'intermédiaire de l'interlocuteur « psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent » identifié au sein de la protection de l'enfance [cf. R7]).

Par ailleurs, le conseil départemental et la DT PJJ font connaître auprès des acteurs de la protection de l'enfance les objectifs et modalités de coordination définis dans le cadre de la/des convention(s) mentionnée(s) ci-avant, puis s'assurent de leur prise en compte dans les pratiques.

Les acteurs gérant une ou des structures autorisées au titre de l'ASE et/ou de la PJJ ainsi que les structures elles-mêmes intègrent dans leurs documents de référence (contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens [CPOM], projets associatifs, volet santé des projets d'établissement ou de service, etc.) et dans leurs pratiques les objectifs et modalités de coordination définis dans le cadre de la convention.

R63 **PSY** – Les structures de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent font connaître auprès de l'ensemble de leurs services/professionnels les acteurs de la protection de l'enfance et les objectifs et modalités de coordination formalisés dans le cadre de la/des convention(s) mentionnée(s) ci-avant.

7.2. Espaces pluripartenariaux de décision dédiés aux situations individuelles complexes (PE & PSY)

R64 **PE & PSY** – S'il n'existe pas déjà, un espace pérenne pluripartenarial de décision dédié au traitement des situations individuelles complexes¹¹⁵ est mis en place à l'initiative du conseil départemental (échelon départemental, voire infra), en articulation avec les dispositifs de coordination existant notamment dans le champ du handicap (communautés 360, DAC, etc.). Il peut être mobilisé rapidement pour repenser collectivement l'accompagnement/la prise en charge d'un enfant et favoriser la stabilité du placement¹¹⁶. Ses modalités précises de fonctionnement sont clairement définies (situations

¹¹⁵ Les « situations complexes » sont définies ici comme les situations d'enfants ayant connu/connaissant de nombreuses ruptures dans leur parcours.

¹¹⁶ Par opposition aux (et en complément des) espaces de rencontres pluripartenariaux destinés à permettre des échanges réguliers sur les pratiques, hors situations individuelles (partie 7.3).

concernées, répartition des rôles, coordination, animation et secrétariat, modalités de saisine, fréquence et modalités d'organisation des réunions [en présentiel de préférence], informations susceptibles d'être échangées ou partagées et modalités d'échange ou de partage, etc.).

Il implique au minimum des représentants de la protection de l'enfance (conseil départemental, DT PJJ, organismes gérant des structures autorisées ASE et/ou PJJ), de la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et du champ du handicap, incluant des professionnels pouvant s'engager au titre de leurs institutions. Il peut également mobiliser d'autres représentants du champ sanitaire (acteurs de premier recours notamment) et des représentants des champs de l'enseignement, de la formation et de l'insertion professionnelle.

Il permet l'analyse partagée des situations et la formalisation conjointe des objectifs et des modalités concrètes d'accompagnement/de prise en charge à mettre en place par les acteurs concernés. Pour chaque situation abordée, des points réguliers sont programmés afin de suivre l'évolution de la situation de l'enfant concerné. Lorsqu'une réunion est mobilisée en urgence pour un enfant nécessitant une solution d'accueil immédiate, une solution à moyen, voire long terme est également élaborée.

Points de vigilance

- Les professionnels présents ne participant ni à l'accompagnement ni à la prise en charge d'un enfant dont la situation est abordée quittent momentanément la réunion.
- Si un regard tiers de professionnels n'accompagnant pas le(s) enfant(s) concerné(s) est jugé nécessaire, les situations sont abordées de façon anonymisée.

À ces espaces pluripartenariaux de décision peuvent s'ajouter des espaces pluripartenariaux de réflexion, permettant aux professionnels d'échanger avec les professionnels d'autres structures sur des situations individuelles complexes anonymisées.

Points de repère : les comités départementaux pour la protection de l'enfance

Dans le cadre du décret n° 2022-1730 du 30 décembre 2022, plusieurs conseils départementaux expérimentent la mise en œuvre d'un comité départemental pour la protection de l'enfance pluri-institutionnel intégrant notamment, pour le champ sanitaire, le directeur de l'ARS ou son représentant. Cette « instance stratégique de coordination et de décision » a pour mission d'« assurer la coordination interinstitutionnelle de tous les acteurs de la protection de l'enfance et [de] veille[r] à la cohérence de leurs interventions ».

Par ailleurs, « dans les territoires où il n'existe pas de commissions traitant des situations complexes », le décret prévoit que « le comité se réunit en formation restreinte pour coordonner les actions menées pour la prise en charge d'un mineur ou d'un majeur âgé de moins de vingt et un ans, lorsqu'elle se caractérise par une particulière complexité, ou pour apporter une réponse coordonnée à un dysfonctionnement grave intervenu dans la prise en charge d'un mineur ou d'un majeur âgé de moins de vingt et un ans au titre de la protection de l'enfance ».

7.3. Espaces visant à favoriser l'interconnaissance et l'acculturation réciproque entre professionnels, hors traitement des situations individuelles (PE & PSY)

R65 **PE & PSY** – Dans chaque département, l'ODPE se met en lien avec l'instance de gouvernance du(des) PTSM¹¹⁷ afin de réaliser un état des lieux des espaces de rencontre destinés à favoriser l'interconnaissance entre la protection de l'enfance et la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et à permettre des échanges sur les pratiques. Les conseils locaux de santé (CLS), conseils locaux de santé mentale (CLSM) et toute commission créée par les collectivités territoriales pour traiter de santé mentale peuvent également être mobilisés.

L'état des lieux permet d'identifier, pour chacun des espaces concernés, ses objectifs, la structure « porteuse » le cas échéant, les acteurs participants, les modalités concrètes de rencontre (lieu, fréquence, modalités de définition des thématiques abordées, etc.), les points positifs et les difficultés éventuellement rencontrées.

R66 **PE & PSY** – En fonction des espaces existants et des manques éventuellement identifiés, les acteurs du territoire s'organisent pour mettre en place des espaces permettant des temps d'échanges réguliers sur les pratiques entre les professionnels des deux champs, hors traitement des situations individuelles.

Ces espaces peuvent également être ouverts à d'autres partenaires du territoire : magistrats, autres acteurs du champ sanitaire (acteurs de premier recours, PMI, services des urgences et UAPED notamment), professionnels de la structure en charge de la coordination des parcours de soins des enfants protégés le cas échéant, acteurs du champ médico-social, acteurs de l'Éducation nationale, etc.

Points de vigilance

- Il convient de veiller à ce que ces espaces soient ouverts à l'ensemble des catégories de professionnels dans les deux champs (en incluant les professionnels d'encadrement et les assistants familiaux).
- Il est important de formaliser les engagements de chaque institution et les modalités de participation prévues pour les professionnels (répartition des places par exemple).

Le contenu des rencontres peut être co-élaboré par des représentants des deux champs. Il peut notamment être pertinent :

- d'intégrer des temps de présentation des missions des différents acteurs, de leurs modalités d'actions, des difficultés qu'ils rencontrent et éventuellement des outils mobilisés (PPE/projet personnalisé d'accompagnement ; projet thérapeutique par exemple), afin d'améliorer l'interconnaissance et de lever les représentations négatives ;
- d'organiser des réflexions autour de thématiques de travail communes pour permettre des échanges sur les pratiques entre les deux champs ;
- d'échanger sur le vocabulaire utilisé afin de mettre en évidence les éventuelles divergences entre les deux champs et de favoriser l'émergence d'un langage commun (autour de la notion d'urgence par exemple) ;

¹¹⁷ Le PTSM doit être élaboré à partir d'un diagnostic territorial partagé qui comprend un état des ressources disponibles (cf. article L. 3221-2 du code de la santé publique et point de repère en R60).

- d'utiliser comme supports aux échanges des exemples de situations individuelles anonymisées (« retours d'expérience »), notamment lorsqu'elles ont suscité des tensions entre équipes (par exemple lorsque se pose la question de la nécessité d'une hospitalisation à temps plein), pour mettre collectivement en évidence les éléments susceptibles d'être améliorés.

R67 **PE & PSY** – Les acteurs du territoire s'organisent pour favoriser la mise en place de périodes d'immersion réciproques entre les deux champs. Cette modalité peut être évoquée dans les conventions recommandées en R61.

7.4. Formation (PE & PSY)

Points de repère

Article L. 542-1 du code de l'éducation

« Les médecins, l'ensemble des personnels médicaux et paramédicaux, les travailleurs sociaux, les magistrats, les personnels enseignants, les professionnels des services aux familles définis à l'article L. 214-1 du code de l'action sociale et des familles, les personnels d'animation sportive, culturelle et de loisirs et les personnels de la police nationale, des polices municipales et de la gendarmerie nationale reçoivent une formation initiale et continue, en partie commune aux différentes professions et institutions, dans le domaine de la protection de l'enfance en danger. [...] »

Article L. 226-3-1 du code de l'action sociale et des familles

« Dans chaque département, un observatoire départemental de la protection de l'enfance, placé sous l'autorité du président du conseil départemental, a pour missions :

[...] 5° De réaliser un bilan annuel des formations continues délivrées dans le département en application de l'article L. 542-1 du code de l'éducation, qui est rendu public, et d'élaborer un programme pluriannuel des besoins en formation de tous les professionnels concourant dans le département à la protection de l'enfance. »

Formation continue

R68 **PE & PSY** – Dans chaque département, l'ODPE se met en lien avec l'instance de gouvernance du(des) PTSM afin de mettre en place un comité pédagogique co-porté et pérenne. Ce comité pédagogique a notamment pour missions :

- le recensement des formations existantes organisées par les différents acteurs ;
- l'identification des besoins de formation sur le territoire (il s'appuie notamment sur le bilan réalisé par l'ODPE le cas échéant) ;
- la définition d'un programme pluriannuel de formation continue afin de pallier les manques identifiés ;
- l'identification des possibilités de mutualisation des formations organisées par les acteurs de protection de l'enfance et de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, et des modalités de cette mutualisation le cas échéant (participation au financement en particulier) ;
- la planification et le suivi de formations partagées sur les thématiques identifiées.

La constitution du comité pédagogique et ses modalités d'action font l'objet d'une convention précisant notamment les rôles de chacun ainsi que les moyens mis à disposition.

Le comité pédagogique mobilise des représentants des deux champs et des différents métiers/fonctions :

- pour la protection de l'enfance : des représentants du conseil départemental, de la DT PJJ et de l'ensemble des organismes gestionnaires d'établissements et services autorisés au titre de l'ASE et/ou de la PJJ présents sur le territoire ;
- pour la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent : des représentants de tous les établissements de santé ayant une autorisation d'activité en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et des CMPP.

Il mobilise également des représentants de la (des) MDA et des acteurs de la formation présents dans le département ainsi que, le cas échéant, des représentants de la structure en charge de la coordination des parcours de soins des enfants protégés.

Point de vigilance

Il est important que les membres du comité pédagogique puissent s'engager au titre de leurs institutions. Dans le cas contraire, il convient d'organiser un niveau de validation.

R69 **PE & PSY** – Dans le cadre de l'élaboration du programme pluriannuel de formation évoqué en R68, le comité pédagogique veille à :

- renouveler régulièrement les formations proposées afin de permettre :
 - la formation des nouveaux professionnels,
 - la mise à jour/l'ancrage des connaissances ;
- organiser des échanges réguliers entre les professionnels déjà formés sur la mise en œuvre des acquis dans leurs pratiques ;
- associer des apports de connaissances théoriques et pratiques, en tenant compte de la pluralité des approches, ainsi que des retours d'expériences ;
- intégrer des temps de présentation des acteurs de la protection de l'enfance et de la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et de leurs missions, afin d'améliorer l'interconnaissance.

Points de vigilance

- Il convient de veiller à ce que les formations soient ouvertes à l'ensemble des catégories de professionnels dans les deux champs (en incluant les professionnels d'encadrement et les assistants familiaux).
- Il est important de veiller à ce que les temps de formation ne deviennent pas des espaces de concertation autour des situations individuelles accompagnées conjointement par les participants.

R70 **PE & PSY** – Dans le champ de la protection de l'enfance, le conseil départemental et les acteurs gérant une ou des structures autorisées au titre de l'ASE s'assurent que tous les professionnels (en incluant les professionnels d'encadrement et les assistants familiaux) bénéficient, dans l'année de leur prise de poste, d'une formation portant sur les enjeux spécifiques à prendre en compte pour les enfants accompagnés, et notamment sur les conséquences :

- de la maltraitance¹¹⁸ (impacts sur la santé mentale et physique, le développement de l'enfant, la construction psychique, besoins spécifiques¹¹⁹, etc.) ;

¹¹⁸ Incluant, comme précisé en introduction, les violences et les négligences.

¹¹⁹ La démarche de consensus sur les besoins fondamentaux de l'enfant en protection de l'enfance (48) a insisté sur les besoins *spécifiques* engendrés par l'exposition à la maltraitance. Ces besoins spécifiques s'ajoutent aux besoins *universels* communs à

- de la séparation et du placement le cas échéant.

Parallèlement, dans le champ de la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, chaque structure de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent s'assure que tous les professionnels, au moment de leur prise de poste, bénéficient d'une formation portant sur la protection de l'enfance.

Point de vigilance

Pour que ces recommandations soient applicables, il est indispensable dans les deux champs :

- de reconnaître le temps de formation comme un temps de travail à part entière et comme un enjeu pour l'employeur comme pour le salarié, à évoquer dès le recrutement ;
- pour les cadres, d'avoir une vigilance sur les non-inscriptions et les annulations de formations, afin de s'assurer que chaque professionnel se forme régulièrement.

R71 **PE & PSY** – En complément des formations évoquées en R70¹²⁰, il convient que l'ensemble des professionnels des deux champs intervenant dans l'accompagnement et la prise en charge des MNA bénéficie de temps de sensibilisation/formation concernant :

- les risques de psychotraumatismes spécifiquement liés aux expériences vécues dans le pays d'origine, pendant le parcours migratoire et à l'arrivée en France ;
- l'impact du contexte culturel d'origine des enfants en termes de rapport au soin et aux professionnels de santé.

R72 **PE PSY & autres acteurs** – Il apparaît également important de favoriser l'acquisition de repères communs entre les acteurs de la protection de l'enfance, de la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et de la psychiatrie de l'adulte, notamment sur :

- l'importance de la relation mère-bébé sur le développement du bébé ;
- les interactions parents-enfant, pour permettre de repérer les difficultés éventuelles, d'évaluer l'opportunité de contacts entre les parents et l'enfant et de définir leurs modalités pertinentes le cas échéant (fréquence, présence éventuelle d'un tiers, etc.) ;
- les conséquences éventuelles des troubles psychiques/TND susceptibles d'être rencontrés chez les parents sur leurs capacités à répondre aux besoins de l'enfant. L'enjeu est notamment que les professionnels ne se limitent pas exclusivement à l'existence d'un diagnostic psychiatrique chez l'un des parents pour évaluer sa capacité à répondre aux besoins de l'enfant, et en particulier puissent faire la différence entre :
 - les situations dans lesquelles il est possible d'anticiper les difficultés et les risques pour l'enfant et de mettre éventuellement en place des réponses aux besoins de compensation,
 - les situations dans lesquelles il est plus complexe d'anticiper les difficultés et les risques mais qui peuvent être transitoires (pathologies psychiatriques non stabilisées par exemple) ;
- les modalités possibles de partage d'informations entre protection de l'enfance, psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et psychiatrie de l'adulte autour des situations relevant de la protection de l'enfance ;
- les spécificités du cadre juridique qui s'applique en termes d'autorité parentale dans les situations relevant de la protection de l'enfance.

l'ensemble des enfants. Peuvent également s'ajouter pour certains enfants des besoins *particuliers*, notamment en lien avec une situation de handicap, ainsi que des besoins liés aux effets iatrogènes de la prise en charge (ou non-prise en charge) en protection de l'enfance, comme évoqué dans l'introduction.

Pour plus d'informations, consulter l'annexe 3 – Points de repère concernant les besoins fondamentaux en protection de l'enfance.

¹²⁰ Et en lien avec les points de vigilance évoqués en R1 concernant le bilan de santé, l'évaluation et les soins.

Formation initiale

R73 **PE & PSY** – Il serait intéressant que puisse être proposé, dans le cadre de la formation initiale des différentes professions concernées (professionnels de santé, psychologues, travailleurs sociaux notamment), un enseignement en protection de l'enfance/santé mentale, selon le champ avec lequel les futurs professionnels vont être amenés à collaborer.

R74 **PE & PSY** – Par ailleurs, il serait intéressant de favoriser des rencontres entre les futurs professionnels des différentes disciplines dès la formation initiale via l'organisation de temps communs/partagés dans le cadre de ces enseignements et/ou de stages d'immersion.

Table des annexes

Annexe 1. Recommandations HAS complémentaires à la présente recommandation sur la coordination entre protection de l'enfance et psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent	80
Annexe 2. Complément aux repères juridiques relatifs à l'échange et au partage d'informations entre professionnels	81
Annexe 3. Points de repère concernant les besoins fondamentaux en protection de l'enfance	84
Annexe 4. Points de repère concernant l'interprétariat linguistique dans le domaine de la santé	85
Annexe 5. Points de repère concernant le projet pour l'enfant (PPE)	86

Annexe 1. Recommandations HAS complémentaires à la présente recommandation sur la coordination entre protection de l'enfance et psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent

Recommandations et parcours de soins spécifiques à la prévention, au repérage, à l'évaluation et à la prise en charge de certains troubles

Les recommandations et parcours de soins suivants sont consultables sur le site internet de la HAS :

- [TDAH : diagnostic et interventions thérapeutiques auprès des enfants et adolescents \(2024\)](#) ;
- [Idées et conduites suicidaires chez l'enfant et l'adolescent : prévention, repérage, évaluation et prise en charge \(2021\)](#) ;
- [Troubles du neurodéveloppement – Repérage et orientation des enfants à risque \(2020\)](#) ;
- [Boulimie et hyperphagie boulimique : repérage et éléments généraux de prise en charge \(2019\)](#) ;
- [Trouble du spectre de l'autisme \(TSA\) : signes d'alerte, repérage, diagnostic et évaluation chez l'enfant et l'adolescent \(2018\)](#) ;
- [Comment améliorer le parcours de santé d'un enfant avec troubles spécifiques du langage et des apprentissages \(2018\)](#) ;
- [Patient avec un trouble bipolaire : repérage et prise en charge initiale en premier recours \(2015\)](#) ;
- [Conduite à tenir en médecine de premier recours devant un enfant ou un adolescent susceptible d'avoir un trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité \(TDAH\) \(2015\)](#) ;
- [Manifestations dépressives à l'adolescence : repérage, diagnostic et prise en charge en soins de premier recours \(2014\)](#).

Des travaux sont également en cours :

- [Évaluation et prise en charge du trouble de stress post-traumatique](#) ;
- [Trouble du spectre de l'autisme \(TSA\) : interventions et parcours de vie du nourrisson, de l'enfant et de l'adolescent](#).

Un travail est par ailleurs conduit sur [le repérage, l'évaluation, l'orientation et la prise en charge des troubles psychiques en période périnatale](#).

Recommandations du champ protection de l'enfance

Les recommandations suivantes sont consultables sur le site internet de la HAS :

- [Améliorer la prise en charge à la sortie des dispositifs de protection de l'enfance – Volet 2 : l'accès à l'autonomie \(2024\)](#) ;
- [Cadre de référence pour l'évaluation globale de la situation des enfants en danger/risque de danger \(2021\)](#) ;
- [L'accompagnement des mineurs non accompagnés dits « mineurs isolés étrangers » \(2018\)](#) ;
- [Prendre en compte la santé des mineurs/jeunes majeurs dans le cadre des établissements/services de la protection de l'enfance et/ou mettant en œuvre des mesures éducatives \(2015\)](#) ;
- [L'expression et la participation du mineur, de ses parents et du jeune majeur dans le champ de la protection de l'enfance \(2014\)](#) ;
- [L'exercice de l'autorité parentale dans le cadre du placement \(2012\)](#).

Des travaux sont également en cours sur [l'évaluation globale de la situation de l'enfant en cours de mesure de protection de l'enfance](#).

Annexe 2. Complément aux repères juridiques relatifs à l'échange et au partage d'informations entre professionnels

Tableau récapitulatif

Recommandations concernées	Article/code dont relèveraient l'échange et le partage d'information	
	Mesures administratives et mesures judiciaires d'assistance éducative	Mesures pénales
R16 : transmission d'informations de la protection de l'enfance à la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent	Article L. 226-2-2 du code de l'action sociale et des familles (CASF)	Article L. 1110-4 du code de la santé publique (CSP)
R28 : transmission d'informations de la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à la protection de l'enfance	Article L. 226-2-2 du CASF	
R34 : transmission d'informations des professionnels de santé des urgences à la protection de l'enfance	Article L. 226-2-2 du CASF	
R52 : échanges et partages d'informations entre médecin généraliste/pédiatre/médecin de PMI et protection de l'enfance	Article L. 226-2-2 du CASF	
R53 : échanges et partages d'informations entre médecin généraliste/pédiatre/médecin de PMI et psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent	Appréciation au cas par cas du cadre qui s'applique	

Illustrations des recommandations R28, R36, R52 et R53 par des exemples de transmissions d'informations (dans le cadre de mesures administratives et de mesures judiciaires d'assistance éducative)

Recommandation R28 – Illustrations de transmissions d'informations susceptibles de relever de l'article L. 226-2-2 du CASF

- Au plus tard un an après le début de la prise en charge en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent d'un enfant protégé ayant des troubles psychiques/TND : transmission par la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent d'informations sur le déroulement des soins psychiatriques, les difficultés éventuellement rencontrées (absence aux consultations par exemple) et les éléments permettant aux professionnels de protection de l'enfance d'identifier d'éventuels signes d'aggravation. ;
- À la suite d'une sollicitation des professionnels de protection de l'enfance chargés d'élaborer le rapport sur la situation de l'enfant en amont de l'échéance de la mesure : apport par les professionnels de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent d'informations permettant de nourrir le volet « développement, santé physique et psychique » (éléments d'évaluation sur la santé physique et psychique de l'enfant et son évolution depuis le début de la prise en charge en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent/la précédente évaluation, informations sur la mise en œuvre du projet thérapeutique [dont difficultés éventuellement rencontrées], en lien avec les axes définis dans le cadre du PPE, avis sur l'opportunité de poursuivre les soins et/ou d'ajuster les modalités de suivi et d'accompagnement).

- Dans le cadre d'une aggravation ou amélioration des symptômes cliniques et/ou du niveau de fonctionnement chez un enfant protégé ayant un trouble psychique/TND : information des professionnels de la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent aux professionnels de protection de l'enfance sur les adaptations effectuées concernant les thérapeutiques (médicamenteuses et/ou non médicamenteuses).
- En cas d'évolution du traitement médicamenteux pour un enfant protégé ayant des troubles psychiques/TND : information des professionnels de la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent aux professionnels de protection de l'enfance sur ces évolutions et sur les effets secondaires pouvant éventuellement survenir.
- Si des évolutions des modalités de prise en charge pour un enfant protégé accompagné en CMP (mise en place, en complément, d'une prise en charge en CATTP, en hôpital de jour ou d'hospitalisations à temps plein séquentielles par exemple) sont identifiées comme nécessaires par la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent : information des professionnels de la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent aux professionnels de protection de l'enfance sur ces évolutions, certaines pouvant notamment avoir un impact sur l'organisation du quotidien.

Recommandation R34 – Illustrations de transmissions d'informations susceptibles de relever de l'article L. 226-2-2 du CASF

- À la suite d'une situation ayant conduit les professionnels de protection de l'enfance à recourir aux urgences pour des signes évocateurs de troubles psychiques/TND chez un enfant protégé (y compris à la suite d'une crise associée à un épisode de violence) ou à la suite d'une tentative de suicide :
 - information des professionnels de santé des urgences aux professionnels de protection de l'enfance sur les thérapeutiques prescrites et sur le suivi d'effets secondaires pouvant éventuellement survenir,
 - information sur les modalités de soins psychiatriques à mettre en place et transmission des éléments nécessaires pour assurer la suite de la prise en charge,
 - information sur la conduite à tenir en cas de nouvelle crise,
 - en cas de tentative de suicide : information sur une éventuelle inclusion dans un dispositif de veille et de recontact adapté aux enfants et aux adolescents suicidants.

Recommandation R52 – Illustrations de transmissions d'informations susceptibles de relever de l'article L. 226-2-2 du CASF

- En amont de la première consultation d'un enfant ayant une mesure de protection de l'enfance avec un médecin généraliste/pédiatre/médecin de PMI, par exemple pour la réalisation du bilan de santé et de prévention : transmission par les professionnels de protection de l'enfance d'éléments concernant le contexte ayant conduit à la mise en œuvre de la mesure et les objectifs de la mesure.
- À la suite d'une consultation de suivi avec un médecin généraliste/pédiatre/médecin de PMI : transmission par le médecin généraliste/pédiatre/médecin de PMI au(x) professionnel(s) de protection de l'enfance au(x)quel(s) le suivi de la santé de l'enfant a été confié d'éléments relatifs à l'évolution de son état de santé rendant nécessaires une adaptation de son accompagnement et/ou la mise en place d'une orientation vers la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent.

Recommandation R53

Illustrations de transmissions d'informations susceptibles de relever l'article L. 1110-4 du CSP

- Transmission des ordonnances de médicaments de l'équipe de psychiatrie suivant un enfant protégé ayant un trouble psychique/TND au médecin généraliste qui le suit (devant notamment permettre d'éviter les interactions médicamenteuses).
- Transmission par le médecin généraliste au référent du parcours de soins de l'enfant au sein de l'équipe de psychiatrie d'éléments relatifs à une maladie somatique identifiée chez un enfant protégé suivi pour un trouble psychique/TND (éléments nécessaires aux soins et à leur coordination).

Illustrations de transmissions d'informations susceptibles de relever de l'article L. 226-2-2 du CASF

- À la suite de la réalisation du bilan de santé et de prévention (obligatoire à l'entrée en protection de l'enfance) par un médecin généraliste/pédiatre/médecin de PMI, l'enfant est orienté vers la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent pour une évaluation. En amont de cette évaluation (organisée en lien avec la protection de l'enfance), le médecin généraliste/pédiatre/médecin de PMI ayant réalisé le bilan transmet directement à la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent les éléments cliniques ayant motivé la proposition d'orientation.
- Dans le cadre d'un examen médical devant permettre l'élaboration du volet santé physique et psychique du rapport sur la situation de l'enfant, le médecin généraliste/pédiatre/médecin de PMI qui suit l'enfant diagnostique une maladie somatique chez un enfant suivi par la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent pour un trouble psychique/TND. Dans les suites directes de ce bilan, le MG/pédiatre/médecin de PMI l'ayant réalisé transmet directement à la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent les traitements ayant été initiés.

Annexe 3. Points de repère concernant les besoins fondamentaux en protection de l'enfance

La loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant a défini l'objectif de la protection de l'enfance comme étant de « garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l'enfant, [...] soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social et [...] préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation, dans le respect de ses droits¹²¹ ».

Après sa promulgation, une démarche de consensus pluridisciplinaire a été mise en œuvre pour élaborer des repères communs sur les besoins fondamentaux de l'enfant en protection de l'enfance (48).

Elle a mis en évidence les besoins fondamentaux suivants, présentés ici sous forme de classification (11) :

- des besoins universels, dont la satisfaction est nécessaire pour tout enfant/adolescent afin de permettre son bon développement et son bien-être :
 - un « méta-besoin » de sécurité, qui comprend :
 - les besoins physiologiques et de santé,
 - le besoin de protection,
 - le besoin de sécurité affective et relationnelle,
 - quatre « autres besoins fondamentaux et universels » :
 - le besoin d'expériences et d'exploration du monde,
 - le besoin d'un cadre de règles et de limites,
 - le besoin d'identité,
 - le besoin d'estime de soi et de valorisation de soi ;
- des besoins spécifiques, engendrés par l'exposition à la maltraitance le cas échéant ;
- des besoins particuliers, pour les enfants/adolescents en situation de handicap ou ayant une problématique médicale ;
- des besoins liés aux effets iatrogènes de la prise en charge (ou non-prise en charge) en protection de l'enfance.

¹²¹ Article L. 112-3 du code de l'action sociale et des familles.

Annexe 4. Points de repère concernant l'interprétariat linguistique dans le domaine de la santé

Dans son référentiel de compétences, formation et bonnes pratiques « [Interprétariat linguistique dans le domaine de la santé](#) » (49), la HAS souligne que l'intervention d'un interprète est « particulièrement importante à certains temps forts de la prise en charge du patient » et cite notamment la consultation initiale et les entretiens avec un psychologue ou psychiatre.

Elle précise que « seul le recours à un interprète professionnel permet de garantir d'une part, aux patients/usagers, les moyens de communication leur permettant de bénéficier d'un égal accès aux droits, à la prévention et aux soins de manière autonome et, d'autre part, aux professionnels, les moyens d'assurer une prise en charge respectueuse du droit à l'information, du consentement libre et éclairé du patient et du secret médical. Elle reconnaît néanmoins que d'autres moyens de communication peuvent s'avérer utiles dans les cas où le recours à un interprète professionnel n'est pas possible ».

Sont ainsi distingués :

- l'interprétariat professionnel dans le domaine de la santé, « mode d'interprétation entre deux parties, dans un dialogue direct entre les parties et en leur présence », qui peut exister sous trois formes :
 - en face-à-face, ce qui est présenté comme étant plus adapté à une prise en charge humaine impliquant une relation entre individus,
 - par téléphone, ce qui peut être utile notamment dans certains contextes (urgence, langue rare, etc.) et compte tenu de l'inégalité territoriale d'accès à l'interprétariat physique,
 - ou par vidéo (modalité en cours de mise en place au moment de l'élaboration du référentiel) ;
- les autres moyens de communication : recours à un tiers non formé à l'interprétariat, recours à une langue tierce (par exemple, l'anglais), utilisation d'outils (pictogrammes, sites de traduction en ligne et applications pour smartphones, etc.). La HAS précise que ces moyens de communication sont à considérer avec une grande prudence.

Annexe 5. Points de repère concernant le projet pour l'enfant (PPE)

Un projet pour l'enfant (PPE) est établi pour chaque enfant dans un délai de trois mois à compter du début de la prestation ou de la mesure de protection de l'enfance, en cohérence avec les objectifs de celle-ci¹²². Ce document unique a vocation à accompagner l'enfant tout au long de son parcours et « vise ainsi à assurer la stabilité de ce parcours ainsi que la continuité et la cohérence des actions conduites auprès de l'enfant, de sa famille et de son environnement¹²³ ».

Le président du conseil départemental est le garant du PPE, qui est établi « dans un objectif de construction commune entre les titulaires de l'autorité parentale, l'enfant, les tiers impliqués dans la vie de l'enfant, les services départementaux et, le cas échéant, le service ou l'établissement auquel le juge a confié la mesure¹²⁴ ». En ce sens, il est un outil au service de la coordination entre les différents acteurs.

Le PPE prend en compte les différents domaines de vie de l'enfant, parmi lesquels « le développement, la santé physique et psychique ». Pour chacun des domaines, le PPE intègre :

- « les éléments synthétiques d'évaluation actualisée, et notamment ceux de l'évaluation médicale et psychologique [...] » ;
- les observations et propositions des titulaires de l'autorité parentale, de l'enfant et de son environnement.

« Concernant le domaine de vie relatif au développement, à la santé physique et psychique de l'enfant, les besoins de soins et d'accompagnement sont identifiés, notamment dans les situations de handicap.

Sur la base de ces éléments [...], le projet pour l'enfant définit les objectifs poursuivis et un plan d'action. Ce plan d'action décrit les actions à mener auprès de l'enfant, des titulaires de l'autorité parentale et de son environnement. Il précise également la durée et les dates d'échéance des actions ainsi que les acteurs les mettant en œuvre¹²⁵. »

« Le projet pour l'enfant est actualisé sur la base des rapports de situation établis au moins tous les ans pour les enfants de plus de deux ans et au moins tous les six mois pour les enfants de moins de deux ans. L'actualisation du projet pour l'enfant prend en compte notamment les changements de modalités d'accompagnement¹²⁶. »

Si le projet pour l'enfant est obligatoire depuis 2007¹²⁷, il n'est à ce jour pas mis en place dans l'ensemble des départements et pour l'ensemble des enfants accompagnés dans le champ de la protection de l'enfance (12).

¹²² Article D. 223-14 du code de l'action sociale et des familles.

¹²³ Article D. 223-12 du code de l'action sociale et des familles.

¹²⁴ Article D. 223-13 du code de l'action sociale et des familles.

¹²⁵ Article D. 223-15 du code de l'action sociale et des familles.

¹²⁶ Article D. 223-13 du code de l'action sociale et des familles.

¹²⁷ Article L. 223-1-1 du code de l'action sociale et des familles.

Documents additionnels pour les enfants accompagnés par un établissement ou un service autorisé ASE et/ou PJJ

Document individuel de prise en charge/contrat de séjour

Par ailleurs, pour chaque enfant accompagné par une structure de protection de l'enfance, un document individuel de prise en charge (DIPC) ou un contrat de séjour est établi lors de l'admission pour « défini[r] les objectifs et la nature [...] de l'accompagnement¹²⁸ ». Il reprend les objectifs de la mesure et les axes du PPE dans les différents domaines de vie de l'enfant (dont le domaine « développement, santé physique et psychique »), s'il a été établi en amont de l'admission.

Projet personnalisé d'accompagnement

Par la suite, un projet personnalisé d'accompagnement permet de décliner de façon opérationnelle les objectifs définis et les modalités d'accompagnement. Il est co-construit après une phase d'évaluation partagée qui permet de compléter l'évaluation initiale (notamment grâce aux observations recueillies au quotidien pour les enfants ayant une mesure d'accueil), et régulièrement actualisé au cours de l'accompagnement. Il comporte un volet « développement, santé physique et psychique », élaboré en cohérence avec les objectifs définis dans le cadre du PPE le cas échéant et précisant les modalités de mise en œuvre des actions prévues.

Documents additionnels pour les enfants ayant une notification MDPH

Enfin, les enfants bénéficiant d'une notification MDPH ont également d'autres projets qui doivent s'articuler, *a fortiori* lorsqu'ils sont accompagnés par une structure médico-sociale (plan personnalisé de compensation, projet personnalisé de scolarisation, projet personnalisé d'accompagnement, plan d'accompagnement global pour certains, etc.).

¹²⁸ L'obligation d'établir un document individuel de prise en charge ou un contrat de séjour pour chaque personne accompagnée (article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles) concerne l'ensemble des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, dont les établissements et services de la protection de l'enfance.

Références bibliographiques

1. Haute Autorité de santé. Programme pluriannuel. Psychiatrie et santé mentale 2018-2023. Saint-Denis La Plaine: HAS; 2020.
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3221946/fr/programme-pluriannuel-psychiatrie-et-sante-mentale-2018-2023-mise-a-jour-oct-2020
2. Observatoire national de la protection de l'enfance. Données sur les prises en charge en protection de l'enfance au 31 décembre 2022. Variations départementales et évolutions. Paris: ONPE; 2024.
https://onpe.gouv.fr/system/files/publication/note_24-02_chiffres_et_analyse_prises_en_charge_en_pe_web.pdf
3. Direction de la Protection judiciaire de la jeunesse. Protéger, éduquer, insérer. Paris: Ministère de la justice; 2023.
https://www.justice.gouv.fr/sites/default/files/2023-05/plaquette_PJJ.pdf
4. Tursz A. Les conséquences de la maltraitance dans l'enfance sur la santé physique et mentale à l'âge adulte : approche épidémiologique de santé publique. Rev Fr Affr 2013;(1):32-50.
<https://dx.doi.org/10.3917/rfas.125.0032>
5. Dumaret AC, Guerry E, Crost M. Placements dans l'enfance et devenir à l'âge adulte : insertion générale et qualité de vie liée à la santé. Neuropsychiatr Enfance Adolesc 2011;59(5):289-98.
<https://dx.doi.org/10.1016/j.neurenf.2011.01.003>
6. Bronsard G, Leroux PA, Diallo I, Eleuterio J, Le Bihan A, Boyer L, Lavenne-Collot N. Prevalence of mental disorders in closed educational centers in France. Encephale 2024.
<https://dx.doi.org/10.1016/j.encep.2023.11.026>
7. Centre national de ressources et de résilience. Ressource protection de l'enfance. Lille: Cn2r; 2023.
https://cn2r.fr/wp-content/uploads/2023/05/Ressource_protection_enfance_Cn2r.pdf
8. Heady N, Watkins A, John A, Hutchings H. Prevalence of neurodevelopmental disorders (NDDs) in looked after children (Lac) versus children that are not looked after (non-Lac) and adverse outcomes: A systematic review and Metaanalysis. Research Square. Preprint 2023.
<https://dx.doi.org/10.21203/rs.3.rs-3344908/v1>
9. Bronsard G, Alessandrini M, Fond G, Loundou A, Auquier P, Tordjman S, Boyer L. The prevalence of mental disorders among children and adolescents in the child welfare system: A systematic review and meta-analysis. Medicine (Baltimore) 2016;95(7):e2622.
<https://dx.doi.org/10.1097/MD.0000000000002622>
10. Commission nationale de lutte contre la maltraitance et de promotion de la bientraitance. Démarche nationale de consensus pour un vocabulaire partagé de la maltraitance des personnes en situation de vulnérabilité. Dossier d'appui et annexes. Paris: Ministère des solidarités; 2021.
https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/vocabulaire_partage_de_la_maltraitance_des_personnes_en_situation_de_vulnerabilite_mars_2021-2.pdf
11. Corbet E. Pour que les négligences ne soient plus négligées : prise en compte des besoins fondamentaux de l'enfant. Dans: Balençon M, ed. Pédiatrie médico-légale. Mineurs en danger : du dépistage à l'expertise pour un parcours spécialisé protégé. Paris: Elsevier Masson; 2020. p. 53-65.
12. Bonne B. Rapport d'information fait au nom de la commission des affaires sociales sur l'application des lois relatives à la protection de l'enfance. Paris: Sénat; 2023.
<https://www.senat.fr/rap/r22-837/r22-8371.pdf>
13. Inspection générale des affaires sociales, Cherubini C, Dubosq C, Marquis Samar E, Conrath E. Création d'un organisme national dans le champ de la protection de l'enfance. Paris: IGAS; 2020.
<https://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/2020-006r.pdf>
14. Cour des comptes. La protection de l'enfance. Paris: CC; 2020.
https://www.ccomptes.fr/system/files/2020-11/20201130-rapport-protection-enfance_0.pdf
15. Inspection générale des affaires sociales, Lopez A, Turan-Pelletier G. Organisation et fonctionnement du dispositif de soins psychiatriques, 60 ans après la circulaire du 15 mars 1960. Tome 1. Paris: IGAS; 2017.
https://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/2017-064R-Tome_1_rapport.pdf
16. Inspection générale des affaires sociales, Branchu C, Buchter J, Emmanuelli J, Robineau FM. Mission relative à l'évaluation du fonctionnement des centres d'action médico-sociale précoce (CAMSP), des centres médico-psycho-pédagogiques (CMPP), et des centres médico-psychologiques de psychiatrie infanto-juvénile (CMP-IJ). Paris: IGAS; 2018.
https://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/IGAS2018-005R_version_sept.pdf
17. Chatagner A, Olliac B, Choquet LH, Botbol M, Raynaud JP. Adolescents reçus en urgence en psychiatrie infanto-juvénile. Qui sont-ils ? Quel est leur parcours ? Quel suivi social et/ou judiciaire ? Neuropsychiatr Enfance Adolesc 2015;63(2):124-32.
<https://dx.doi.org/10.1016/j.neurenf.2014.08.003>
18. Conseil économique social et environnemental, Dulin A. Prévenir les ruptures dans les parcours en protection de l'enfance. Paris: CESE; 2018.
https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2018/2018_17_protection_enfance.pdf
19. Défenseur des droits. Handicap et protection de l'enfance : des droits pour les enfants invisibles. Paris: DD; 2015.
https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/rae_2015_accessible.pdf
20. Défenseur des droits. Enfance et violence : la part des institutions publiques. Paris: DD; 2019.

https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/rae-2019-num-22.10.19-2_1.pdf

21. Coldefy M, Faure P, Prieto N. Les enfants et adolescents pris en charge dans les centres médicopsychopédagogiques. Etudes et Résultats 2005;(392):1-8.

22. Chapdelaine MA. Rapport relative à l'autorité parentale et à l'intérêt de l'enfant. Paris: Assemblée nationale; 2014.
<https://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rapports/r1925.pdf>

23. Direction générale de la Cohésion sociale. L'exercice des actes relevant de l'autorité parentale pour les enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance. Paris: Ministère des Solidarités et de la Santé; 2018.
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/guide_acte_usuels.pdf

24. Conseil national de l'Ordre des médecins. Echanges et partage d'informations au sein de l'équipe de soins prenant en charge une personne. Paris: CNOM; 2017.
https://www.conseil-national.medecin.fr/sites/default/files/external-package/rapport1doif2d/cnom_echanges_et_partage_informati ons.pdf

25. Dini M, Meunier M. Rapport d'information fait au nom de la commission des affaires sociales sur la protection de l'enfance. Paris: Sénat; 2014.
<https://www.senat.fr/rap/r13-655/r13-6551.pdf>

26. Milon A, Amiel M. Rapport d'information fait au nom de la mission d'information sur la situation de la psychiatrie des mineurs en France. Paris: Sénat; 2017.
<http://www.senat.fr/rap/r16-494/r16-4941.pdf>

27. Inspection générale des affaires sociales, Inspection générale de la justice, Gazagnes P, Robineau FM, Lods P, Lavergne P, et al. Délais d'exécution des décisions de justice en matière de protection de l'enfance. Paris: IGAS; 2019.
<https://igas.gouv.fr/IMG/pdf/2019-019r.pdf>

28. Haute Autorité de santé. Lettre ouverte du Collège de la HAS à tous ceux qui œuvrent pour la qualité des soins et des accompagnements. Saint-Denis La Plaine: HAS; 2022.
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3328851/fr/lettre-ouverte-du-college-de-la-has-a-tous-ceux-qui-oeuvrent-pour-la-qualite-des-soins-et-des-accompagnements

29. Direction générale de la Cohésion sociale, Association nationale des directeurs de l'action sociale et de santé, Conseil national de la protection de l'enfance. Etat des lieux 2018 de la mise en œuvre des dispositions créées ou renforcées par la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant. Synthèse des résultats. Paris: Ministère des solidarités et de la santé; 2019.
https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/enquete_-_etat_des_lieux_mise_en_oeuvre_dispositions_loi_du_14_mars_2016_-_synthese_resultats.pdf

30. Observatoire national de la protection de l'enfance. La santé des enfants protégés. Seizième rapport au gouvernement et au parlement. Paris: ONPE; 2022.

31. Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux. La réduction des risques et des dommages dans les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques

pour usagers de drogues (CAARUD). Saint-Denis La Plaine: HAS; 2017.

https://www.has-sante.fr/jcms/c_2833719/fr/recommandations-caarud-web

32. Arrêté du 3 juin 2019 relatif à l'expérimentation pour un parcours de soins coordonné des enfants et adolescents protégés. Journal Officiel 2019;16 Juin 2019.

33. Arrêté du 22 décembre 2021 modifiant l'arrêté du 28 novembre 2019 relatif à l'expérimentation pour un parcours de soins coordonné des enfants et adolescents protégés. Journal Officiel 2021;26 décembre 2021.

34. Arrêté du 14 juin 2023 modifiant l'arrêté du 3 juin 2019 relatif à l'expérimentation pour un parcours de soins coordonné des enfants et adolescents protégés. Journal Officiel 2023;18 juin 2023.

35. Arrêté du 19 juillet 2019 relatif à l'expérimentation d'un protocole de santé standardisé appliqué aux enfants ayant bénéficié avant l'âge de cinq ans d'une mesure de protection de l'enfance. Journal Officiel 2019;3 août 2019.

36. Arrêté du 25 octobre 2022 modifiant l'arrêté du 19 juillet 2019 relatif à l'expérimentation Pégase, protocole de santé standardisé appliqué aux enfants ayant bénéficié avant l'âge de cinq ans d'une mesure de protection de l'enfance. Journal Officiel 2022;29 octobre 2022.

37. Première évaluation des besoins en santé au cours de la période d'accueil provisoire d'urgence des personnes se déclarant comme mineures et privées de la protection de leur famille. Guide de bonnes pratiques. Paris: Ministère de la justice; 2023.
https://www.justice.gouv.fr/sites/default/files/2023-07/guide_premiere_evaluation_besoins_sante.pdf

38. Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux. L'accompagnement des mineurs non accompagnés dits "Mineurs isolés étrangers (MNA)". Saint-Denis La Plaine: HAS; 2018.
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2018-03/rbpp_mna_web.pdf

39. Institut national d'excellence en santé et services sociaux, Boisvert I, Moreault B, Brassard J. Dépistage des difficultés et retards liés au développement des enfants et des jeunes (0-18 ans) recevant des services en vertu de la loi sur la protection de la jeunesse (LPJ). Fiche synthèse. Québec: INESSS; 2020.
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/ServicesSociaux/Fiche-synthese_Depistage_developpement_0-18.pdf

40. Collège national de pédopsychiatrie de la Fédération française de psychiatrie, Bennevault B, Berdah S, Bridier F. Souffrances psychiques et troubles du développement chez l'enfant et l'adolescent. Paris: Ministère des Affaires sociales et de la Santé; 2013.
<https://eduscol.education.fr/document/1668/download?attachement>

41. Observatoire national du suicide. Suicide. Mesurer l'impact de la crise sanitaire liée au Covid-19. Effets contrastés au sein de la population et mal-être chez les jeunes. Paris: DREES; 2022.
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2022-10/ONS5_MAJ25-10.pdf

42. Haute Autorité de santé. Cadre national de référence : Évaluation globale de la situation des enfants en danger ou risque de danger. Livret 3 guide d'accompagnement à l'évaluation. Saint-Denis La Plaine: HAS; 2021.

43. Haute Autorité de santé. Accompagner la scolarité et contribuer à l'inclusion scolaire. Recommandation. Saint-Denis La Plaine: HAS; 2021.
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3288239/fr/accompagner-la-scolarite-et-contribuer-a-l-inclusion-scolaire-recommandation

44. Haute Autorité de santé. Enjeux et spécificités de la prise en charge des enfants et des adolescents en établissement de santé. Certification V2010. Saint-Denis La Plaine: HAS; 2011.

45. Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux. L'expression et la participation du mineur, de ses parents et du jeune majeur dans le champ de la protection de l'enfance. Saint-Denis La Plaine: HAS; 2010.
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2836142/fr/l-expression-et-la-participation-du-mineur-de-ses-parents-et-du-jeune-majeur-dans-le-champ-de-la-protection-de-l-enfance

46. Haute Autorité de santé. Améliorer la prise en charge à la sortie des dispositifs de protection de l'enfance :

l'accompagnement vers l'autonomie. Recommandation. Saint-Denis La Plaine: HAS; 2023.
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3492315/fr/ameliorer-la-prise-en-charge-a-la-sortie-des-dispositifs-de-protection-de-l-enfance-l-accompagnement-vers-l-autonomie-recommandation

47. Fiertag O, Taylor S, Tareen A, Garralda E. Troubles somatoformes. Dans: Rey JM, ed. Manuel de la IACAPAP pour la santé mentale de l'enfant et de l'adolescent. Geneva: IACAPAP; 2017.
<https://iacapap.org/Resources/Persistent/b0a3bd415119b7baf1106a1c91d28d9e2df03b69/I.1-Somatoform-dis-FRENCH-2017.pdf>

48. Direction générale de la Cohésion sociale, Martin-Blachais MP. Démarche de consensus sur les besoins fondamentaux de l'enfant en protection de l'enfance. Paris: Ministère des familles, de l'enfance et des droits des femmes; 2017.

49. Haute Autorité de santé. Interprétariat linguistique dans le domaine de la santé. Saint-Denis La Plaine: HAS; 2017.
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2801508/fr/interpretariat-dans-le-domaine-de-la-sante-referentiel-de-competences-formation-et-bonnes-pratiques

Participants

Les organismes professionnels et associations de patients et d'usagers suivants ont été sollicités pour proposer des experts conviés à titre individuel dans les groupes de travail/lecture¹²⁹ :

Assemblée des départements de France (ADF)*	Conférence nationale des présidents de CME de CH*
Association de directeurs, cadres de direction du secteur social, médico-social et sanitaire (ADC)	Conférence nationale des présidents de CME de CHS*
Association des établissements du service public de santé mentale (ADESM)*	Conférence nationale des présidents de CME-ESPIC
Association départementale pour la sauvegarde de l'enfant à l'adulte d'Eure-et-Loir (ADSEA 28)*	Collège de la médecine générale (CMG)*
Association des ITEP et de leurs réseaux (Aire)	Collège national pour la qualité des soins en psychiatrie (CNQSP)*
Association des psychiatres de secteur infanto-juvénile (API)*	Conseil national professionnel de médecine d'urgence*
Association nationale des assistants de service social (ANAS)*	Conseil national professionnel de pédiatrie*
Association nationale des directeurs d'action sociale et de santé des départements (ANDASS)*	Conseil national professionnel de psychiatrie*
Association nationale des directeurs enfance famille (ANDEF)*	Conseil national professionnel infirmier
ATD quart-monde	Convention nationale des associations de protection de l'enfant (CNAPE)*
Autisme France	Croix-Rouge française
Collectif des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux (CDO3S)	Direction générale de la Cohésion sociale (DGCS)
Comité d'étude des formations infirmières et des pratiques en psychiatrie (CEFI-PSY)*	Direction générale de l'enseignement scolaire (DGESCO)
Comité national de liaison des acteurs de la prévention spécialisée (CNLAPS)	Direction de la Protection judiciaire de la jeunesse (DPJJ)*
Conférence des directeurs généraux de CHRU	Fédération des CMPP (FDCMPP)*
Conférence des directeurs généraux de CH*	Fédération française de psychiatrie (FFP)*
Conférence nationale des présidents de CME de l'hospitalisation privée	Fédération française des psychologues et de psychologie (FFPP)*
Conférence nationale des présidents de CME de CHU	Fédération française Sésame autisme
	Fédération nationale des associations d'usagers en psychiatrie (FNAPSY)*
	Fédération nationale des associations d'entraide des personnes accueillies à la protection de l'enfance (FNADEPAPE)*

¹²⁹ Ont également été sollicités, en tant que membres du comité de concertation social et médico-social de la HAS : ADEDOM, APF France handicap, Association des directeurs au service des personnes âgées (AD-PA), Association nationale des directeurs et cadres des ESAT (ANDICAT), Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA), Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV), Caisse nationale de l'assurance maladie (CNAM), Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA), Cités Caritas, Conseil national des personnes accompagnées et accueillies (CNPA), Conseil national professionnel de gériatrie, délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement (DIHAL), FAGERH, Fédération addiction, Fédération des acteurs de la solidarité, Fédération française des associations de médecins coordonnateurs en EHPAD (FFAMCO), Fédération des aveugles de France, Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne (FEHAP), Fédération française des services à la personne et de proximité (FEDESAP), Fédération hospitalière de France (FHF), Fédération nationale avenir et qualité de vie des personnes âgées (FNAQPA), Fédération nationale des associations de directeurs d'établissements et services pour personnes âgées (FNADEPA), Fédération nationale des associations tutélaires (FNAT), France alzheimer, France horizon, Générations mouvement, Syndicat national des établissements et résidences privés pour les personnes âgées (SYNERPA), Trisomie 21 France, Union nationale de l'aide, des soins et des services aux domiciles (UNA), Union professionnelle du logement accompagné (UNAFLO), Unapei, Union nationale des centres communaux d'action sociale (UNCCAS), Union nationale pour l'habitat des jeunes (UNHAJ), Union pour la gestion des établissements des caisses de l'assurance maladie (UGEAM).

Fédération nationale des centres régionaux d'études, d'actions et d'informations, en faveur des personnes en situation de vulnérabilité (ANCREAI)

Fédération des organismes régionaux et territoriaux pour l'amélioration des pratiques en santé (FORAP)

France Terre d'Asile*

Groupement national des directeurs généraux d'association du secteur éducatif, social et médico-social (GNDA)

Groupe national des établissements publics sociaux et médico-sociaux (GEPISO)*

Groupe SOS

Nexem*

Observatoire national de la protection de l'enfance (ONPE)

Organisation nationale des éducateurs spécialisés (ONES)

REPAIRS 94*

Réseau des médecins référents protection de l'enfance*

Société française de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et disciplines associées (SFPEADA)*

Syndicat national des médecins de protection maternelle et infantile (SNMPMI)*

Union nationale aide à domicile en milieu rural (ADMR)

Union nationale des associations familiales (UNAF)*

Union nationale de familles et amis de personnes malades et/ou handicapées psychiques (UNAFAM)*

Union nationale aide à domicile en milieu rural (ADMR)*

Union nationale des associations de formation et de recherche en intervention sociale (Unaforis)

Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux (UNIOPSS)*

* Organismes ayant proposé une ou plusieurs personnes pour les groupes de travail/lecture dans le cadre de ce travail.

Équipe projet

Mme Amélie PRIGENT, cheffe de projet, services des bonnes pratiques, DAQSS, HAS

Mme Manon PRACA, cheffe de projet, service recommandations, DiQASM, HAS

Mme Nagette JOUSSE, assistante, service recommandations, DiQASM, HAS

Mme Manuela CHEVIOT, cheffe du service recommandation, DiQASM, HAS

Dr Pierre GABACH, adjoint à la directrice de la DAQSS, HAS

Dr Morgane LE BAIL, cheffe du service des bonnes pratiques, DAQSS, HAS

Mme Virginie HENRY, documentaliste, service documentation et veille, direction de la communication, de l'information et de l'engagement des usagers (DCIEU), HAS

Mme Laurence FRIGERE, assistante documentaliste, service documentation et veille, DCIEU, HAS

Dr Matthias BRUNN, psychiatre, docteur en sciences politiques, chargé de projet (participation à l'analyse de la littérature – partie « Freins et leviers à la coordination entre protection de l'enfance et pédopsychiatrie » du rapport d'élaboration) (jusqu'en mai 2024)

M. Nicolas CAMPELO, psychologue, docteur en psychologie, chargé de projet (participation à la sélection des

références bibliographiques et à l'analyse de la littérature – partie « Modalités et dispositifs de coordination entre protection de l'enfance et psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent ») (jusqu'en septembre 2023)

Mme Amélie TURLAIS, chercheuse, docteur en sciences de l'éducation, chargée de projet (participation à la sélection des références bibliographiques) (jusqu'en mars 2022)

M. Christophe MORICARD, chargé d'études, service évaluation, DiQASM, HAS (participation à l'exploitation des données de l'appel à contributions)

Mme Emmanuelle HOARAU, sociologue, docteur en sociologie, chargée de projet (participation à l'exploitation des données de l'appel à contributions) (jusqu'en octobre 2022)

Mme Floriane GASTO, adjointe au chef de service, service juridique, secrétariat général, HAS

Mme Clara PROUST, juriste, service juridique, secrétariat général, HAS

M. Maxence LYONNET, chef du service juridique, secrétariat général, HAS

Mme Valérie COMBE, assistante de communication, service communication et information, DCIEU, HAS

Groupe de travail

Dr Nathalie BATARDIERE, psychiatre de l'enfant et de l'adolescent (49) (jusqu'au 4 octobre 2023)

Dr Patrick BELAMICH, psychiatre (75)

Mme Valérie BENEAT-MARLIER, directrice d'hôpital (17)

Mme Patricia BETTING, psychologue en équipe de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent (57)

Mme Alexandra BICHON, usagère du système de santé, social ou médico-social (44) (jusqu'au 3 décembre 2022)

Dr Sylvie BOIVIN, psychiatre de l'enfant et de l'adolescent, vice-présidente de CME (29)

Dr Cécile BONNEFOY, psychiatre de l'enfant et de l'adolescent, responsable de mission santé mentale et psychiatrie au sein d'une ARS (76)

Dr Françoise BONNIN, médecin de PMI puis médecin au sein des services de l'ASE d'une collectivité territoriale (75)

Pr Michel BOTBOL, psychiatre de l'enfant et de l'adolescent, co-président du groupe de travail (75)

Pr Guillaume BRONSARD, psychiatre de l'enfant et de l'adolescent (29)

Mme Cécile BRUNE, psychologue ASE au sein d'un conseil départemental (56)

Dr Anne CHARTIER, médecin référente protection de l'enfance au sein d'un conseil départemental (35)

Mme Nadège COILLIER, cheffe de bureau aide sociale à l'enfance au sein d'un conseil départemental (79) (jusqu'au 10 janvier 2023)

Mme Éliane CORBET, psychopédagogue, ancienne directrice déléguée CREA Rhône-Alpes, co-présidente du groupe de travail (69)

Mme Gisèle DELCAMBRE, juge des enfants (59) (jusqu'au 7 mars 2023)

M. Mamédi DIARRA, usager du système de santé, social ou médico-social (94)

M. Jean-Michel DONIZEAU, référent ASE au sein d'un conseil départemental, chargé de protection de l'enfance au sein d'une autre collectivité territoriale puis éducateur spécialisé en équipe de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent (79)

Dr Yvon DUBOIS, psychiatre de l'enfant et de l'adolescent (13)

M. Franck DUCOROY, usager du système de santé, social ou médico-social (66)

M. Éric GHOZLAN, psychologue et directeur du pôle enfance puis directeur général d'une association gérant des établissements et services intervenant dans le champ de la protection de l'enfance (75)

Auditions

Pr Raoul BELZEAUX, professeur des universités-praticien hospitalier au CHU et à l'université de Montpellier (34)

Dr Marie-Hélène CERTAIN, médecin généraliste en libéral (78)

Groupe de lecture

Mme Geneviève AVENARD, ancienne Défenseuse des enfants (21)

Mme Angélique BABAHAN, cadre de santé en équipe de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent (13)

Pr Martine BALENCON, pédiatre, médecin légiste (14)

Dr Marion BAILHACHE, pédiatre aux urgences pédiatriques et dans une UAPED (33)

Mme Claire HANGOUET, éducatrice spécialisée en centre départemental de l'enfance et de la famille (33)

Mme Hélène JAUNATRE, responsable technique et éducatif ASE au sein d'un conseil départemental (85)

Mme Bernadette JOLLY, assistante de service social en CMPP (20)

Mme Bérengère LEFEVRE, infirmière (35) (jusqu'au 5 mars 2024)

Dr Roxane LIARD, médecin généraliste (75) (jusqu'au 19 décembre 2022)

Mme Anne-Véronique LOSHOUARN, éducatrice spécialisée en STEM (PJJ) (29)

Mme Séverine MAILLE, psychologue en UEMO (PJJ) (34)

Mme Julie MONI, cheffe de service éducatif en DT PJJ (06) (jusqu'au 3 mars 2023)

Dr Marcela MONTES DE OCA, psychiatre de l'enfant et de l'adolescent (75)

M. François PACAUD, psychologue en équipe de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent puis en CLSM (59)

Mme Élise PERRIER, éducatrice spécialisée coordinatrice en MECS (33)

M. Stanislas PUROL, directeur d'établissements et services intervenant dans le champ de la protection de l'enfance (14)

Mme Chantal ROUSSY, usagère du système de santé, social ou médico-social (75)

Mme Mélanie SANCHEZ, directrice d'un centre départemental de l'enfance et de la famille puis directrice adjointe d'un établissement public de santé mentale (97)

Mme Catherine TOURROLIER, directrice d'une maison d'enfants à caractère social (12)

Mme Aurore TREPP, responsable d'une UEHC (PJJ) (31)

Dr Pascale VURPILLAT, pédiatre, en exercice libéral, hospitalier et en structures médico-sociales (25)

Dr Michel DUGNAT, praticien hospitalier, responsable de l'unité de soins conjoints de l'AP-HM et praticien attaché à l'unité de soins conjoints du CH Montfavet à Avignon (84)

Jérôme BEAURY, usager du système de santé, social ou médico-social (14)

Dr Maurice BENSOUSSAN, psychiatre libéral (31)

Dr Carole BERKENBAUM, médecin généraliste au sein d'un centre départemental de l'enfance et de la famille (33)

Dr Corinne BOIS, médecin conseiller technique petite enfance au sein d'un conseil départemental (92)

- Mme Corinne BORY, éducatrice spécialisée dans un service de milieu ouvert (42)
- Dr Lucie BOSMEAN, médecin généraliste (38)
- M. Jean-Pierre BURNICHON, sociologue, cadre de santé (69)
- Dr Jean CHAMBRY, psychiatre de l'enfant et de l'adolescent (75)
- Dr Catherine CHOLLET-FOUKS, pédopsychiatre (31)
- Mme Elsa DARCHY, infirmière en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent (59)
- Mme Adeline DASNIAS, directrice appui et qualité au sein d'une association intervenant dans le champ de la protection de l'enfance (26)
- Mme Angelina DAVET, psychologue au sein d'un service de placement familial (28)
- Mme Hélène DAVTIAN-VALCKE, psychologue clinicienne chargée d'un projet jeunes, proches et parentalité en psychiatrie (75)
- Mme Émilie DERCHE, cheffe de service éducatif en maison d'accueil pour mineurs non accompagnés (80)
- Mme Céline DESCAMPS, cheffe de projet PTSM (69)
- Mme Dominique DUBOIS, juriste, conseillère technique en CREA (21)
- Mme Laurine GUERIN, infirmière puéricultrice en PMI (42)
- Mme Pauline GUEZENNEC, coordinatrice PTSM (anciennement conseillère technique santé au sein d'une DIR PJJ) (29)
- Dr Didier HONNART, anesthésiste-réanimateur urgentiste (77)
- Mme Martine ISOREZ, infirmière au sein d'une DT PJJ (80/02)
- Dr Stéphanie JAMIER, médecin conseillère technique auprès du directeur académique, Éducation nationale (35)
- Mme Sandrine JANUARIO, psychologue en STEMO et UEMO (PJJ) (13)
- Mme Émilie JARJAT, éducatrice en UEMO (42)
- Mme Typhaine JEHANNE, cadre éducatif ASE au sein d'un conseil départemental (44)
- Dr Anna KONRAD, psychiatre (93)
- M. Patrick LAROSE, directeur d'un dispositif intervenant dans le champ de la protection de l'enfance (75)
- Dr Christine LEQUETTE, médecin de l'Éducation nationale retraitée (38)
- Mme Sophie LESINEAU, magistrate (33)
- Mme Pascale LOUVENAZ, assistante de service social en équipe de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent (01)
- Dr Anne Nathalie MARGUERON, médecin référente protection de l'enfance au sein d'un conseil départemental (56)
- Dr Isabelle MARTINIE-DUCLOUP, collaboratrice ARS (Nouvelle-Aquitaine)
- Dr Véronique MASSIN, médecin de l'Éducation nationale (75)
- Dr Corinne MAYER, pédiatre retraitée (anciennement médecin de PMI) (33)
- Mme Sylvie MOAL, éducatrice spécialisée en équipe de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent (29)
- Mme Amélia NETO, assistante de service social en équipe de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent (93)
- Mme Marie PARNEIX, psychologue au sein d'un service intervenant dans le champ de la protection de l'enfance (91)
- Dr Émeline PASDELOUP, médecin généraliste (45)
- Dr Georges PICHEROT, pédiatre retraité (44)
- Mme Émilie PONCHEL, assistante de service social en équipe de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent (73)
- Pr Diane PURPER-OUAKIL, psychiatre de l'enfant et de l'adolescent (34)
- Dr Claire PUYBARET-BATAILLE, pédopsychiatre retraitée (75)
- Mme Sylvie QUELET, collaboratrice ARS (Nouvelle-Aquitaine)
- Dr Clémentine RAPPAPORT, pédopsychiatre (93)
- Dr Gérard ROBIN, pédopsychiatre retraité (75)
- Dr Daniel ROUSSEAU, psychiatre de l'enfant et de l'adolescent libéral, en service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et au sein d'un foyer départemental de l'enfance (49)
- Dr Lori SAVIGNAC-KRIKORIAN, médecin généraliste (31)
- Dr Yannick SCHMITT, médecin généraliste (67)
- Dr Louis SCIARA, psychiatre (75)
- Dr Claire SCHVOERER, médecin inspecteur de santé publique, conseiller médical référent régional handicap en ARS (33)
- Dr Louis TANDONNET, pédopsychiatre (47)
- Pr Sylvie TORDJMAN, pédopsychiatre (35/75)
- Mme Emmanuelle TOUSSAINT, psychologue en équipe de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent (44)
- Mme Lysiane URBAN, cadre enfance et parentalité au sein d'une association de services à la personne intervenant dans le champ de la protection de l'enfance (73)
- Dr Nathalie VABRES, praticienne hospitalière, pédiatre coordinatrice, unité d'accueil pédiatrique des enfants en danger (UAPED), hôpital mère-enfant, service de pédiatrie (44)
- M. Noël VANDERSTOCK, directeur adjoint d'un établissement de santé (29)
- Dr Évelyne WANNEPAIN, médecin de PMI, retraitée (93)
- Mme Stéphane XAVIER-GRELET, directrice d'un EPEI (PJJ) (95)

Parties prenantes et institutionnels sollicités à la phase de lecture¹³⁰

Assemblée des départements de France (ADF)	Conférence nationale des présidents de CME-ESPIC
Association de directeurs, cadres de direction du secteur social, médico-social et sanitaire (ADC)*	Conseil national de la protection de l'enfance (CNPE)
Association départementale pour la sauvegarde de l'enfant à l'adulte d'Eure-et-Loir (ADSEA 28)*	Conseil national professionnel de pédiatrie*
Association des établissements du service public de santé mentale (ADESM)*	Convention nationale des associations de protection de l'enfant (CNAPE)*
Association des ITEP et de leurs réseaux (Aire)*	Croix-Rouge française*
Association nationale des directeurs d'action sociale et de santé des départements (ANDASS)	Défenseur des droits
Association nationale des directeurs de l'enfance et de la famille (ANDEF)	Direction générale de la Cohésion sociale (DGCS)*
Association nationale des placements familiaux (ANPF)	Direction générale de l'enseignement scolaire (DGESCO)
Association nationale des responsables qualité en psychiatrie (ANRQPSY)*	Direction de la Protection judiciaire de la jeunesse (DPJJ)*
ATD quart-monde	Direction générale de la Santé (DGS)
Autisme France	Direction générale de l'Organisation des soins (DGOS)*
Carrefour national de l'action éducative en milieu ouvert (CNAEMO)	Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne (FEHAP)*
Collectif des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux (CDO3S)	Fédération française de psychiatrie (FFP)
Collège de la médecine générale (CMG)*	Fédération française Sésame Autisme
Collège national pour la qualité des soins en psychiatrie (CNQSP)	Fédération hospitalière de France (FHF)
Collège national des universitaires de psychiatrie (CNUP)*	Fédération de l'hospitalisation privée (FHP)
Comité d'étude des formations infirmières et des pratiques en psychiatrie (CEFI-PSY)	Fédération nationale des associations d'entraide des personnes accueillies à la protection de l'enfance (FNADEPAPE)*
Comité national de liaison des acteurs de la prévention spécialisée (CNLAPS)*	Fédération nationale des associations d'usagers en psychiatrie (FNAPSY)
Conférence nationale des présidents de CME de l'hospitalisation privée	Fédération nationale des centres régionaux d'études, d'actions et d'informations, en faveur des personnes en situation de vulnérabilité (ANCREAI)*
Conférence nationale des présidents de CME de CHU	Fédération des organismes régionaux et territoriaux pour l'amélioration des pratiques en santé (FORAP)
Conférence nationale des présidents de CME de CH	France Terre d'Asile
Conférence nationale des présidents de CME de CHS*	Groupe national des directeurs généraux d'association du secteur éducatif, social et médico-social (GNDA)
	Groupe national des établissements publics sociaux et médico-sociaux (GEPSO)*
	Groupe SOS

130 Ont également été sollicités, en tant que membres du comité de concertation social et médico-social de la HAS : ADEDOM, APF France handicap, Association des directeurs au service des personnes âgées (AD-PA), Association nationale des directeurs et cadres des ESAT (ANDICAT), Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA), Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV), Caisse nationale de l'assurance maladie (CNAM), Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA), Cités Caritas, Conseil national des personnes accompagnées et accueillies (CNPA), Conseil national professionnel de gériatrie, délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement (DHAL), FAGERH, Fédération addiction, Fédération des acteurs de la solidarité, Fédération des aveugles de France, Fédération française des associations de médecins coordonnateurs en EHPAD (FFAMCO), Fédération française des services à la personne et de proximité (FEDESAP), Fédération nationale avenir et qualité de vie des personnes âgées (FNAQPA), Fédération nationale des associations de directeurs d'établissements et services pour personnes âgées (FNADEPA), Fédération nationale des associations tutélaires (FNAT), France alzheimer, France horizon, Générations mouvement, Syndicat national des établissements et résidences privés pour les personnes âgées (SYNERPA), Trisomie 21 France, Union nationale de l'aide, des soins et des services aux domiciles (UNA), Union professionnelle du logement accompagné (UNAF), Unapei, Union nationale des centres communaux d'action sociale (UNCCAS), Union nationale pour l'habitat des jeunes (UNHAJ), Union pour la gestion des établissements des caisses de l'assurance maladie (UGECAM).

Nexem*

Observatoire national de la protection de l'enfance (ONPE)*

Syndicat national des psychologues (SNP)*

Union nationale aide à domicile en milieu rural (ADMR)*

Union nationale de familles et amis de personnes malades et/ou handicapées psychiques (UNAFAM)*

Union nationale des associations de formation et de recherche en intervention sociale (Unaforis)*

Union nationale des associations familiales (UNAF)

Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux (UNIO PSS)

* Organisme ayant fait parvenir un avis dans le cadre de la phase de lecture de ce travail.

Remerciements

La HAS tient à remercier l'ensemble des participants cités ci-dessus.

Elle remercie également pour leur contribution aux travaux : Florence BECLIER (direction des Affaires civiles et des Grâces du ministère de la Justice), Marie DE CORDOUE (Conseil national de l'ordre des médecins), Méhidine FAROUDJ (direction de la Protection judiciaire de la jeunesse du ministère de la Justice), Émile GABRIE (direction des Affaires juridiques des ministères sociaux), Dr Marie-Pierre GLAVIANO-CECCALDI (Conseil national de l'ordre des médecins), Cécile GRESSIER (direction des Affaires civiles et des Grâces du ministère de la Justice), Caroline HERON (Conseil national de l'ordre des médecins), Flavie LE TALLEC (direction des Affaires civiles et du Sceau du ministère de la Justice), Pearl NGUYEN-DUY (direction des Affaires juridiques des ministères sociaux), Caroline NISAND (direction de la Protection judiciaire de la jeunesse du ministère de la Justice), Pr Stéphane OUSTRIC (Conseil national de l'ordre des médecins), Laureline PEYREFITTE (direction des Affaires civiles et des Grâces du ministère de la Justice), Catherine RAYNOUARD (direction des Affaires civiles et du Sceau du ministère de la Justice), Mélodie SIMON (direction des Affaires juridiques des ministères sociaux), Dr Anne-Marie TRARIEUX (Conseil national de l'ordre des médecins).

Abréviations et acronymes

AEMO	Action éducative en milieu ouvert
ANAP	Agence nationale de la performance sanitaire et médico-sociale
ANESM	Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux
ARS	Agence régionale de santé
ASE	Aide sociale à l'enfance
CLS	Conseil local de santé
CLSM	Conseil local de santé mentale
CMP	Centre médico-psychologique
CMPP	Centre médico-psycho-pédagogique
CNOM	Conseil national de l'ordre des médecins
CPOM	Contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens
CPTS	Communauté professionnelle territoriale de santé
DAC	Dispositif d'appui à la coordination
DGCS	Direction générale de la Cohésion sociale
DGS	Direction générale de la Santé
DROM	Départements et régions d'outre-mer
FALC	Facile à lire et à comprendre
HAS	Haute Autorité de santé
IGAS	Inspection générale des affaires sociales
MDA	Maison des adolescents
MDPH	Maison départementale des personnes handicapées
MEJP	Mesure éducative judiciaire provisoire
MNA	Mineur non accompagné
ODPE	Observatoire départemental de la protection de l'enfance
ONPE	Observatoire national de la protection de l'enfance
PCO	Plateforme de coordination et d'orientation
PJJ	Protection judiciaire de la jeunesse
PMI	Protection maternelle et infantile
PPE	Projet pour l'enfant
PRS	Projet régional de santé
PTSM	Projet territorial de santé mentale
SDRE	Soins sur décision du représentant de l'État
UAPED	Unité d'accueil pédiatrique enfants en danger

Retrouvez tous nos travaux sur
www.has-sante.fr

